

Buku Referensi
**EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI
UNTUK REMAJA**

Gusmadewi • Indayana Setiawati • Marchatus Soleha
Anin Wijayanti • Ana Lestari
Meining Issuryanti

Editor : Amrina nur rohmah

BUKU REFERENSI EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK REMAJA

Gusmadewi, AMd. Keb.SKM. M.Kes
Indayana Setiawati, S.ST.,M.Kes
Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes
Anin Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kes
Ana Lestari, S.ST., M.Kes
Ns.Meining Issuryanti,S.Kep.,M.Kep

Editor : Amrina nur rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb



BUKU REFERENSI

EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK REMAJA

Penulis: Gusmadewi, AMd. Keb.SKM. M.Kes

Indayana Setiawati, S.ST.,M.Kes

Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes

Anin Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kes

Ana Lestari, S.ST., M.Kes

Ns.Meining Issuryanti,S.Kep.,M.Kep

Editor : Amrina nur rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN : 978-623-10-9551-0

Cetakan Pertama : Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi ini yang berjudul **Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respon atas kebutuhan mendesak akan literasi kesehatan reproduksi yang akurat, komprehensif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya bagi kalangan remaja.

Remaja merupakan kelompok usia yang tengah mengalami transisi fisik, psikologis, dan sosial yang kompleks. Dalam masa ini, pengetahuan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi menjadi sangat penting untuk membentuk sikap, perilaku, dan keputusan yang bertanggung jawab. Sayangnya, masih banyak remaja yang belum mendapatkan informasi yang benar, terbuka, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun media.

Buku ini disusun untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Di dalamnya termuat berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari pentingnya edukasi sejak dini, peran keluarga dan sekolah, hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pendidikan yang inovatif.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi maupun pendekatan, untuk itu kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan edisi berikutnya. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pendidik, tenaga kesehatan, orang tua, dan semua pihak yang peduli terhadap perkembangan remaja yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas edukasi kesehatan reproduksi di Indonesia.

(Mei, 2025)

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENTINGNYA EDUKASI REPRODUKSI SEJAK DINI	1
A. Pendahuluan	1
B. Perubahan Seks Primer dan Seks Sekunder Remaja Putri	1
C. Perubahan Seks Primer dan Seks Sekunder Remaja Laki-laki	2
D. Seks Pra Nikah	2
E. Kebersihan Diri Pada Organ Reproduksi	2
F. Menstruasi.....	3
G. Konsep Kesehatan Reproduksi.....	3
H. Penutup.....	3
Referensi	4
BAB II PERAN KELUARGA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN REPRODUKSI.....	5
A. Konsep Dasar Pendidikan Reproduksi.....	5
B. Pentingnya Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Dan Remaja.....	5
C. Komponen-Komponen Pendidikan Reproduksi.....	6
D. Perspektif Sosial Dan Budaya Dalam Pendidikan Reproduksi.....	6
E. Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Utama	7
F. Pendekatan Dan Strategi Pendidikan Reproduksi Di Keluarga.....	9
G. Komunikasi Terbuka Dan Efektif Dalam Keluarga Terkait Pendidikan	10
H. Nilai-Nilai Keluarga Dalam Pendidikan Reproduksi	12
I. Dampak Pendidikan Reproduksi Dalam Keluarga	14
J. Kolaborasi Keluarga Dengan Lingkungan Eksternal Dalam Pendidikan Reproduksi.....	17
K. Penutup.....	19
Referensi	20
BAB III PENGARUH POLA ASUH TERHADAP PERILAKU REMAJA	22
A. Pendahuluan	22
B. Definisi Pola Asuh.....	23
C. Jenis-jenis pola Asuh.....	24
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh.....	26
E. Pengertian Remaja.....	27
F. Tahap Perkembangan Remaja.....	28
G. Kenakalan Remaja.....	29
H. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja	31
I. Penyebab Kenakalan Remaja.....	33
J. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja	33
K. Penutup.....	34
Referensi	36
BAB IV MENCEGAH PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL REMAJA AWAL DENGAN BIMBINGAN KELOMPOK TENTANG PENDIDIKAN SEKS ISLAMI DI SEKOLAH	37
A. Pendahuluan	37
B. Masalah Perilaku Penyimpangan Seksual Remaja Awal	39
C. Urgensi dan Manfaat Pendidikan Seks Islami bagi Remaja Awal	45
D. Kelebihan Bimbingan Kelompok untuk Mengedukasi Remaja Awal	48

E. Bimbingan Kelompok tentang Pendidikan Seks Islami di Sekolah sebagai Strategi Mencegah Perilaku Penyimpangan Seksual Remaja Awal.....	50
F. Penutup.....	52
Referensi	53
BAB V EDUKASI TENTANG PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN ORGAN REPRODUKSI REMAJA	60
A. Pendahuluan	60
B. Pengenalan tentang Kesehatan Reproduksi	61
C. Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi Sejak Usia Dini	62
D. Kesehatan Reproduksi Wanita Saat Menstruasi	63
E. Pentingnya Pendidikan Seksual dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi.....	64
F. Peran Dukungan Sosial dalam Kesehatan Reproduksi.....	65
G. Mempersiapkan Kesehatan Reproduksi untuk Kehamilan yang Sehat	66
H. Penutup.....	67
Referensi	68
BAB VI PENDEKATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI	72
A. Pendahuluan	72
B. Remaja.....	73
C. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja	77
D. Teknologi Digital	83
E. Pendekatan Teknologi Digital dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	88
F. Penutup.....	93
Referensi	95
Profil Penulis	98
Sinopsis Buku	101

BAB I

PENTINGNYA EDUKASI REPRODUKSI SEJAK DINI

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi masih menjadi hal yang tabu di kalangan remaja baik laki-laki maupun Perempuan di Indonesia. Usia remaja adalah masa dimana mereka senang mencoba hal baru termasuk kaitannya dengan reproduksi. Oleh karena itu, edukasi perlu disosialisasikan kepada remaja. Edukasi ini bisa melalui orang tua, guru maupun tenaga Kesehatan.

Pemerintah menerbitkan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotive dan preventif untuk mencegah Masyarakat sakit. Layanan ini mencakup Kesehatan reproduksi untuk remaja dimana pemerintah menggalakkan pemberian komunikasi, edukasi, dan pelayanan Kesehatan reproduksi. Program ini mencakup edukasi mengenai system, fungsi dan proses reproduksi, menjaga Kesehatan reproduksi, perilaku beresiko dan dampaknya, serta keluarga berencana dan kemampuan melindungi diri dan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan.

Pada target 3.7 dalam *sustainable development goals* (SDG's) dalam bidang Kesehatan reproduksi bertujuan untuk memastikan akses universal terhadap layanan Kesehatan seksual dan reproduksi pada tahun 2030. Pentingnya edukasi reproduksi sejak dini sangat diperlukan agar pengetahuan laki-laki maupun Perempuan semakin meningkat. Pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi dapat diperoleh melalui Pendidikan Kesehatan, penyuluhan, pengalaman, membaca materi tentang Kesehatan reproduksi melalui media cetak maupun media elektronik, Pendidikan formal maupun nonformal seperti dari keluarga (Elfi dkk, 2021)

B. Perubahan Seks Primer dan Seks Sekunder Remaja Putri

Bagi seorang remaja putri, masa peralihan dari masa anak-anak ke masa pubertas merupakan masa yang penting untuk mendapatkan edukasi yang tepat. Pada masa pubertas, sistem reproduksi seorang perempuan mengalami kematangan yang disertai dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara primer maupun sekunder. Tanda seks primer ini ada kaitannya dengan organ seks yaitu menstruasi.

Menarche merupakan menstruasi yang pertama kali pada seorang perempuan yang rata-rata terjadi pada sekitar usia 11- 14 tahun. Keluarga merupakan salah satu elemen terkecil masyarakat (Vina & Elvin 2021).

Perubahan seks sekunder pada remaja putri saat masa pubertas yaitu payudara mulai terbentuk dan membesar, menstruasi, kulit berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, tumbuh rambut disekitar kemaluan, dan pinggul membesar.

C. Perubahan Seks Primer dan Seks Sekunder Remaja Laki-laki

Perubahan yang terjadi pada masa pubertas remaja ini berlangsung secara bertahap. Ada yang perubahannya cepat dan ada juga yang mengalami perubahan dalam jangka waktu beberapa tahun bahkan bisa jadi perubahannya mengalami kelambatan (Vina dan Elvin, 2021).

Remaja laki-laki mengalami perubahan seks primer jika sudah mengalami yang namanya mimpi basah (*spermarche*). Rata-rata remaja laki-laki mengalami mimpi basah pada usia 14 tahun (Rahayu, Herwinda, Hindarta, Nadhea, 2023)

Perubahan organ seksual pada masa ini ditandai adanya perubahan primer dan perubahan seks secara sekunder. Pada remaja laki-laki terjadi perubahan suara, tumbuhnya jakun, penis dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, tubuh lebih berotot, tumbuhnya kumis dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, suara membesar, pertumbuhan tinggi badan yang pesat, keringat bertambah banyak.

D. Seks Pra Nikah

Usia remaja sering kali melakukan hal-hal yang membuat rasa penasaran akan hal yang baru. Salah satu rasa penasaran pada masa pubertas adalah melakukan seks pra nikah.

Banyak dampak atau resiko yang diperoleh dari melakukan seks pra nikah bagi remaja yaitu adanya penularan seksual terutama HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku seks pra nikah diantaranya kurangnya pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, akses atau penggunaan alat kontrasepsi yang buruk, penggunaan media sosial dan gaya pacaran pada anak remaja.

E. Kebersihan Diri Pada Organ Reproduksi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga Kesehatan organ reproduksi perempuan adalah sebagai berikut (Vina dan Elvin 2021):

1. Membersihkan vagina setiap hari.

Cara membasuh vagina yang benar yaitu dari arah depan menuju ke belakang dengan air bersih secara perlahan setiap kali selesai buang air kecil, buang air besar ataupun pada saat mandi.

2. Sering mengganti pakaian dalam setiap hari.

Pakaian dalam yang tepat untuk digunakan adalah pakaian dalam yang berbahan katun. Pakaian dalam sering diganti dalam setiap lembab atau minimal dua kali dalam sehari yaitu pagi dan sore hari setelah mandi.

3. Ganti pembalut sesering mungkin saat menstruasi.
Menggunakan pembalut dari bahan yang aman dan menggantinya minimal empat sampai lima kali dalam sehari.
4. Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah menyentuh alat kelamin.
5. Keringkan organ intim dengan tisu kering atau handuk kering khusus (dipakai setiap kali setelah buang air kecil)
6. Mencukur Sebagian rambut kemaluan agar terhindar dari kelembaban.
Rambut kemaluan yang terlalu lebat dan lembab memudahkan mikroorganisme bersarang sehingga menimbulkan resiko infeksi.
7. Hindari pemakaian cairan atau sabun pembersih vagina secara terus menerus (hal ini bisa dilakukan jika ada anjuran dari dokter)

F. Menstruasi

Menstruasi yaitu keluarnya darah dari kemaluan akibat dari meluruhnya lapisan endometrium di dalam uterus. Menstruasi merupakan indikator terjadinya kematangan seksual pada remaja putri. Menstruasi merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam kebersihan diri. Hal yang harus diperhatikan selama menstruasi yaitu seringnya mengganti pembalut dan celana dalam. Hal ini dilakukan agar terhindar dari gangguan reproduksi baik alat atau organ reproduksi maupun fungsinya (Wahyuni dkk, 2022)

G. Konsep Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera baik fisik, mental dan sosial yang utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan) dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja menurut BKKBN adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan namun juga sehat secara fisik, mental dan social (Kemenkes, 2017)

H. Penutup

Pemberian edukasi reproduksi sejak dini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi remaja laki-laki maupun Perempuan. Pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi diberikan sejak remaja agar bisa mengenali kelainan pada Kesehatan reproduksinya sedini mungkin terutama tentang menstruasi pada remaja putri dan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh remaja secara umum.

Referensi

- Galbinur, E., Defitra, M. A., & Venny. (2021). Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. *Prosiding SEMNAS BIO*, 221–228. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/pentingnya-pengetahuan-kesehatan-reproduksibagi-remaja.html>
- Gunawan, S., & Tadjudin, N. S. (2022). Edukasi Seks dan Kesehatan Reproduksi Remaja pada Siswa/Siswi SMP Tarakanita 2 Jakarta. *Serina Iv Untar 2022*, 1341–1346.
- Hapsari, A. (2019). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Modul Kesehatan Reproduksi Remaja. In *Katalog Dalam Terbitan*. Wineka Media. http://eprints.undip.ac.id/38840/1/KESEHATAN_MENTAL.pdf
- Kuswati, & Handayani, R. (2016). Gambaran Kesiapan Remaja Dalam Menghadapi Menarche Di Sdit Aisyiyah Full Day Pandes Wedi Klaten. *Jurnal Kebidanan*, 8(01), 37–47. <https://doi.org/10.35872/jurkeb.v8i01.198>
- Mulyanti, Y., Ningsih, R., Nurhalimah. (2023) Kesehatan Reproduksi Remaja Sampai Lanjut Usia. NTB. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Rahayu, Herwinda, Hindarta, N. (2023). *Gizi dan Kesehatan Remaja*. Banyumas. Zahira Media Publisher.
- Wahyunita, V. D. (n.d.). (2021) *Menarche dan Perubahan Seks Sekunder.pdf*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. <https://doi.org/ISBN 978-623-6730-86-7>
- Widiawati, S., & Selvi, S. (2022). Edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.30644/jphi.v4i1.631>

BAB II

PERAN KELUARGA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN REPRODUKSI

A. Konsep Dasar Pendidikan Reproduksi

1. Pengertian

Pendidikan reproduksi adalah proses pemberian informasi yang komprehensif mengenai anatomi, fisiologi, dan fungsi sistem reproduksi, serta aspek sosial, emosional, dan etika yang terkait. Pendidikan ini bertujuan untuk membantu individu memahami tubuh mereka, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan mengembangkan sikap yang sehat terhadap seksualitas.

2. Beberapa definisi dari berbagai organisasi:

- a. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia): Pendidikan reproduksi adalah upaya sistematis untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial.
- b. UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB): Pendidikan reproduksi mencakup pemahaman tentang pertumbuhan tubuh, hubungan sosial, nilai-nilai moral, serta keterampilan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi.

B. Pentingnya Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Dan Remaja

Pendidikan reproduksi sangat penting bagi anak dan remaja karena:

Membantu Memahami Perubahan Fisik dan Emosional

Memfasilitasi pemahaman tentang pubertas dan perubahan hormonal. Mengurangi kebingungan dan kecemasan terkait perkembangan seksual.

1) Mencegah Misinformasi dan Mitos Seputar Seksualitas.

- a. Mengatasi mitos dan informasi yang keliru dari lingkungan sekitar atau media.
- b. Membangun pemahaman yang ilmiah dan berbasis fakta.

2) Meningkatkan Kesadaran tentang Kesehatan Reproduksi

- a. Mengenalkan pentingnya kebersihan dan kesehatan organ reproduksi.
- b. Mencegah penyakit menular seksual dan infeksi reproduksi.

- 3) Mendorong Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab
 - a. Mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam hubungan sosial.
 - b. Membantu remaja memahami konsekuensi dari aktivitas seksual yang tidak aman.
- 4) Mencegah Kehamilan Tidak Direncanakan dan Risiko Seksual Lainnya
 - a. Memberikan pemahaman tentang kontrasepsi dan metode pencegahan lainnya.
 - b. Mengurangi angka pernikahan dini dan kehamilan remaja.

C. Komponen-Komponen Pendidikan Reproduksi

Pendidikan reproduksi yang komprehensif mencakup beberapa aspek berikut:

1. Aspek Biologis
 - a. Struktur dan fungsi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan.
 - b. Siklus menstruasi dan ovulasi.
 - c. Perubahan hormon selama masa pubertas.
2. Aspek Psikologis
 - a. Perubahan emosional selama masa pubertas dan remaja.
 - b. Konsep identitas diri dan penerimaan diri.
 - c. Hubungan antara perkembangan psikologis dan kesehatan reproduksi.
3. Aspek Sosial dan Budaya
 - a. Nilai-nilai keluarga dan norma sosial terkait seksualitas.
 - b. Pengaruh media dan pergaulan dalam membentuk pola pikir remaja tentang seksualitas.
 - c. Stigma dan tabu seputar pendidikan reproduksi di masyarakat.
4. Aspek Moral dan Etika
 - a. Tanggung jawab dalam hubungan sosial dan seksual.
 - b. Nilai-nilai agama dan budaya dalam menjaga kesucian diri.
 - c. Hak dan kewajiban dalam kesehatan reproduksi.
5. Aspek Kesehatan dan Keselamatan
 - a. Pencegahan penyakit menular seksual.
 - b. Pentingnya menjaga kebersihan organ reproduksi.
 - c. Konsep batasan diri (consent) dalam interaksi sosial dan seksual.

D. Perspektif Sosial Dan Budaya Dalam Pendidikan Reproduksi

Pendidikan reproduksi tidak terlepas dari pengaruh sosial dan budaya di masyarakat. Beberapa perspektif yang perlu dipahami:

1. Peran Agama dalam Pendidikan Reproduksi

- a. Sebagian masyarakat menganggap pendidikan reproduksi harus selaras dengan nilai-nilai agama.
- b. Pemahaman tentang kesucian, pernikahan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan seksual.
- 2. Pandangan Tradisional vs. Modern
 - a. Pandangan konservatif sering menganggap pembahasan seksualitas sebagai hal yang tabu.
 - b. Pendekatan modern menekankan pentingnya edukasi sejak dini untuk pencegahan risiko.
- 3. Pengaruh Media dan Teknologi
 - a. Akses informasi yang luas melalui internet dapat menjadi peluang dan tantangan.
 - b. Peran keluarga dalam menyaring dan mendampingi anak dalam memahami informasi yang benar.
- 4. Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Reproduksi
 - a. Regulasi tentang pendidikan seks di sekolah dan dalam lingkungan keluarga.
 - b. Program kesehatan reproduksi yang didukung oleh pemerintah dan organisasi sosial.

E. Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Utama

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan reproduksi kepada anak. Sebagai pendidik utama, mereka tidak hanya menjadi sumber informasi pertama tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan pemahaman anak mengenai kesehatan reproduksi.

Berikut beberapa aspek utama dalam peran orang tua:

- 1. Memulai Pendidikan Reproduksi Sejak Dini

Pendidikan reproduksi bukan hanya tentang seks, tetapi juga mencakup pemahaman tentang tubuh, kesehatan, dan hubungan sosial yang sehat. Orang tua harus mulai mengajarkan konsep ini sesuai dengan usia anak:

 - a. Usia 3-5 tahun: Mengenalkan bagian tubuh dan konsep privasi.
 - b. Usia 6-9 tahun: Menjelaskan perubahan tubuh yang akan terjadi.
 - c. Usia 10-12 tahun: Membahas pubertas dan emosi yang menyertainya.
 - d. Usia 13 tahun ke atas: Diskusi lebih dalam tentang hubungan, tanggung jawab, dan konsekuensi seksual.
- 2. Membangun Komunikasi Terbuka dan Nyaman

Banyak anak merasa canggung atau takut bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi. Oleh karena itu, orang tua perlu menciptakan suasana yang nyaman dan bebas dari rasa malu atau takut.

- a. Dengarkan dengan empati: Biarkan anak bertanya dan berikan jawaban yang jujur serta sesuai dengan usianya.
 - b. Gunakan bahasa yang sederhana dan positif: Hindari kata-kata yang menakutkan atau menimbulkan stigma.
 - c. Jadilah sumber informasi yang dapat dipercaya: Jika anak tidak mendapatkan informasi dari orang tua, mereka mungkin mencarinya dari teman atau internet yang belum tentu benar.
3. Menanamkan Nilai-nilai dan Tanggung Jawab
- Pendidikan reproduksi bukan hanya soal biologis, tetapi juga tentang nilai dan tanggung jawab. Orang tua harus membantu anak memahami bahwa:
1. Setiap individu memiliki hak atas tubuhnya sendiri.
 2. Hubungan yang sehat harus didasarkan pada rasa hormat dan persetujuan.
 3. Tanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi termasuk menjaga kebersihan, memahami risiko, dan membuat keputusan yang bijaksana.
4. Memberikan Contoh yang Baik
- Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika orang tua menunjukkan sikap yang positif dan terbuka dalam berbicara tentang kesehatan reproduksi, anak akan lebih nyaman untuk berdiskusi dan bertanya.
5. Menggunakan Media dan Sumber Informasi yang Tepat
- Dengan kemajuan teknologi, banyak informasi yang tersedia, tetapi tidak semuanya akurat atau sesuai dengan usia anak. Orang tua bisa:
1. Memilih buku atau video edukasi yang sesuai.
 2. Mengawasi konten digital yang dikonsumsi anak.
 3. Menggunakan aplikasi atau sumber terpercaya untuk menjelaskan topik yang lebih kompleks.
6. Bekerja Sama dengan Sekolah dan Tenaga Kesehatan
- Pendidikan reproduksi tidak bisa hanya dilakukan di rumah. Orang tua dapat:
1. Berkomunikasi dengan guru tentang kurikulum pendidikan reproduksi di sekolah.
 2. Mengajak anak berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan jika ada pertanyaan lebih lanjut.
 3. Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas yang mendukung kesehatan reproduksi remaja.
- Sebagai pendidik utama, orang tua memiliki peran besar dalam membimbing anak memahami pendidikan reproduksi dengan benar. Dengan komunikasi yang terbuka, memberikan informasi yang sesuai usia, dan menjadi contoh yang baik, orang tua dapat membantu anak tumbuh dengan pemahaman yang sehat tentang tubuh, hubungan, dan tanggung jawab mereka sendiri.

F. Pendekatan Dan Strategi Pendidikan Reproduksi Di Keluarga

Pendidikan reproduksi yang efektif di keluarga memerlukan pendekatan yang tepat serta strategi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Pendekatan yang baik akan membantu anak memahami tubuhnya, mengembangkan sikap yang sehat terhadap seksualitas, serta membangun tanggung jawab dalam hubungan sosial dan reproduksi.

Berikut adalah beberapa pendekatan dan strategi yang dapat diterapkan oleh keluarga:

1. Pendekatan Berbasis Usia dan Perkembangan Anak

Pendidikan reproduksi harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman anak agar informasi yang diberikan tepat guna dan tidak menimbulkan kebingungan.

1. Usia 3-5 tahun:

- 1) Mengenalkan bagian tubuh dengan nama yang benar.
- 2) Mengajarkan konsep privasi dan batasan tubuh.
- 3) Menjelaskan bahwa ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain tanpa izin.

2. Usia 6-9 tahun:

- 1) Memperkenalkan konsep dasar pubertas.
- 2) Menanamkan pentingnya menjaga kebersihan diri.
- 3) Memberikan pemahaman awal tentang perbedaan gender.

3. Usia 10-12 tahun:

- 1) Menjelaskan perubahan tubuh saat pubertas lebih detail.
- 2) Membahas emosi dan ketertarikan kepada lawan jenis.
- 3) Mengajarkan batasan dalam pergaulan dan konsep persetujuan (consent).

4. Usia 13 tahun ke atas (remaja):

- 1) Diskusi lebih terbuka tentang seksualitas, hubungan, dan tanggung jawabnya.
- 2) Menjelaskan risiko kehamilan di luar nikah dan penyakit menular seksual.
- 3) Mengajarkan cara menghadapi tekanan sosial dan media terkait seksualitas.

2. Pendekatan Berbasis Nilai Keluarga dan Budaya

Orang tua dapat mengajarkan pendidikan reproduksi dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, budaya, dan agama yang dianut keluarga.

1. Menanamkan norma dan etika dalam berhubungan dengan lawan jenis.
2. Mengajarkan pentingnya kesetiaan, komitmen, dan tanggung jawab dalam hubungan.
3. Menggunakan kisah atau ajaran dalam budaya dan agama sebagai bahan diskusi.

3. Pendekatan Komunikasi Terbuka dan Dialog

Pendidikan reproduksi tidak boleh menjadi topik yang tabu di rumah. Dengan komunikasi yang terbuka, anak akan lebih nyaman untuk bertanya dan memahami informasi dengan benar.

1. Jangan menghakimi atau memarahi saat anak bertanya.
2. Gunakan bahasa yang jelas dan sesuai usia.
3. Dorong anak untuk berbicara tentang perasaannya terkait perubahan tubuh dan emosi mereka.

G. Komunikasi Terbuka Dan Efektif Dalam Keluarga Terkait Pendidikan Reproduksi

1. Komunikasi Terbuka dan Efektif dalam Keluarga terkait Pendidikan Reproduksi

Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak adalah kunci utama dalam memberikan pendidikan reproduksi yang efektif. Banyak anak merasa canggung atau takut membahas topik ini, sehingga orang tua perlu menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk berdiskusi.

Berikut adalah cara membangun komunikasi yang terbuka dan efektif dalam keluarga:

2. Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Nyaman

Anak perlu merasa bahwa mereka dapat berbicara dengan orang tua tanpa takut dihakimi atau dimarahi. Cara menciptakan lingkungan yang nyaman:

1. Jangan menghakimi atau mengkritik pertanyaan anak. Jika anak bertanya tentang sesuatu yang sensitif, tanggapilah dengan tenang dan positif.
2. Bersikap terbuka dan tidak malu. Jika orang tua terlihat canggung, anak juga akan merasa tidak nyaman untuk bertanya.
3. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan dulu pertanyaan anak sebelum langsung memberikan nasihat atau koreksi.

3. Menggunakan Bahasa yang Jelas dan Sesuai Usia

1. Hindari istilah medis yang rumit atau bahasa yang terlalu teknis untuk anak kecil.
2. Gunakan istilah yang benar untuk bagian tubuh dan proses biologis agar anak tidak bingung.
3. Sesuaikan penjelasan dengan usia dan tingkat pemahaman anak.

Contoh:

- 1) Anak usia 3-5 tahun: "Setiap orang punya bagian tubuh pribadi yang harus dijaga, tidak boleh disentuh orang lain tanpa izin."
- 2) Anak usia 6-9 tahun: "Saat kamu tumbuh besar, tubuhmu akan mengalami perubahan, itu namanya pubertas."

- 3) Anak usia remaja: "Saat kamu mulai tertarik pada seseorang, penting untuk memahami perasaanmu dan juga risiko serta tanggung jawabnya."
4. Memilih Waktu dan Situasi yang Tepat
- Pilih waktu yang santai dan tidak terkesan seperti interogasi. Beberapa situasi yang bisa dimanfaatkan:
1. Saat menonton film atau berita yang berkaitan dengan topik reproduksi.
 2. Saat mengobrol santai di perjalanan atau saat makan bersama.
 3. Jika anak bertanya, jawab dengan segera jika memungkinkan, atau beri tahu bahwa pembahasannya bisa dilakukan nanti dengan penjelasan yang lebih lengkap.
5. Memanfaatkan Media dan Sumber yang Tepat
1. Gunakan buku, video edukasi, atau situs web terpercaya sebagai alat bantu.
 2. Jika merasa kesulitan menjelaskan, ajak anak berdiskusi dengan dokter atau konselor.
 3. Arahkan anak untuk mendapatkan informasi dari sumber yang benar, bukan hanya dari internet atau teman sebaya.
6. Mengajarkan Bukan Melarang
- Banyak orang tua cenderung melarang atau menakut-nakuti anak daripada memberikan pemahaman. Misalnya:
- a. "Jangan pacaran dulu, nanti malah hamil!"
 - b. "Punya pacar itu boleh, tapi penting untuk memahami batasan dan tanggung jawab dalam hubungan."
- Pendekatan yang berbasis pemahaman dan diskusi lebih efektif dibandingkan sekadar melarang tanpa penjelasan.
7. Memberikan Kesempatan bagi Anak untuk Bertanya
1. Dorong anak untuk bertanya kapan pun mereka ingin tahu sesuatu.
 2. Jika orang tua tidak tahu jawabannya, akui dan cari informasi bersama-sama.
 3. Jangan meremehkan pertanyaan anak, meskipun tampak sepele.
8. Mengajarkan Anak tentang Batasan dan Privasi
1. Ajarkan konsep "tubuhku adalah milikku" agar anak memahami bahwa mereka berhak menentukan batasan terhadap tubuh mereka.
 2. Jelaskan bahwa tidak semua sentuhan itu baik dan bagaimana cara menolak sentuhan yang tidak nyaman.

Komunikasi terbuka dalam keluarga membantu anak memahami pendidikan reproduksi dengan cara yang sehat dan positif. Orang tua perlu bersikap jujur, tenang, dan responsif terhadap pertanyaan anak. Dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, memilih kata-kata yang sesuai, dan memberikan ruang bagi anak

untuk bertanya, orang tua dapat menjadi sumber informasi utama yang dapat dipercaya oleh anak.

H. Nilai-Nilai Keluarga Dalam Pendidikan Reproduksi

Pendidikan reproduksi tidak hanya sebatas memberikan informasi biologis tentang tubuh dan seksualitas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keluarga yang akan membentuk sikap dan perilaku anak dalam menjalani kehidupan. Orang tua memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai ini agar anak memiliki pemahaman yang sehat, bertanggung jawab, dan beretika dalam menyikapi aspek reproduksi dan hubungan sosialnya.

1. Nilai Tanggung Jawab

Anak perlu memahami bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan tubuh dan hubungan memiliki konsekuensi. Orang tua dapat mengajarkan:

1. Tanggung jawab terhadap tubuh sendiri, seperti menjaga kesehatan reproduksi dan kebersihan diri.
2. Tanggung jawab dalam hubungan, memahami batasan diri dan menghormati pasangan.
3. Tanggung jawab dalam menghadapi konsekuensi, seperti kehamilan di usia dini atau risiko penyakit menular seksual.

Cara mengajarkan:

- 1) Diskusikan tentang pentingnya membuat keputusan yang bijak.
- 2) Gunakan contoh nyata atau cerita untuk menggambarkan konsekuensi dari tindakan tertentu.

2. Nilai Rasa Hormat dan Batasan Diri

Mengajarkan anak untuk menghormati dirinya sendiri dan orang lain sangat penting dalam pendidikan reproduksi. Ini mencakup:

1. Menghormati batasan pribadi dan tubuh orang lain.
2. Mengerti bahwa setiap orang berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya.
3. Menolak paksaan dalam hubungan dan memahami konsep persetujuan (consent).

Cara mengajarkan:

- 1) Gunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajarkan anak untuk tidak memaksakan sesuatu kepada orang lain.
- 2) Berikan pemahaman bahwa "tidak" adalah jawaban yang harus dihormati, baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

3. Nilai Kejujuran dan Keterbukaan

Anak perlu merasa bahwa mereka dapat berbicara dengan orang tua tanpa rasa takut atau malu. Jika komunikasi dalam keluarga sudah terbuka, anak tidak akan mencari informasi dari sumber yang kurang terpercaya.

Cara mengajarkan:

1. Jadilah orang tua yang terbuka dan tidak menghakimi saat anak bertanya.
2. Sampaikan informasi dengan jujur dan sesuai dengan usia anak.

4. Nilai Kesetiaan dan Komitmen dalam Hubungan

Pendidikan reproduksi juga mencakup pemahaman tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat dan berkomitmen. Anak perlu memahami bahwa:

1. Hubungan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kepercayaan dan kesetiaan.
2. Perasaan dan emosi dalam hubungan harus dikelola dengan baik.

Cara mengajarkan:

- 1) Berikan contoh nyata dari hubungan yang harmonis di sekitar mereka.
- 2) Diskusikan bagaimana membangun hubungan yang sehat dan penuh komitmen.

5. Nilai Religius dan Moral dalam Seksualitas

Setiap keluarga memiliki nilai moral dan keyakinan yang berbeda mengenai pendidikan reproduksi. Namun, inti dari nilai ini adalah membimbing anak agar dapat menghormati dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka pilih.

Cara mengajarkan:

1. Sesuaikan pendidikan reproduksi dengan nilai agama dan budaya keluarga.
2. Jelaskan bahwa seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi harus disikapi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai yang dianut keluarga.

6. Nilai Kemandirian dalam Membuat Keputusan

Anak perlu dididik untuk membuat keputusan sendiri yang bijak, terutama dalam hal kesehatan reproduksi. Orang tua bisa membantu anak dengan:

1. Memberikan informasi yang cukup sehingga mereka bisa berpikir kritis.
2. Mengajarkan bagaimana mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu keputusan.

Cara mengajarkan:

1. Latih anak untuk menganalisis situasi sebelum mengambil keputusan.
2. Berikan kebebasan dalam batas yang aman untuk membuat pilihan sendiri.

Nilai-nilai keluarga sangat berperan dalam membentuk pemahaman dan sikap anak terhadap pendidikan reproduksi. Dengan menanamkan nilai tanggung jawab, hormat, keterbukaan, kesetiaan, moral, dan kemandirian, anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang sehat tentang tubuh, hubungan, dan keputusan yang mereka buat di masa depan.

I. Dampak Pendidikan Reproduksi Dalam Keluarga

Pendidikan reproduksi dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku anak terhadap tubuhnya, kesehatan reproduksi, serta hubungan sosialnya. Ketika pendidikan ini diberikan dengan baik, dampaknya bisa sangat positif bagi perkembangan anak dan remaja. Sebaliknya, jika pendidikan reproduksi diabaikan atau disampaikan dengan cara yang salah, anak dapat berisiko mengalami kesalahpahaman, perilaku berisiko, atau informasi yang salah.

Berikut adalah beberapa dampak dari pendidikan reproduksi yang diberikan dalam keluarga:

1. Dampak Positif Pendidikan Reproduksi Dalam Keluarga

a. Meningkatkan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi

Anak yang mendapatkan pendidikan reproduksi dari keluarga akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang:

- 1) Perubahan tubuh selama pubertas.
- 2) Cara menjaga kesehatan organ reproduksi.
- 3) Siklus menstruasi dan produksi sperma.
- 4) Cara mencegah penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan.

Dengan pemahaman ini, anak akan lebih siap menghadapi perubahan dalam tubuhnya dan mampu menjaga kesehatannya dengan lebih baik.

b. Membantu Anak Menghargai dan Menghormati Tubuhnya

Pendidikan reproduksi yang baik mengajarkan anak bahwa tubuhnya adalah miliknya dan harus dihormati. Anak yang memahami ini akan:

- 1) Lebih sadar akan batasan tubuhnya dan menolak perlakuan yang tidak pantas.
- 2) Tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari teman sebaya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai dirinya.

3) Menghormati tubuh orang lain dan memahami konsep persetujuan (consent).

c. Mengurangi Perilaku Berisiko di Kalangan Remaja

Pendidikan reproduksi yang diberikan sejak dini dan dengan cara yang tepat dapat mencegah remaja melakukan perilaku berisiko, seperti:

- 1) Seks bebas yang tidak aman.
- 2) Kehamilan di usia remaja.
- 3) Penyalahgunaan media digital yang berkaitan dengan pornografi atau pelecehan seksual.

Remaja yang mendapatkan pendidikan reproduksi dari orang tua biasanya lebih mampu mengambil keputusan yang bijak dalam pergaulan mereka.

d. Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Kesehatan Mental Anak

Ketika anak memiliki pemahaman yang baik tentang tubuhnya dan seksualitasnya, mereka akan lebih percaya diri dalam menghadapi perubahan dalam hidupnya. Dampaknya:

- 1) Anak tidak merasa malu atau takut terhadap perubahan yang terjadi selama pubertas.
- 2) Mereka lebih nyaman berbicara tentang kesehatan reproduksi dengan orang tua atau tenaga kesehatan.
- 3) Anak tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan dari teman atau media sosial.

e. Membangun Hubungan yang Lebih Dekat antara Orang Tua dan Anak

Keluarga yang menerapkan komunikasi terbuka dalam pendidikan reproduksi akan membangun hubungan yang lebih erat antara orang tua dan anak.

- 1) Anak merasa nyaman berbicara tentang masalah pribadinya kepada orang tua.
- 2) Orang tua dapat memahami dan mendukung perkembangan anak dengan lebih baik.
- 3) Anak lebih cenderung mencari nasihat dari orang tua dibandingkan mencari informasi dari sumber yang kurang terpercaya.

2. Dampak Negatif Jika Pendidikan Reproduksi Diabaikan

Jika pendidikan reproduksi tidak diberikan atau diberikan dengan cara yang salah, ada beberapa dampak negatif yang bisa terjadi, antara lain:

a. Anak Mendapatkan Informasi yang Salah dari Sumber Lain

Tanpa bimbingan orang tua, anak cenderung mencari informasi dari teman sebaya atau internet yang mungkin tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Hal ini bisa menyebabkan:

- 1) Miskonsepsi tentang seksualitas dan reproduksi.
 - 2) Penyebaran mitos yang tidak berdasar.
 - 3) Perilaku yang tidak sehat dalam hubungan sosial.
- b. Risiko Kehamilan di Usia Remaja dan Penyakit Menular Seksual
- Remaja yang tidak mendapatkan pendidikan reproduksi cenderung tidak memahami risiko dan konsekuensi dari hubungan seksual. Dampaknya:
1. Kehamilan yang tidak direncanakan di usia muda.
 2. Penyakit menular seksual karena kurangnya pemahaman tentang cara pencegahan.
 3. Tekanan emosional akibat keputusan yang diambil tanpa pemahaman yang cukup.
- c. Anak Mengalami Rasa Takut atau Malu terhadap Perubahan Tubuhnya
- Tanpa edukasi yang cukup, anak dapat merasa takut, cemas, atau bahkan jijik terhadap perubahan tubuhnya sendiri, misalnya:
1. Remaja putri yang mengalami menstruasi pertama tanpa persiapan bisa merasa panik atau bingung.
 2. Remaja laki-laki yang mengalami mimpi basah bisa merasa malu atau bersalah.
- Ketidaktahuan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mental anak dan kepercayaan dirinya.
- d. Kesulitan dalam Membangun Hubungan yang Sehat
- Tanpa pemahaman yang baik tentang hubungan yang sehat, anak bisa mengalami berbagai masalah, seperti:
1. Tidak bisa menetapkan batasan dalam pergaulan.
 2. Sulit memahami konsep persetujuan dalam hubungan.
 3. Rentan terhadap tekanan sosial untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
- e. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Kesehatan Reproduksi
- Anak yang tidak mendapatkan pendidikan reproduksi yang baik sering kali kurang peduli terhadap kesehatan reproduksinya, yang bisa berdampak pada:
1. Kurangnya kebersihan organ reproduksi.
 2. Tidak mengetahui kapan harus berkonsultasi ke dokter saat mengalami masalah kesehatan reproduksi.
 3. Tidak memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, seperti Pap smear atau pemeriksaan testis.

Pendidikan reproduksi dalam keluarga memberikan dampak yang sangat besar bagi anak dan remaja. Jika diberikan dengan baik, pendidikan ini akan

membantu anak memahami tubuhnya, membangun kepercayaan diri, serta mencegah perilaku berisiko. Namun, jika diabaikan, anak berisiko mendapatkan informasi yang salah, mengalami masalah dalam hubungan sosial, dan menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk mulai membangun komunikasi yang terbuka dan memberikan pendidikan reproduksi yang sesuai dengan usia anak agar mereka dapat tumbuh dengan pemahaman yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi mereka.

J. Kolaborasi Keluarga Dengan Lingkungan Eksternal Dalam Pendidikan Reproduksi

Pendidikan reproduksi yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan dukungan dari lingkungan eksternal, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, komunitas, dan media. Kolaborasi ini penting agar anak mendapatkan informasi yang akurat, dukungan moral, serta lingkungan yang mendukung perkembangan reproduksi dan seksual yang sehat.

1. Peran Berbagai Pihak dalam Kolaborasi Pendidikan Reproduksi

a. Sekolah sebagai Mitra dalam Pendidikan Reproduksi

Sekolah memiliki peran penting dalam melengkapi pendidikan reproduksi yang diberikan di rumah. Bentuk kolaborasi antara keluarga dan sekolah meliputi:

1. Kurikulum Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi ke dalam mata pelajaran seperti Biologi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, atau Bimbingan Konseling.
2. Workshop atau Seminar untuk Orang Tua dan Siswa: Mengundang tenaga ahli untuk membahas topik kesehatan reproduksi, hubungan sehat, dan pubertas.
3. Layanan Konseling: Sekolah menyediakan layanan bimbingan konseling agar siswa memiliki tempat aman untuk bertanya dan berdiskusi tentang isu reproduksi dan seksual.

b. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit)

Kolaborasi dengan tenaga kesehatan membantu memberikan informasi yang lebih akurat dan profesional, misalnya:

1. Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja): Fasilitas kesehatan bisa menjadi tempat bagi remaja untuk berkonsultasi terkait kesehatan reproduksi mereka.

2. Pemeriksaan Kesehatan Berkala: Orang tua dapat berkoordinasi dengan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak, termasuk kesehatan reproduksi.
 3. Edukasi dan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi: Mengadakan kegiatan edukatif bersama keluarga mengenai pentingnya kebersihan organ reproduksi dan pencegahan penyakit menular seksual.
- c. Komunitas dan Organisasi Sosial
- Komunitas dan organisasi sosial berperan dalam membangun lingkungan yang suportif bagi pendidikan reproduksi melalui:
1. Program Penyuluhan di Masyarakat: Kelompok masyarakat bisa mengadakan diskusi dan forum terbuka tentang pendidikan seksual.
 2. Dukungan bagi Orang Tua: Komunitas bisa memberikan pelatihan kepada orang tua tentang cara berbicara dengan anak mengenai kesehatan reproduksi.
 3. Kampanye Anti-Pelecehan Seksual: Komunitas dapat berperan dalam membangun kesadaran tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.
- d. Peran Media dan Teknologi dalam Pendidikan Reproduksi
- Media dan teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam pendidikan reproduksi, namun perlu pendampingan orang tua. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui:
1. Pemanfaatan Media Edukasi: Menyediakan akses ke buku, film edukatif, dan artikel terpercaya tentang kesehatan reproduksi.
 2. Filter dan Pengawasan Konten Digital: Orang tua dapat menggunakan aplikasi untuk mengontrol konten yang dikonsumsi anak terkait topik seksual di internet.
 3. Kampanye Digital Positif: Mempromosikan edukasi reproduksi yang sehat melalui media sosial dan platform daring.
2. Manfaat Kolaborasi Keluarga dengan Lingkungan Eksternal
- a. Menyediakan Informasi yang Akurat dan Ilmiah
- 1) Anak dan remaja mendapatkan informasi yang benar dari sumber terpercaya.
 - 2) Mengurangi penyebaran mitos dan misinformasi tentang kesehatan reproduksi.
- b. Membantu Orang Tua dalam Menyampaikan Pendidikan Reproduksi
- 1) Orang tua yang kurang percaya diri dalam menjelaskan pendidikan seksual dapat dibantu oleh sekolah, tenaga kesehatan, dan komunitas.

- 2) Memudahkan orang tua mengakses sumber daya yang mendukung pendidikan reproduksi di rumah.
- c. Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Remaja
 - 1) Remaja lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka.
 - 2) Mereka memiliki lebih banyak tempat untuk bertanya dan berdiskusi secara terbuka.
- d. Mencegah Perilaku Berisiko
 - 1) Dengan dukungan dari berbagai pihak, anak lebih mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab.
 - 2) Mengurangi angka kehamilan remaja dan penyakit menular seksual.

Kolaborasi antara keluarga dan lingkungan eksternal sangat penting dalam memberikan pendidikan reproduksi yang holistik bagi anak. Dengan keterlibatan sekolah, tenaga kesehatan, komunitas, dan media, anak dan remaja dapat menerima informasi yang akurat, memiliki lingkungan yang mendukung, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka.

K. Penutup

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan reproduksi kepada anak dan remaja. Dengan komunikasi yang terbuka, pemahaman yang benar, serta dukungan emosional yang kuat, keluarga dapat menjadi sumber informasi utama yang membentuk sikap dan perilaku reproduksi yang sehat. Pendidikan reproduksi dalam keluarga bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai, keterampilan hidup, dan kesiapan dalam menghadapi perubahan di setiap tahap perkembangan.

Referensi

- BKKBN. (2020). *Pedoman pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Departemen Kesehatan RI. (2019). *Pedoman pelayanan kesehatan reproduksi remaja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- WHO (World Health Organization) . (2013) tentang *Comprehensive Sexuality Education* (CSE).
- UNICEF dan UNESCO . (2018) mengenai pendidikan seksual berbasis keluarga.
- Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN terkait kebijakan kesehatan reproduksi dan edukasi seksual bagi remaja.
- https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/1/international-technical-guidance-on-sexuality-education?utm_source=chatgpt.comInternational technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach
- https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000229673?utm_source=chatgpt.com
- https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000229599?utm_source=chatgpt.com
- <https://www.youtube.com/watch?v=mD0gY33bjBM>
- [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45757/1/18200010019_BAB-I_IV-atau V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45757/1/18200010019_BAB-I_IV-atau_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21534/1/AGOS%20PURNO MO-FITK.pdf>
- <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/831/1/LAILATUL%20MASRUROH%20NPM.%201501010269.pdf>

Glosarium

Adolescence (Masa Remaja) – Periode transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial.

Edukasi Seksual – Proses pemberian informasi dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, hubungan interpersonal, serta aspek emosional dan sosial dari seksualitas.

Family Planning (Perencanaan Keluarga) – Usaha yang dilakukan keluarga untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak melalui metode kontrasepsi atau cara lainnya.

Hormon Reproduksi – Zat kimia dalam tubuh yang berperan dalam perkembangan dan fungsi sistem reproduksi, seperti estrogen, progesteron, dan testosteron.

Kesehatan Reproduksi – Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsinya pada setiap tahap kehidupan.

Menstruasi – Siklus bulanan yang dialami oleh perempuan di mana lapisan rahim meluruh dan dikeluarkan melalui vagina jika tidak terjadi kehamilan.

Mitos Seksual – Kepercayaan yang tidak berdasar mengenai seksualitas dan reproduksi yang sering berkembang di masyarakat.

Orang Tua sebagai Pendidik Seksual – Peran orang tua dalam memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan hubungan sosial kepada anak-anak mereka.

Pergaulan Bebas – Interaksi sosial yang dilakukan tanpa batasan norma dan dapat berisiko bagi kesehatan reproduksi, seperti seks bebas dan penyalahgunaan zat.

Pendidikan Seksual Komprehensif – Pendekatan pendidikan yang mencakup informasi mengenai aspek biologis, emosional, sosial, dan etika terkait seksualitas.

Pubertas – Masa perkembangan ketika tubuh anak mulai mengalami perubahan fisik dan hormonal yang menandakan kesiapan organ reproduksi.

Seksualitas – Aspek kehidupan manusia yang mencakup identitas gender, orientasi seksual, perilaku seksual, serta ekspresi emosional dan sosial.

Sistem Reproduksi – Struktur dan organ dalam tubuh yang berfungsi dalam proses reproduksi, seperti testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan.

Tanggung Jawab Seksual – Kesadaran seseorang dalam menjaga kesehatan reproduksi, termasuk memahami konsekuensi dari hubungan seksual.

Tingkat Literasi Seksual – Kemampuan seseorang untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan reproduksi dengan baik.

Komunikasi Keluarga – Interaksi antara anggota keluarga yang mendukung pembelajaran dan pemahaman tentang seksualitas serta kesehatan reproduksi.

BAB III

PENGARUH POLA ASUH TERHADAP PERILAKU REMAJA

A. Pendahuluan

Kehidupan keluarga suami istri tidak dapat sekadar didasarkan pada hubungan suka sama suka yang menjadi penyalur kerinduan seksual. Membangun sebuah keluarga tidak hanya membutuhkan seorang laki-laki yang secara psikologis siap jadi imam yang baik guna istrinya, tetapi juga membutuhkan seorang perempuan yang siap secara mental serta fisik guna jadi seorang istri, memiliki keterampilan yang dibutuhkan, siap jadi seorang ibu, serta siap jadi madrasah bagi anak-anaknya. Jika kedua orang tua tidak siap, maka tidak ada anak yang terabaikan dan tidak mengetahui kelangsungan hidup mereka di masa depan, sehingga tidak akan tercipta keluarga yang bahagia.

Keluarga sejahtera diberikan arti selaku keluarga yang dibentuk berlandaskan atas perkawinan sah, bisa mencukupi keperluan hidup spiritual serta material yang layak, bertaqwa pada Tuhan YME, serta mempunyai hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras diantara anggotanya maupun antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Adristinindya, U dkk, 2021). PP No. 21 Tahun 1994 Bab 1, Pasal 1, Ayat 2 juga mengatur tentang perwujudan keluarga sejahtera.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan awal anak. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh sikap dan tindakan semua orang tua dalam keluarga. Perilaku anak secara langsung dan kuat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam keluarga. Kasih sayang orang tua sangat diperlukan karena orang tua ingin anaknya berhasil, mencapai cita-citanya, bergaul dengan orang lain, dan tidak selalu mendapat masalah (Ahmad S, 2015).

Masa remaja yakni masa transisi yang sering disebut sebagai masa adolescence. Pada masa transisi ini dapat terjadi fase krisis yang diberi tanda dengan kecenderungan untuk menunjukkan perilaku menyimpang. Dalam beberapa keadaan, perilaku menyimpang ini akan berubah jadi perilaku yang mengganggu jika didorong oleh lingkungan yang tidak kondusif; akibatnya, hal ini akan mengarah pada terciptanya perilaku menyimpang lebih lanjut dan kegiatan berbahaya yang bertentangan dengan norma dan peraturan sosial.

Tindakan remaja juga akan berdampak pada perilaku mereka. Dikarenakan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian remaja secara utuh, bukan hanya kecakapan akademisnya saja. Pengawasan orang tua sangat penting di sepanjang tahap perkembangan anak karena ini adalah langkah pertama dalam

mendidik mereka. Hal ini serupa dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari ketika pengaruh eksternal membentuk kepribadian seseorang. Kehidupan bermasyarakat juga membantu orang tua dalam proses pengembangan kepribadian anak. Pengajaran perilaku sosial anak merupakan bidang lain yang menjadi tanggung jawab masyarakat (Arikunto, 2010).

Remaja yang terlampaui jauh dari kasih sayang orang tua akan lebih mudah melakukan pengekspresian dirinya dengan cara-cara yang berbau tidak baik, bertindak tanpa pengawasan orang tua, dan berinteraksi dengan orang lain di lingkungan manapun. Akibatnya, mereka akan menunjukkan banyak perilaku buruk dan perilaku yang tidak selaras dengan norma agama serta sosial. Ketika orang tua tidak peduli dengan pergaulan anak-anaknya, oleh karenanya akan berakibat pada perilaku negatif seperti seks bebas dan kenakalan remaja. Kondisi ini sering kali muncul pada anak-anak yang berada di bawah pengasuhan mereka.

Periode pengasuhan ini berfungsi sebagai penghalang terhadap perilaku menyimpang di masa depan dari anak-anak. Semua faktor yang mempengaruhi bagaimana anak-anak mengembangkan karakter mereka harus diperhitungkan dengan cermat untuk mencegah masalah yang lebih serius selama masa puber, seperti ketidaktaatan, kurangnya disiplin, dan perilaku abnormal lainnya. Untuk memenuhi harapan setiap orang tua, yaitu lahirnya generasi mandiri yang berkomitmen pada Tuhan YME dan mampu memiliki kesadaran diri, orang tua harus menerapkan gaya pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka.

B. Definisi Pola Asuh

Penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial dan internal, pendidikan yang diberikan kepada anak, dialog dengan anak, sosial budaya, suasana psikologis, perilaku yang ditunjukkan ketika bertemu dengan anak, kontrol atas perilaku anak, dan penentuan nilai-nilai moral selaku landasan perilaku serta apa yang dikejar oleh anak, semuanya merupakan contoh-contoh upaya orang tua yang diaktualisasikan dalam konteks pengasuhan anak (Nyoman Subagia, 2021).

Dalam rangka membantu anak menjadi mandiri, tumbuh dan berkembang sesuai potensinya, mempunyai rasa percaya diri, rasa ingin tahu, ramah, serta fokus pada kesuksesan, orang tua memberi dorongan anak dengan melakukan perubahan perilaku, pengetahuan, serta nilai-nilai mereka dengan cara yang dipandang paling sesuai bagi orang tua (Saiful Djamarah, 2018).

Lingkungan rumah adalah tempat anak pertama kali mempelajari berbagai topik dan merupakan lingkungan pendidikan non-formal yang dapat memberikan efek langsung ataupun tidak langsung pada perilaku serta perkembangan mereka. Dalam perspektif setiap orang, terutama orang tua, anak-anak adalah permata yang tak ternilai harganya; mereka berfungsi sebagai pengikat antara anggota keluarga. Maka dari itu, bisa diungkapkan bahwa anak adalah sesuatu yang tak terukur dan

mereka dipercayakan oleh penciptanya untuk dilindungi, dididik, disayangi, dan diwujudkan agar tidak menjadi lemah secara intelektual, fisik, dan material.

Proses di mana orang tua melindungi, mendidik, dan merawat anak-anak mereka disebut sebagai pengasuhan. Pola asuh orang tua, selain lingkungan sosial anak, akan memberi dampak pada bagaimana anak mengembangkan sikap dan karakternya sepanjang hidupnya. Pola asuh diartikan sebagai pola perilaku, tata cara, serta tindakan yang dilakukan oleh orang tua baik ayah, ibu, ataupun wali yang secara terus menerus memelihara, mendidik, dan merawat anaknya. Perihal ini bisa memberi dampak positif dan negatif, tetapi juga dapat membantu perkembangan anak. Definisi ini didasarkan pada berbagai definisi pengasuhan orang tua yang diberikan di atas.

C. Jenis-jenis pola Asuh

Banyak pendekatan yang diperlukan untuk merawat berbagai jenis anak ini karena diketahui bahwa ada berbagai jenis orang tua dan anak. Beberapa jenis gaya pengasuhan anak yang sering digunakan dalam rumah tangga, seperti:

1. Pola asuh demokratis

Pola asuh demokratis menempatkan penekanan kuat pada cinta dan perhatian, tetapi juga menggabungkan ketegasan dan disiplin untuk memastikan bahwa pengasuhan anak benar-benar terorganisir. Anak-anak tunduk pada peraturan dalam gaya pengasuhan ini, tetapi mereka juga diberi bimbingan serta penjelasan tentang apa yang boleh serta tidak boleh diperbuat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membantu anak-anak memahami apa yang mereka lakukan, bukan untuk memaksa mereka.

Casmini. 2017. Pola Asuh Demokratis. Jakarta: Gramedia. Model pola asuh demokratis, berlandaskan Baurmind & Black dalam Hanna Widjaya (1986) model pola asuh demokratis ini mencakup:

- a. Membangun rasa percaya diri dan keyakinan diri dengan mendorong anak untuk melakukan kontrol diri dan mendukung perilaku yang terarah.
- b. Membantu anak-anak dalam membuat pilihan mereka sendiri.
- c. Mendorong kemandirian yang bertanggung jawab.
- d. Orang tua dan anak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- e. Orang tua secara bertahap memikul lebih banyak tanggung jawab untuk anak-anak mereka.
- f. Memberi dan menerima.
- g. Mendengar keluhan dan sudut pandang satu sama lain.
- h. Ketika orang tua bertindak, mereka selalu memberikan penjelasan kepada anak.
- i. Memotivasi anak untuk bersikap tidak memihak dan saling mendukung.
- j. Tegak tetapi baik dan penuh kasih sayang.

2. Pola asuh otoriter

Gaya pengasuhan yang dikenal sebagai pengasuhan otoriter menempatkan batasan-batasan pada anak-anak secara keseluruhan dan mengharuskan setiap perilaku anak didikte oleh orang tua mereka. Berbeda dengan pola asuh demokratis, yang memungkinkan anak mengekspresikan diri mereka secara bebas, gaya pengasuhan ini tidak memberikan kebebasan kepada anak untuk berbicara atau bertindak. Menetapkan batasan dan melarang anak untuk melakukan sesuatu adalah ciri khas pola asuh otoriter. Untuk mendorong usaha dan kerja keras, orang tua akan mendorong anak untuk mengikuti instruksi mereka (Winarti, 1992).

Menurut perspektif Dariyo dalam Munita Yeni (2017), pola asuh seperti ini juga dikenal selaku pola asuh sentral, di mana semua perkataan, keinginan, dan standar orang tua digunakan sebagai pedoman atau standar yang wajib diikuti oleh anak. 19. Oleh karena itu, perilaku dan tingkah laku anak akan selalu didasarkan pada apa yang diputuskan oleh orang tua mereka, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk tumbuh sebagai individu dan menemukan potensi dan bakat mereka sendiri. Meskipun demikian, orang tua akan selalu mengawasi perilaku anak-anak mereka untuk memudahkan mereka melihat potensi hasil negatif seperti pergaulan negatif dan perilaku negatif. Penulis membuat kesimpulan berikut ini mengenai tanda-tanda pola asuh otoriter berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya:

- a. Anak-anak sepenuhnya berada di bawah kendali orang tua mereka.
- b. Ada komunikasi satu arah.
- c. Orang tua jarang memberikan pujian kepada anak.
- d. Ketika orang tua menekan anak, anak sering merasa takut.
- e. Memaksakan semua keinginan orang tua.
- f. Tidak mengizinkan anak untuk mengekspresikan ide-idenya.
- g. Anak-anak berjuang untuk membangun keterampilan dasar mereka.

3. Pola asuh permisif

Gaya pengasuhan yang dikenal sebagai pengasuhan permisif menempatkan batasan-batasan pada anak-anak secara keseluruhan dan mengharuskan setiap perilaku anak didikte oleh orang tua mereka. Berbeda dengan pola asuh demokratis, yang memungkinkan anak mengekspresikan diri mereka secara bebas, gaya pengasuhan ini tidak memberikan kebebasan kepada anak untuk berbicara atau bertindak. Menetapkan batasan dan melarang anak untuk melakukan sesuatu adalah ciri khas pola asuh otoriter. Untuk mendorong usaha dan kerja keras, orang tua akan mendorong anak untuk mengikuti instruksi mereka (Winarti, 1992).

Menurut perspektif Dariyo dalam Munita Yeni (2017), pola asuh seperti ini juga dikenal selaku pola asuh sentral, di mana semua perkataan, keinginan, serta standar orang tua digunakan sebagai pedoman atau standar yang wajib diikuti oleh anak. 19. Oleh karena itu, perilaku dan tingkah laku anak akan selalu didasarkan pada apa yang diputuskan oleh orang tua mereka, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk tumbuh sebagai individu dan menemukan potensi dan bakat mereka sendiri. Meskipun demikian, orang tua akan selalu mengawasi perilaku anak-anak mereka untuk memudahkan mereka melihat potensi hasil negatif seperti pergaulan negatif dan perilaku negatif. Penulis membuat kesimpulan berikut ini mengenai tanda-tanda pola asuh otoriter berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya.

4. Pola asuh penelantar

Salah satu gaya pengasuhan yang terkadang disebut “pengasuhan yang lalai” adalah pengasuhan yang lalai. Ketidakpedulian orang tua adalah ciri dari pengasuhan yang lalai, ketika orang tua gagal memenuhi tugas sebagai orang tua dan tidak menetapkan standar. 21. Dengan demikian, gaya pengasuhan ini cenderung menelantarkan atau mengabaikan anak, tidak berkontribusi pada perkembangan karakter anak, dan membiarkan anak berperilaku seenaknya tanpa pengawasan serta kontrol yang cukup dari orang tua.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Berlandaskan Fatmawati et al., (2021), Segala faktor yang memberi dampak pada pola asuh orang tua yang diberi pada anak seperti;

1. Faktor Pendidikan Orang Tua

Pengasuhan yang diberi orang tua pada anak-anak mereka sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka, termasuk pemahaman mereka akan tugas-tugas sebagai orang tua, kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah, serta pengetahuan tentang perkembangan anak.

2. Faktor Dari Pengalaman Orang Tua

Gaya pengasuhan orang tua dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan pola asuh mereka di masa kecil, yang kemudian mereka terapkan kepada anak-anak mereka.

3. Faktor Ekonomi Orang Tua

Karena hal tersebut berdampak pada sumber daya yang tersedia guna mendidik anak, seperti akses ke sekolah serta kegiatan untuk anak, keadaan ekonomi keluarga juga berdampak pada pengasuhan anak.

4. Faktor Kebudayaan

Gaya pengasuhan orang tua dipengaruhi oleh budaya yang mereka temui di keluarga dan masyarakat; mereka sering mencontoh pola asuh dan pengasuhan anak dari orang lain. Hal ini dilakukan karena orang tua percaya bahwa jika orang lain berhasil mengikuti pola tersebut, maka mereka akan dapat menerapkannya juga.

E. Pengertian Remaja

Istilah remaja, seperti yang dikenal dalam bahasa aslinya, bermula dari bahasa Latin *adolenscere*, yang berarti "tumbunh atau tumbuh guna meraih kematangan." Berlandaskan psikologi, masa remaja yakni masa saat seseorang berintegrasi ke dalam masyarakat dewasa dan saat anak-anak tidak merasa lebih rendah dibandingkan orang yang lebih tua melainkan setara dengan mereka (Ali et al. 2018).

WHO memberi pendefinisian remaja selaku mereka yang berumur diantara 10 hingga 19 tahun yang memenuhi tiga persyaratan: biologis, psikologis, dan sosioekonomi. Di Indonesia, remaja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur diantara 10 hingga 18 tahun, berdasarkan Permenkes No. 25 Tahun 2014 (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

1. Kategore Usia Remaja

a. Masa remaja awal (11-14 tahun).

- 1) Tidak stabil kondisinya, lebih emosional
- 2) Memiliki banyak masalah,
- 3) Mulai tertarik pada lawan jenis,
- 4) Masa yang kritis,
- 5) Timbulnya rasa kurang percaya diri,
- 6) Suka melakukan pengembangan gelisah, pikiran baru, suka berkhayal serta suka menyendiri.

b. Masa remaja madya (pertengahan) (usia 14-17 tahun)

- 1) Sangat memerlukan teman,
- 2) Condong mempunyai sifat kecintaan.narsistik pada diri sendiri,
- 3) Ada dalam kondisi kebingungan serta keresahan, dikarenakan pertentangan yang timbul dalam diri,
- 4) Berkenginan besar melakukan percobaan segala hal yang belum diketahuinya,
- 5) Keinginan melakukan penjelajahan ke alam sekitar yang lebih luas.

c. Masa remaja akhir (17-20 tahun). Dengan ciri-ciri

- 1) Aspek-aspek psikis serta fisiknya mulai stabil.
- 2) Mengalami peningkatannya berfikir realistis, mempunyai sikap pandang yang telah baik.

- 3) Lebih matang dalam cara melawan masalah, ketenangan emosional bertambah, lebih bisa menguasai perasaan.
- 4) Telah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- 5) Lebih banyak perhatian pada lamabang-lambang kematangan (Saputro, 2018).

F. Tahap Perkembangan Remaja

Ada beberapa aspek pertumbuhan remaja, seperti kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Ada beberapa pola perkembangan yang sering terlihat, meskipun setiap orang dapat mengalami fase-fase tersebut secara berbeda. Menurut Syahrudin dkk. (2023) dan Haryanti (2016), remaja mengalami fase-fase perkembangan sebagai berikut:

1. Perkembangan Fisik

Salah satu dari dua tahap kehidupan seseorang di mana perkembangan fisik terjadi pada tingkat yang relatif tinggi adalah masa remaja. Ciri-ciri seks sekunder masuk penonjolan payudara pada remaja perempuan, perkembangan rambut ketiak, pembesaran testis pada remaja laki-laki, atau rambut kemaluan mulai muncul pada masa remaja awal (usia 11-14 tahun). Periode remaja pertengahan (usia 14-17) yakni ketika ciri-ciri seks sekunder ini paling berkembang, dan tahap remaja akhir (usia 17-20) adalah saat proses dan perkembangan reproduksi hampir tuntas erta remaja sudah mencapai kematangan fisik.

2. Identitas

Penerimaan atau penolakan adalah indikator awal dari ketertarikan teman sebaya. Remaja bereksperimen dengan banyak peran, mengubah persepsi mereka tentang diri mereka sendiri, menjadi lebih mencintai diri mereka sendiri, dan memiliki beberapa impian hidup yang utopis. Masa remaja akhir adalah masa ketika harga diri, citra tubuh, dan peran gender yang stabil hampir terbentuk.

3. Perkembangan Kognitif (Intelektual)

Proses perkembangan kognitif dipengaruhi oleh sejumlah variabel, seperti pengalaman pribadi, lingkungan, dan genetika. Proses pertumbuhan mental manusia, yang meliputi akuisisi, generalisasi, dan penerapan informasi, terjadi sepanjang masa ini. Proses mental meliputi menimbang, mengamati, mengingat, melakukan analisis, menilai, serta menyelesaikan masalah melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

4. Perkembangan Emosi

Puncak emosi, atau pertumbuhan emosi yang tinggi, terjadi sepanjang masa remaja. Bagi remaja, mencapai kematangan emosional adalah tujuan

perkembangan yang sangat menantang. Oleh karena itu, keadaan sosio-emosional di lingkungan sekitar, terkhusus lingkungan rumah serta kelompok teman sebaya, memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pencapaiannya.

Karena perubahan emosi sepanjang masa remaja meliputi emosi rasa bersalah, kesadaran diri, kesepian, dan keputusan, terutama antara usia 12 dan 15 tahun, maka perkembangan emosi adalah sesuatu yang sangat membutuhkan perhatian. Menurut Nasrudin (2013), mereka lebih mudah tersinggung, murung, kurang sopan, tidak tenang, mudah gelisah, dan meledak-ledak (impulsif dan regresif).

5. Perkembangan Kepribadian

Masa yang paling krusial bagi perkembangan serta integrasi kepribadian adalah masa remaja. Pembentukan identitas terjadi sepanjang masa remaja. Remaja akan merasa bingung jika mereka tidak dapat menggabungkan elemen dan pilihan atau jika mereka merasa tidak mampu membuat keputusan. Banyak elemen, termasuk lingkungan keluarga, panutan, dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, memengaruhi bagaimana seseorang mengembangkan identitas mereka.

6. Perkembangan Psikososial

Konsep diri remaja, lingkungan teman sebaya, dan dinamika keluarga dapat berdampak pada perkembangan psikososial mereka. Menurut Saputra dkk. (2020), remaja yang memiliki konsep diri yang buruk tidak memiliki pengetahuan diri yang cukup untuk mempengaruhi proses penerimaan diri mereka.

G. Kenakalan Remaja

Anak-anak mengalami banyak perubahan fisik dan psikologis selama masa remaja, yang membuatnya menjadi waktu yang penting. Masa remaja adalah masa yang sangat berharga karena kebingungan yang disebabkan oleh perubahan psikologis. Setelah itu, pertumbuhan remaja berubah dengan sangat cepat. Remaja masih dipandang sebagai anak-anak oleh sebagian orang, sementara banyak orang lain melihat mereka sebagai bagian dari populasi orang dewasa, dengan pemikiran yang setara dengan orang dewasa. Remaja dalam bahasa Inggris disebut sebagai *adult*, yang bermula dari bahasa Latin *adolescere*, yang mempunyai arti jadi dewasa, menurut Gazi dan Faojah.

Secara lebih spesifik, masa remaja adalah masa ketika seseorang mulai menunjukkan karakteristik orang dewasa saat mereka beranjak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pertumbuhan khas seorang remaja terjadi antara usia 12 dan 22 tahun, yang berarti 10 tahun masa remaja. Namun, anak-anak sekolah dasar yang

“menjadi dewasa dengan cepat” karena kemajuan teknologi dan koneksi yang sudah ada sebelumnya dianggap lebih cepat dalam periode pubertas saat ini. Seorang anak muda akan tumbuh melalui masa remaja dengan lebih cepat dengan cara ini. Masa remaja tidak terjadi pada waktu yang sama di setiap negara. Tergantung pada standar kedewasaan lokal, waktunya bervariasi. Sebagai contoh, anak-anak berusia dua belas tahun di pedesaan, komunitas pertanian sudah melakukan tugas-tugas yang semestinya dilaksanakan oleh orang dewasa. Dalam situasi ini, hal ini menunjukkan bahwa orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut telah mengamanatkan agar ia bertanggung jawab. Di sisi lain, masa remaja berlangsung lebih lama di wilayah metropolitan karena situasi kehidupan yang lebih rumit dan heterogen yang disebabkan oleh dampak dari norma-norma sosial, moral, etika, dan budaya.

Sebaliknya, Dana Darurat Anak-Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menyatakan bahwa “anak-anak didefinisikan sebagai populasi yang berusia antara 0 hingga 18 tahun.” Sementara itu, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, setiap orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah menikah dianggap sebagai anak.

Juvenile delinquency diterjemahkan sebagai “kenakalan anak”. Namun, kenakalan remaja sekarang secara umum dipahami sebagai definisi kenakalan anak. “Suatu perbuatan dianggap delinquent apabila berlawanan dengan norma-norma yang terdapat pada masyarakat di mana ia hidup, sebuah perbuatan yang anti sosial yang mengandung unsur anti normatif,” demikian menurut Sudarsono yang mendefinisikan kenakalan remaja.

Anak-anak atau remaja yang mendekati masa pubertas dan terlibat dalam perilaku yang menentang norma-norma dan konvensi sosial yang berlaku adalah mereka yang sedang dibahas dalam periode ini. Itulah yang dimaksud dengan kenakalan.

Masalah kenakalan remaja menjadi semakin signifikan di Indonesia. Keadaan seperti itu tidak diragukan lagi memberikan insentif yang kuat bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Pemerintah sebagai lembaga penyuluhan, lembaga penegak hukum seperti polisi, organisasi pendidikan di lingkungan sekolah, dan, dari sudut pandang yang paling dekat, keluarga, adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk hal ini.

Remaja yang berperilaku tidak selaras dengan norma-norma masyarakat merupakan hal yang umum terjadi di kota-kota besar di Indonesia, layaknya Jakarta, Bali, Yogyakarta, Semarang, Tangerang Selatan, Bandung, serta Surabaya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kota-kota besar berkembang jauh lebih cepat daripada kota-kota kecil atau bahkan daerah pedesaan. Ada juga perbedaan dalam ikatan sosial yang terbentuk. Kebutuhan alamiah remaja untuk belajar tentang

segala sesuatu di sekitar mereka mengarah pada perkembangan interaksi sosial di antara mereka.

Pertumbuhan hubungan sosial ini juga memperhitungkan bagaimana seorang individu beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti bagaimana mereka mengembangkan loyalitas terhadap kelompok atau organisasinya, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka makan dan minum secara mandiri, dan bagaimana mereka mengikuti aturan. Namun, karena rasa ingin tahu mereka yang besar dan proses pencarian jati diri yang terjadi saat menjadi remaja atau dewasa muda, mereka sering kali tidak ingin mematuhi peraturan karena hal itu dapat membuat kelompok mereka merasa bangga. Mayoritas dari mereka bermula dari keluarga yang kurang memperoleh kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Mungkin saja kedua orang tua sibuk dengan pekerjaan mereka, sering bertengkar, bahkan bercerai.

Remaja sering kali membuat keputusan yang buruk ketika memilih jalan hidup mereka dalam upaya untuk memfokuskan energi psikologis mereka untuk mendapatkan perhatian, persetujuan, dan pengakuan dari orang lain. Remaja yang hidup dalam situasi seperti ini cenderung melakukan kejahatan, kekerasan, pembunuhan, pelecehan, pencurian, pemerasan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, dan bahkan perampokan.

Tidak diragukan lagi bahwa beberapa pihak perlu memberikan perhatian terhadap kenakalan remaja. Menurut beritatangsel.com, Pada hari Minggu, 6 November 2017, Tangsel Zulham Firdaus, ketua Bamus (Badan Musyawarah), mengadakan acara bakti sosial di Serpong. Zulham Firdaus menegaskan bahwa "karena anak sekolah dan organisasi dapat bertemu dan bekerja sama untuk menurunkan prevalensi kenakalan remaja, Dalam rangka membantu menurunkan angka kenakalan anak sekolah yang sebagian besar adalah remaja, Bamus berharap kegiatan ini akan menumbuhkan hubungan yang positif antara sekolah dan organisasi Bamus.

H. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Setiap negara memiliki definisi kenakalan remaja yang berbeda, oleh karena itu konsep ini dipandang secara luas. Kenakalan remaja mencakup spektrum yang luas dari perilaku nakal, mulai dari kejahatan seperti mencuri dan merusak hingga perilaku yang tidak diinginkan secara sosial seperti menyebabkan masalah di sekolah. John W. Santrock menyatakan bahwa "pembagian pelanggaran dibuat menjadi 2 jenis untuk kenyamanan hukum:"

1. Terlepas dari apakah pelakunya adalah orang dewasa atau remaja, kejahatan indeks adalah tindakan kriminal. Kejahatan ini terdiri dari pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan brutal, dan perampokan. Dibandingkan dengan

kejahatan lainnya (seperti penyerangan, penyalahgunaan narkoba, atau gangguan perdamaian), pelanggaran properti memiliki prevalensi yang lebih besar.

2. Pelanggaran yang lebih ringan adalah pelanggaran status, yang meliputi pembolosan, melarikan diri dari rumah, minum-minuman keras di bawah umur, hubungan seksual, dan perilaku yang tidak dapat diatur. Hanya jika dilakukan oleh anak di bawah umur tertentu, pelanggaran tersebut dilarang.

Namun, terlepas dari semua masalah kenakalan remaja di Indonesia, sistem hukum negara ini sebenarnya telah memberlakukan undang-undang. Sejumlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur prosedur hukum dan isi hukum yang berkaitan dengan remaja, atau anak di bawah umur. "Pasal 45 menyatakan bahwa mereka yang bersalah harus diserahkan kepada pihak yang berwenang ketika:

1. Anak yang dibawah umur tersebut melakukan kejahatan. Jadi menurut Hukum Pidana Indonesia perbuatan tersebut merupakan delik yang termuat dalam Buku Kedua KUHP, dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Anak di bawah umur tersebut melakukan salah satu pelanggaran dalam Buku Ketiga antara lain:
 - a. Bab I tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang
 - b. dan kesehatan, meliputi Pasal 489, 490, 492, 496, dan 497.
 - c. Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum, meliputi Pasal 503, 505, 514, 517, dan 519.
 - d. Bab III tentang pelanggaran terhadap penguasa umum meliputi Pasal 526.
 - e. Bab V tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan meliputi Pasal 531.
 - f. Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan, meliputi Pasal 532, 536, dan 540.

Keresahan yang ditimbulkan oleh meningkatnya kriminalitas remaja di kota-kota besar tidak diragukan lagi menarik perhatian masyarakat juga. Tidak diragukan lagi, masyarakat memiliki peran dalam menghasilkan generasi muda yang berakhlak mulia dan produktif. Untuk mendidik atau bahkan memerangi kenakalan remaja, masyarakat juga terlibat. Selain itu, "keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja dapat berupa:" kata Sudarsono.

- a. Tawarkan bimbingan langsung kepada anak yang bersangkutan agar ia berhenti terlibat dalam perilaku yang melanggar standar yang relevan, termasuk standar sosial, hukum, moral, dan agama.
- b. mencari solusi untuk memberi tahu anak tersebut dan berbicara dengan orang tua atau wali yang khawatir.
- c. Agar tindakan pencegahan menyeluruh dapat segera dilaksanakan, masyarakat akhirnya harus memiliki keberanian untuk menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya perilaku kriminal.²⁵

I. Penyebab Kenakalan Remaja

Perilaku yang menyimpang dari rutinitas atau melanggar hukum disebut sebagai kenakalan remaja. Jensen, yang dikutip oleh Sarlito W. Sarwono dalam bukunya Psikologi Remaja, mengkategorikan kenakalan remaja ke dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan bentuk-bentuk kenakalan lain yang mengakibatkan cedera fisik pada orang lain adalah contohnya.
2. Kenakalan yang merugikan secara materi termasuk pencurian, pemerasan, perusakan, dan lain-lain.
3. Prostitusi dan penyalahgunaan obat terlarang merupakan contoh kenakalan sosial yang tidak mengakibatkan korban pada orang lain.
4. Kenakalan berbasis posisi mencakup hal-hal seperti meningkari posisi anak sebagai pelajar dengan membolos, meningkari status orang tua dengan meninggalkan rumah atau tidak mematuhi perintah orang tua, dan lain sebagainya. Tindakan mereka pada usia ini belum merupakan pelanggaran hukum yang nyata karena yang dilanggar adalah kedudukan mereka di lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah), yang tidak secara khusus diatur oleh hukum. Namun, anak tersebut dapat melakukan kejahatan status ini terhadap atasannya di tempat kerja atau penegak hukum setempat jika dia sudah dewasa. Jensen mengkategorikan pelanggaran status ini sebagai kenakalan dan bukan hanya perilaku menyimpang karena hal ini.²⁴

J. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja

Juvenile Delinquency atau kenakalan remaja tidak serta merta muncul dengan sendirinya. Munculnya kenakalan remaja terdapat sebabnya, diantaranya:

1. Lingkungan keluarga

Unit sosial terkecil yang menjadi dasar utama perkembangan anak adalah keluarga. Selain itu, keluarga memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian anak. Keluarga juga dipandang sebagai institusi yang dapat

memenuhi kebutuhan manusia, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian.²⁵

2. Lingkungan sekolah

Setelah keluarga, sekolah merupakan tempat kedua untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah adalah lembaga pendidikan resmi yang menyelenggarakan program pelatihan, pengajaran, dan bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dalam hal intelektual, emosional, sosial, dan moral-spiritual.

3. Lingkungan masyarakat

Remaja adalah anggota masyarakat dan mungkin secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan dan status masyarakat. Faktor utamanya adalah perubahan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal seperti daya saing ekonomi, pengangguran, media, dan berbagai peluang waktu luang, yang semuanya sering dikaitkan dengan risiko kejahatan yang lebih tinggi.

K. Penutup

Penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial dan internal, sistem pendidikan, dialog dengan anak, suasana psikologis, sosiokultural, perilaku yang diperlihatkan saat bertemu dengan anak, kontrol terhadap perilaku anak, dan penentuan nilai moral sebagai landasan perilaku dan apa yang dikejar oleh anak adalah contoh-contoh upaya orang tua yang diaktualisasikan dalam konteks pengasuhan.

Pengasuhan anak saat ini berfungsi sebagai penghalang terhadap perilaku menyimpang anak di masa depan. Semua faktor yang mempengaruhi bagaimana anak-anak mengembangkan karakter mereka harus diperhitungkan dengan cermat untuk mencegah masalah yang lebih serius selama masa puber, seperti ketidaktaatan, kurangnya disiplin, dan perilaku abnormal lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan setiap orang tua, yaitu lahirnya generasi mandiri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kesadaran diri, pola asuh orang tua harus sesuai dengan kebutuhan anak.

Untuk membantu anak menjadi mandiri, tumbuh dan berkembang secara maksimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi pada kesuksesan, orang tua mendorong anak dengan mengubah perilaku, pengetahuan, dan nilai-nilai mereka dengan cara-cara yang dianggap paling tepat oleh orang tua. Hal ini dikenal sebagai pengasuhan.

Dalam hal pendidikan, keluarga adalah lingkungan pendidikan awal anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak secara signifikan dipengaruhi oleh sikap dan tindakan semua orang tua dalam keluarga. Perilaku anak secara langsung dan kuat

dipengaruhi oleh peran orang tua dalam keluarga. Kasih sayang orang tua diperlukan karena orang tua ingin anak-anak mereka berhasil, mencapai tujuan mereka, bergaul dengan orang lain, dan tidak terus-menerus terlibat dalam masalah.

Masa remaja merupakan masa transisi yang sering disebut sebagai masa adolescence. Masa transisi ini dapat memicu terjadinya krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Dalam beberapa keadaan, perilaku menyimpang ini akan berubah menjadi perilaku yang mengganggu jika didorong oleh lingkungan yang tidak kondusif; akibatnya, hal ini akan mengarah pada terciptanya perilaku menyimpang lebih lanjut dan kegiatan berbahaya yang bertentangan dengan norma dan peraturan sosial.

Tindakan remaja juga akan berdampak pada sikap atau perilaku mereka. Karena pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian remaja secara utuh, bukan hanya kecakapan akademisnya saja. Pengawasan orang tua sangat penting di sepanjang tahap perkembangan anak karena ini adalah langkah pertama dalam mendidik mereka. Hal ini serupa dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari ketika pengaruh eksternal membentuk kepribadian seseorang. Kehidupan bermasyarakat juga membantu orang tua dalam proses pengembangan kepribadian anak. Pengajaran perilaku sosial anak merupakan bidang lain yang menjadi tanggung jawab masyarakat.

Referensi

- Adristinindya utami dan Santoso R, (2021), Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja, Jurna Pekerjaan Solsial, Universitas Padjajaran.
- Ahmad Susanto, (2015). Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-Kanak. Jakarta : Prenada Media.
- Ali, M., & Ansori, M. (2018). Psikologi Remaja. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baumrind. 2017. Pola Asuh Orang Tua. Jakarta: Balai Cipta.
- Fatmawati, E., Ismaya, E. A., & Setiawan, D. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Anak Pada Pembelajaran Daring. Jurnal Educatio FKIP UNMA.
- Haryanti, D., Pamela, E. M. and Susanti, Y. (2016) „Perkembangan Mental Emosional Remaja Di Panti Asuhan”, Jurnal Keperawatan Jiwa, 4(2), pp. 97– 104
- Hamidah, R. N., & Rosidah, N. S. (2021). Konsep kesehatan mental remaja dalam perspektif Islam. *Prophetic Guidance and Counseling Journal*, 2(1),
- Kementerian Kesehatan. (2018). Hasil utama riskesdas
- Nyoman S, 2021. Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan Anak. Bandung : Nilacakra.
- Saiful D, 2018. Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga. Jakarta : PT Rineka Citra.
- Saputra, F., Jurisa, E., & Iskandar, I. (2020). Masalah Psikososial pada Remaja di Sekolah Asrama di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. *Khatulistiwa Nursing Journal*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.53399/knj.v2i1.15>
- Nasrudin, N. (2013). Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Terhadap Kecerdasan Emosional Remaja. *Jurnal EduHealth*, 3(2), 244799
- Winarti. 1992. Pola Asuh Orang Tua. Jakarta: Gramedia.

BAB IV

MENCEGAH PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL REMAJA AWAL DENGAN BIMBINGAN KELOMPOK TENTANG PENDIDIKAN SEKS ISLAMI DI SEKOLAH

A. Pendahuluan

Perilaku penyimpangan seksual merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi remaja. Perilaku seksual menyimpang (sexual deviation) disebut juga perilaku seksual yang abnormal atau tidak wajar dan memiliki kecenderungan dapat mengarah ke kejahatan seksual (Suherman, 2013), diantaranya homoseksual (gay dan lesbian), transexualist, sodomi, exhibisionism, dan sebagainya. Perilaku seksual yang tidak normal tersebut biasanya dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual, dan cenderung akan menimbulkan berbagai masalah jika tidak diatasi, seperti melanggar norma dan hukum, serta mengganggu kehidupan pribadi dan sosial. Dalam hal ini, remaja atau anak yang mendekati usia baligh (remaja awal usia 10-12 tahun) merupakan kelompok yang berisiko mengalami penyimpangan seksual, tapi mereka sering tidak menyadarinya (Madani, 2014).

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual pada remaja yaitu pengalaman traumatik, tingkat pemahaman agama, tingkat kepercayaan diri, biologis, pengetahuan dan orientasi seksual, perilaku seks bebas, perceraian orang tua, komunikasi dalam keluarga, mengikuti tren, interaksi dengan pelaku seks menyimpang, pendidikan seks dan paparan media pornografi (Sumadi, 2012; Aini, 2011; Darmasih, 2009; Supriyanto, 2011; Hana, 2014; Haryani, 2012).

Sebagaimana keterangan bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres di salah satu kota di Jawa Timur, pada tahun 2014 sampai tahun 2024, tercatat bahwa angka penyimpangan seksual pada anak dan remaja awal semakin meningkat, rata-rata 12 kasus per tahun, diantaranya sodomi dan sadism, yang ditemukan bersama dengan kejadian kekerasan atau pelecehan seksual. Seperti fenomena gunung es, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan keterangan yang diperoleh dari salah satu relawan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Gubug Sebaya, sebuah komunitas beranggotakan 300 lebih anak, remaja dan dewasa dengan penyimpangan seksual seperti homoseksual, transeksual dan biseksual yang berasal dari beberapa kota penyangga sekitar Surabaya. Sejak berdiri tahun 2013 sampai kini, mereka masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial, namun disisi lain, sebagian besar anggotanya sudah terlibat dalam

aktivitas berisiko (50% lebih adalah perempuan), seperti mengarah ke seks bebas dan semakin sulit untuk dikoordinasikan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara acak pada puluhan siswa kelas 4 sampai 6 sekolah dasar berbasis Islam, didapatkan data bahwa 43% siswa mengatakan pernah buang air atau ganti baju bersama teman yang berjenis kelamin sama, mengetahui bahwa homoseksual adalah penyimpangan seksual, dan lebih nyaman curhat dengan teman, sedangkan 86% sengaja atau tidak sengaja telah terpapar tayangan bermuatan pornografi dan tidak tahu cara mencegah terjadinya penyimpangan seksual, serta 14% mengatakan mencari info tentang seksual melalui internet dan menyimpan rasa penasaran tentang seksual tanpa cerita dengan siapapun (diam saja).

Bertolak dari gambaran data diatas, maka memahami pertumbuhan dan perkembangan seksual remaja sangatlah penting untuk mengetahui kesiapannya mendapatkan edukasi. Menurut Suherman (2013), pada masa remaja awal (10-12 tahun), hormon memberi perubahan yang tidak hanya terjadi pada bentuk fisik (pertumbuhan), melainkan psikologis, sosial, pola pikir dan seksual (perkembangan), termasuk mengenal perasaan jatuh cinta. Dalam hal ini, ternyata remaja perempuan lebih cepat pertumbuhan dan perkembangan seksualnya dibanding pria, organ reproduksinya pun membutuhkan perawatan yang lebih kompleks. Selain itu, remaja awal cenderung sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual dan berpikirnya rasional (harus dapat diterima akal, maka pertanyaannya cenderung kritis, dan salah satu tugas perkembangannya adalah belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, sehingga ingin menyelesaikan sesuatu tanpa pengaruh orang tua (Yusuf, 2010).

Untuk itu, bimbingan perilaku seksual pada remaja awal dengan pendekatan agama (islami) menjadi pilihan tepat ditengah maraknya pemahaman anak yang dangkal tentang pergaulan dan seksual akibat pola asuh orang tua yang belum memfasilitasi kebutuhan pendidikan seksual anak (Takariawan, 2012), sehingga penyimpangan seksual pada fase perkembangan dan pertumbuhan berikutnya dapat dicegah. Pendidikan seks yang dimaksud, dapat berupa adab memasuki kamar orang tua, mengenal najis dan cara bersuci, menghindari rangsangan seksual, mempersiapkan baligh, menjaga kehormatan, mengenal mahram, mengenal zina (etika melihat, bergaul dengan lawan jenis, aurat dan hijab) (Ulwan, 2011).

Adapun alasan pendidikan seks diberikan melalui bimbingan kelompok di sekolah, karena menurut Winarno (2009), hal ini dapat membangun kepercayaan diri remaja. Mengingat pula bahwa remaja tidak dapat dipisahkan dari pergaulan teman sebayanya (Potter, 2005) dan merasa bahagia jika dihargai dan diterima dalam kelompoknya (Yusuf, 2010), serta selalu ingin terlihat up to date atau mengikuti tren (Hana, 2014), sehingga akan berbahaya bila tren yang diikuti adalah merupakan penyimpangan dan tidak ada yang mengarahkan. Di dalam proses

bimbingan kelompok di sekolah, siswa akan mendapatkan bimbingan secara sadar dengan keinginan sendiri dalam mengenali dirinya sebagai manusia, perilaku dan lingkungan yang berisiko, serta memutuskan sendiri upaya antisipasi atau pencegahannya (Kurnanto, 2013).

B. Masalah Perilaku Penyimpangan Seksual Remaja Awal

Penyimpangan seksual atau parafilia adalah suatu perilaku seksual yang menyimpang dari masyarakat umum, dikenal juga sebagai deviasi seksual, yaitu perilaku yang tidak biasanya dilakukan, dan atau perilaku seksual yang dianggap bermasalah (Hana, 2014). Jadi, perilaku seksual yang tidak dapat diterima dalam norma sosial dapat dikategorikan sebagai penyimpangan seksual. Sebagaimana fenomena penyimpangan seksual pada remaja awal yang telah digambarkan dalam sub bab pendahuluan di atas, berikutnya akan dijelaskan jenis perilaku menyimpang seksual, faktor yang mempengaruhi, dan dampaknya.

1. Jenis Perilaku Menyimpang Seksual

Sebetulnya terdapat ratusan jenis perilaku seksual menyimpang yang ada di dunia, beberapa diantaranya menurut Hana (2014) yaitu, Sadism dan Masochis (hanya bisa mendapatkan kepuasan seks dengan lebih dulu menyiksa atau disiksa oleh pasangan secara fisik maupun psikis), Exhibitionisme (hanya bisa mendapatkan kepuasan seks dengan mempertontonkan kelaminnya di depan orang lain yang tidak ingin melihatnya), Transsexualist (merasa dirinya memiliki jenis kelamin yang berlawanan dari fisiknya), Voyeurisme dan Scopophilia (hanya bisa mendapatkan kepuasan seks dengan mengintip atau melihat), Fetishisme (menjadikan suatu benda sebagai objek seksualnya), Pedophilia (hanya bisa mendapat kepuasan seks dengan melakukan hubungan seks dengan anak-anak), Bestiality dan Zoophilia (menyukai hubungan seks dengan binatang), Pornography (lebih menyukai melihat gambar atau video bermuatan seksual dari pada melakukan koitus normal dengan pasangan), Incest (hubungan seksual diantara dua orang sedarah yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam perkawinan), Saliromania (mendapat kepuasan seks dengan mengotori badan, pakaian atau simbol wanita (semacam patung, dan lain-lain) dengan sesuatu, seperti tinta, air, sampah, dan lainnya), Frottage (mendapatkan kepuasan seksual dengan meraba orang yang disengangnya tanpa diketahui oleh si korban), dan masih banyak lagi lainnya.

Berdasarkan uraian jenis-jenis perilaku menyimpang seksual di atas, sebagian besar orang tua mungkin akan berpikir bahwa seperti mustahil anak-anak mereka yang baru beranjak remaja akan berbuat sejauh itu, sehingga kewaspadaan orang tua terkait isu penyimpangan seksual ini tidak sebesar perhatiannya terhadap isu kesehatan reproduksi lainnya, seperti seks bebas, KTD

(kehamilan tidak diinginkan), aborsi, HIV/ AIDS atau semacamnya. Padahal, perilaku penyimpangan seksual tersebut dapat menjadi pintu masuk dari banyak permasalahan kesehatan reproduksi yang selama ini dikhawatirkan oleh orang tua, sehingga penting untuk tidak tutup mata terhadap berbagai informasi yang berkembang terkait dunia kesehatan reproduksi pada remaja awal, sekecil apapun itu, sebelum terlambat.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang Seksual

Perilaku menyimpang seksual tentu tidak terjadi begitu saja, pasti ada hal-hal yang menjadi penyebab, alasan, pemicu atau mendorong terjadinya perilaku tersebut, tetapi juga ada kondisi dan upaya yang dapat mencegah atau menghambat berkembangnya perilaku menyimpang seksual. Setidaknya terdapat empat belas faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang seksual remaja awal, yaitu berupa faktor internal yang meliputi pengalaman traumatik, tingkat pemahaman agama, pengetahuan tentang seksualitas, tingkat kepercayaan diri, orientasi seksual, kondisi biologis, dan seks bebas. Sedangkan yang berupa faktor eksternal diantaranya, perceraian orang tua, komunikasi dalam keluarga, interaksi dengan individu pelaku penyimpangan seksual, mengikuti tren, keterpaparan media informasi, pendidikan seks islami, dan bimbingan kelompok.

Pertama, faktor pengalaman traumatik, pada remaja lesbian ditemukan pengalaman traumatik saat menjalani hubungan heteroseksual dan mengalami kekerasan rumah tangga. Pengalaman hubungan heteroseksual yang di temukan berupa mendapat perlakuan kasar, diselingkuhi dan selalu patah hati. Dari ketiga pengalaman traumatik tersebut menimbulkan respon psikologis pada partisipan, yaitu berupa rasa kecewa, dendam, hingga jera untuk menjalin hubungan heteroseksual kembali. Dampak berkepanjangan ini tentu saja akan mempengaruhi pada proses tumbuh kembang pada remaja dalam mencapai identitas dirinya (Sumadi, 2012).

Kedua, faktor tingkat pemahaman agama juga berpengaruh terhadap perilaku seks pranikah pada remaja (Darmasih, 2009), tentu saja hal ini juga berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan seksual. Remaja yang memiliki tingkat pemahaman agama yang baik akan cenderung memiliki perilaku seks bebas yang rendah (Aini, 2011), sedangkan menurut Hayati (2012), bahwa kematangan beragama berpengaruh terhadap sikap sosial remaja. Keyakinan dan ketaatan beragama dapat menjadi benteng dari perbuatan maksiat, maka Islam memberikan bimbingan seksualitas mencakup upaya preventif dan protektif (Asror, 2013).

Ketiga, faktor pengetahuan tentang seksualitas, yang merupakan dasar dari perubahan sikap dan perilaku yang bertahan lama (long lasting), sehingga setiap

tindakan secara sengaja atau tidak pasti menggambarkan bagaimana pengetahuannya. Darmasih (2009) juga meneliti pengaruh pengetahuan terhadap perilaku seks bebas pada remaja dan hasilnya signifikan, Cindra (2013) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan remaja tentang HIV/ AIDS dengan perilaku seksualnya.

Keempat, faktor tingkat kepercayaan diri, dimana sebuah kepercayaan diri merupakan faktor pengaruh yang paling kuat terhadap perilaku seksual remaja (Suryoputro, 2006). Senada dengan tulisan Hana (2014), bahwa bersikap tegas dengan menunjukkan sikap percaya diri dapat menghindarkan anak dari tindak kekerasan seksual, ini penting untuk pencegahan jangka panjang, karena sebagian besar korban Sodomi akan melakukan hal sama dikemudian hari. Kepercayaan diri juga tergambar dari penerimaan individu terhadap gendernya, karena jika individu justru merasa bahagia dengan gender orang lain yang berbeda, lalu menganggap apa yang dimilikinya tidak membuatnya lebih baik, maka dapat mengarahkan remaja pada penyimpangan seksual (Supriyanto, 2011).

Kelima, begitupun dengan faktor orientasi seksual. Orientasi seksual sesama jenis dapat terjadi sejak kecil, jadi tidak pernah ada ketertarikan sama sekali dengan lawan jenis (Hana, 2014). Jika orientasi ini diyakini terus menerus sampai usianya dewasa akan mengarah pada homoseksual, baik gay maupun lesbi. Namun, biasanya untuk menutupi perilakunya yang menyimpang, homonis akan tetap berusaha memiliki pacar atau menikah, karena secara fungsi seksual tidak akan berubah, hanya kepuasan seksualnya kurang terpenuhi.

Keenam, faktor biologis (genetik dan hormonal). Secara biologis atau fisik, peranan genetik dan hormonal memang cukup besar dalam menentukan fungsi reproduksi dan hasrat seksual. Menurut Hana (2014), seseorang yang memiliki orientasi seks sesama jenis karena adanya potensi yang dibawanya sejak lahir (genetik). Hormon memberi perubahan terhadap bentuk fisik, psikologis, sosial, pola pikir, dan seksual, serta saling berkaitan. Fungsi hormon dapat dipengaruhi oleh status nutrisi dan stimulus dari lingkungan, masing-masing individu berbeda. Hormon ini juga merangsang sebuah proses kimiawi yang memiliki unsur amphetamine, dopamine, neropylathylamine, dan yang paling penting adalah phenylathylamine, yang keberadaannya dapat berperan dalam munculnya perasaan suka pada lawan jenis atau sesama jenis.

Ketujuh, ada juga faktor seks bebas, dimana kehidupan yang bebas dengan free sex menyebabkan banyak kerugian, menarik diri dari lingkungan karena malu sampai kecanduan melakukan aktivitas itu. Dampak yang banyak terjadi pada remaja adalah kehamilan diluar nikah atau kehamilan tidak diinginkan (KTD), kelainan seksual dan penyimpangan seksual (Suherman, 2013).

Kedelapan, faktor perceraian orang tua, yang menurut Hurlock (2007) dalam Sumadi (2012) bahwa dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak, salah satunya yaitu anak kurang kasih sayang. Hal ini menyebabkan mencari kasih sayang lain di luar rumah. Dengan demikian, pertengkaran orang tua di depan anak dan atau perceraian orang tua bisa menyebabkan anak kurang kasih sayang baik dari ibunya maupun dari ayahnya. Kurangnya kasih sayang anak dari ibu ataupun kurangnya peran ayah akibat perceraian tadi bisa mengarahkan anak tumbuh menjadi lesbian.

Kesembilan, faktor komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu dari komponen pola asuh orang tua terhadap anaknya. Prihartini (2002) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara sikap terhadap pergaulan bebas pada remaja awal perempuan dan laki-laki dengan komunikasi efektif tentang seksualitas dalam keluarga. Semakin tinggi komunikasi efektif tentang seksualitas dalam keluarga yang diberikan maka akan semakin tinggi pula sikap remaja awal perempuan maupun laki-laki terhadap pergaulan bebas antar lawan jenis. Sedangkan Supratiwi (2006) menyatakan bahwa ada hubungan antara efektifitas komunikasi orang tua dengan perilaku seks pranikah pada remaja.

Kesepuluh, faktor interaksi dengan individu pelaku penyimpangan seksual juga berpengaruh. Mengingat remaja sangat suka bergaul, bersosialisasi dengan remaja sebayanya, bahkan terkadang dengan yang lebih muda atau dewasa hanya demi mendapatkan pengakuan, maka pemahaman bergaul yang didasari oleh pemahaman agama dapat mencegah terjadinya perilaku seksual menyimpang (Yusuf, 2009).

Kesebelas, faktor mengikuti tren, dimana mengikuti tren pergaulan di lingkungan sosial anak dapat mengalihkan perilakunya menjadi menyukai sesama jenis, padahal sebelumnya orientasi seksualnya hetero (Hana, 2014). Interaksi yang intens dengan teman sebaya dimungkinkan berpeluang lebih besar dalam membentuk karakter anak, apalagi jika keluarga tidak dapat memenuhi fungsi afektifnya, anak akan mencari kenyamanan bersama komunitas yang lebih mengakui dan menerima kondisinya. Sumadi (2012) menemukan bahwa remaja perempuan normal jika sering berkumpul dengan komunitas lesbian bisa menjadi lesbian juga, apalagi dengan remaja perempuan yang memiliki latar belakang traumatik kekerasan semasa kecil dan/ atau pengalaman traumatik hubungan heteroseksual.

Kedua belas, ada faktor keterpaparan media informasi, dimana Nuryani (2011) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keterpaparan media informasi tentang seks dengan perilaku seks remaja. Penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa pornografi sangat berdampak terhadap perilaku seksual remaja, dalam hal ini guru atau pendidik belum optimal (rendah) dalam

mengupayakan pencegahan agar siswa tidak mengakses pornografi (Haryani, 2012), maka kapasitas guru maupun konselor harus memadai dan dapat memuaskan kebutuhan informasi remaja, agar tidak mencari sendiri dari media yang riskan terhadap pornografi.

Ketiga belas, pendidikan seks islami. Pendidikan seksual dapat dilakukan sejak dini untuk mencegah perilaku menyimpang seksual, karena seseorang memerlukan kontrol diri terhadap perilaku seksualnya (Purnamasari, 2010). Penghormatan satu pihak dengan yang lain (antara laki-laki dan perempuan) sehingga tidak terjadi dominasi laki-laki atas perempuan adalah kesadaran gender yang harus ditumbuhkan. Pada masa remaja, rasa ingin tahu terhadap masalah seksual sangat penting dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis (Takariawan, 2012). Pendidikan seks islami didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan bagian dari pendidikan akhlak, dapat digunakan sebagai upaya mencegah anak dari pengaruh seksual negatif dengan keimanan yang kuat (Jamin, 2008).

Keempat belas, faktor bimbingan kelompok, dimana penerapan bimbingan kelompok ternyata dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang seks bebas (Putri, 2013). Bimbingan kelompok juga dapat membangun kepercayaan diri remaja (Winarno, 2009). Bimbingan Secara berkelompok dengan usia sebaya, jumlah yang tidak terlalu besar dan kapasitas yang homogen serta tema yang menarik serta sesuai kebutuhannya, dapat membuat remaja nyaman dan prosesnya akan berjalan lebih efektif.

3. Dampak Perilaku Menyimpang Seksual

Penyimpangan seksual pasti cepat atau lambat akan memberikan dampak bagi pelakunya, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Menurut beberapa sumber, sedikitnya tercatat lima dampak yang paling sering terjadi yaitu, pertama, PMS (HIV/ AIDS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi, depresi, dan penyalahgunaan NAPZA.

Pertama, Penyakit Menular Seksual (PMS) dikenal juga dengan sebutan Sexually Transmitted Diseases (STD), yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual yang dilakukannya (Hana, 2014). AIDS berjalan sangat lambat, gejala baru tampak setelah beberapa tahun sebelumnya terinfeksi HIV, sebagaimana kasus HIV/ AIDS yang terjadi di salah satu kota di Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan beberapa kasus telah terdeteksi pada usia 14 tahun (remaja), artinya individu tersebut telah terpapar HIV saat usia anak-anak. Hal ini mendorong perilaku pencegahan penting dilakukan saat anak mulai aktif bersosialisasi bersama kelompok dan siap menerima pengajaran, yaitu antara 7-12 tahun).

Kedua, menurut Kamus Istilah Keluarga Berencana, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) adalah kehamilan yang dialami oleh seorang ibu yang sebenarnya belum menginginkan atau sudah tidak menginginkan untuk hamil lagi. Ada beberapa alasan untuk tidak menginginkan kehamilan antara lain karena perkosaan, kurang pengetahuan yang memadai tentang kontrasepsi, terlalu banyak anak, alasan kesehatan, janin cacat, usia muda atau belum siap menikah, pasangan tidak bertanggungjawab atau hubungan dengan pasangan belum mantap, kendala ekonomi, dan lainnya (WHO, 2000). Sebagaimana hasil wawancara pada pihak-pihak berwenang, kasus KTD pada remaja meningkat setiap tahun akibat seks bebas dan kekerasan seksual.

Ketiga, aborsi adalah keluarnya janin pada kehamilan usia 0 hingga 20 minggu. Abortus artinya hasil pembuahan (janin) yang dikeluarkan secara sengaja atau tidak, sebelum janin tersebut dapat hidup dalam kandungan (Supriyanto, 2011). Berdasarkan definisinya, aborsi dibedakan menjadi dua, yaitu aborsi spontan (aborsi yang tidak disengaja atau keguguran) dan aborsi buatan (aborsi yang dilakukan dengan sengaja). Untuk aborsi buatan dibagi lagi menjadi dua, yaitu aborsi medisinalis atau aborsi yang dilakukan karena indikasi medis dan aborsi kriminalis atau aborsi yang dilakukan tanpa adanya alasan medis (Hana, 2014). Aborsi kriminalis inilah yang tercatat meningkat seiring kasus KTD di beberapa daerah.

Keempat, depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta bunuh diri. Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai oleh hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif adanya penderitaan berat. Mood adalah keadaan emosional internal yang meresap dari seseorang, dan bukan afek, yaitu ekspresi dari isi emosional saat itu (Geldard, 2012). Remaja awal ingin sembuh atau kembali pada kondisi normal seperti sebelumnya terkadang mengalami tarik ulur terkait perasaannya. Proses yang tidak mudah tersebut, dapat menimbulkan keputusan sampai depresi jika tak kunjung menemukan jalan keluar. Bagaimanapun, perilaku menyimpang ini secara sadar akan menjadi beban bagi remaja, karena bertentangan dengan nurani atau sifat alamiah individu manusia.

Kelima, penggunaan NAPZA, dimana pemakaian obat terlarang pada remaja ditentukan oleh banyak penyebab, tidak ada satu penyebab tunggal yang pasti, kebanyakan efek cenderung bersifat kumulatif (mengalami resiko jangka panjang dan efeknya lebih lama dengan kondisi semakin memburuk), faktor resiko diantaranya secara individual yang antisosial, trauma, atau gangguan kesehatan secara mental, sedangkan faktor dari keluarga biasanya karena adanya kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), pola komunikasi, pola asuh atau kurangnya monitoring dari orang tua. Risiko sebaya berhubungan dengan kelompok sebaya yang memakai NAPZA dan menyediakan akses ketersediaan, koping maladaptif, jaringan sosial dan norma yang dibentuk dalam kelompok remaja itu sendiri, sedangkan sekolah dan masyarakat juga dapat menjadi faktor risiko (Geldard, 2012). Butuh keberanian untuk berperilaku 'berbeda' dari remaja pada umumnya, sehingga kerap kali NAPZA dianggap mampu membantu menumbuhkan dan mempertahankan nyali mereka dalam melakukan penyimpangan.

C. Urgensi dan Manfaat Pendidikan Seks Islami bagi Remaja Awal

Pendidikan seks islami adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang seksualitas individu sebagai fitrah manusia dan hubungan etis dengan manusia lain, mengutamakan akhlak melalui penyadaran, peringatan, pengikatan dan pembiasaan berdasarkan Al- Qur'an dan Hadist (Asror, 2013). Pandangan Islam terhadap pendidikan seksual bagi remaja tidak hanya mengajarkan mengenai fakta-fakta biologis semata, tetapi juga memberikan penerangan yang jelas mengenai adab, keteladanan, pembiasaan, nasihat, hukum peringatan dan petunjuk praktis dalam menyelenggarakan kehidupan sehari-hari (Sasmita, 2010).

Adapun keutamaan dan manfaat diberikannya pendidikan seks islami yakni, bahwa seks harus diajarkan dengan pendamping yang kompeten, agar anak tidak kekurangan informasi seks, yang risiko negatifnya bagi remaja akan mencari kekurangan info tersebut dari teman sebaya atau aneka sumber lain yang justru bermuatan pornografi. Sehingga, memberikan pendidikan seks sebelum beranjak remaja, prinsipnya seperti memberikan imunisasi untuk meningkatkan dan kekebalan sebagai upaya pencegahan agar tidak mudah terserang atau tertular penyakit. Apalagi jika pendidikan seks diperkuat melalui pemahaman spiritual, maka anak akan memiliki pondasi lebih kuat dalam membentengi diri dari pergaulan dan perilaku yang menyimpang (Hana, 2014).

Selain itu, komponen materi dalam pendidikan seks islami berdasarkan buku Ulwan (2011), di dalamnya terdapat pokok bahasan yang dapat dijadikan panduan untuk memberikan pendidikan seks dalam Islam pada remaja, terdapat ada tujuh poin diantaranya, memahami adab memasuki kamar orang tua, mengenalkan mahram, mengenalkan batasan aurat dan etika memandang, menghindari dari rangsangan seksual, mengajarkan ketentuan dan batasan baligh, serta bersuci, menjelaskan tubuh anak, serta memberitahukan penyakit terkait seksual baik fisik, psikis dan sosial.

Pertama, memahami adab memasuki kamar orang tua. Salah satu alasan adab ini diajarkan adalah untuk melindungi anak-anak (sebelum mencapai usia baligh) dalam rumah dari kemungkinan melihat sesuatu yang mempengaruhi libido seksual, serta persoalan seks yang tidak dapat dimengerti karena akalunya masih

lemah dan pengalamannya dalam urusan ini sangat sedikit, sebagaimana QS. An-Nuur : 58. Maka, sebelum memasuki kamar orang tua, anak diajarkan untuk meminta izin terlebih dulu, memperhatikan kondisi atau waktunya, boleh dengan mengucapkan salam, mengetuk pintu atau isyarat lainnya sampai diperbolehkan masuk.

Kedua, mengenalkan mahram. Mengenalkan mahram bertujuan agar anak terhindar dari incest, yaitu menyukai mahram secara berlebihan sampai ingin menikah dengannya. Sedangkan, setiap perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang memiliki ikatan mahram, apapun alasannya, begitupun sebaliknya. Ada tiga kategori mahram, sesuai QS. An-Nisaa : 22-23, diantaranya, mahram karena hubungan keluarga (nasab), mahram karena perkawinan (mushaaharah), serta mahram karena satu susuan (radha'i).

Ketiga, mengenalkan batasan aurat dan etika memandang. Seorang perempuan tidak boleh memandang lelaki asing (lelaki yang bukan mahramnya) sekalipun tidak bersyahwat, seperti sepupu (anak laki-laki paman, dari bapak dan ibu), dan anak laki-laki bibi (dari bapak dan ibu), suami saudara perempuannya, dan suami bibi (saudara perempuan ibu), sebagaimana QS. An-Nuur : 30-31. Sebagaimana perempuan tidak boleh melihat anggota tubuh perempuan lain, laki-laki juga tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya antara pusar dan lutut, baik ia memiliki hubungan famili maupun tidak, baik muslim maupun nonmuslim. Landasan larangan tersebut ada dalam hadits, "Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu pula perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain." Hal ini dapat menghindarkan perempuan dari fitnah dan rangsangan seksual yang menjadikannya gay atau lesbian, yaitu menyukai dan melakukan hubungan badan sesama jenis.

Keempat, menghindarkan dari rangsangan seksual. Seorang anak yang sudah menginjak usia muraahaqah atau mendekati usia muraahaqah-yaitu ketika seorang anak dalam usia sembilan tahun ke atas-dia dilarang untuk bergaul atau berdekatan, karena sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, hawa nafsunya sudah bisa terpengaruh pada sesuatu yang merangsang, sesuai QS. An-Nuur : 31. Hadits riwayat Bukhari-Muslim juga menjelaskan kewajiban syar'i untuk memisahkan tempat tidur anak mereka ketika sudah berusia sepuluh tahun. Hal ini mencegah mereka saling memandang aurat, terutama saat tidur, syahwat mereka bisa merusak moral.

Kelima, mengajarkan ketentuan dan batasan baligh, serta bersuci. Orang tua atau pembimbing mempunyai kewajiban menerangkan pada anak perempuan yang telah memasuki usia 9 tahun atau lebih (ihtilaam) bagaimana tanda baligh, kapan dia harus mandi besar dan tanggungjawabnya sesuai syara' (aturan Islam). Setelah seorang anak mengetahui hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar, sudah semestinya dia belajar tentang kewajiban-kewajiban, sunnah, dan tata cara mandi

besar. Serta sudah semestinya mereka mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan saat junub agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh agama.

Keenam, menjelaskan tubuh anak (termasuk organ reproduksi dan fungsinya). Mengawali penjelasan tentang tubuh anak dapat dilakukan dengan menunjukkan perbedaan anatomi dan fisiologi tubuh laki-laki dan perempuan yang memiliki keistimewaan masing-masing, hal ini agar anak menerima citra tubuhnya dengan baik. Pertumbuhan ciri seks sekunder juga perlu anak ketahui, termasuk hormon yang juga mempengaruhi emosi atau psikologis selama ia tumbuh menjadi perempuan, karena diharapkan anak dapat membangun kepercayaan diri sendiri untuk mencegah terjadinya transeksual saat remaja atau dewasa kelak. Selain itu, perlu juga dijelaskan penciptaan manusia menurut Al-Qur'an, bagaimana janin terbentuk bertumbuh dan akhirnya keluar dari jalan lahir seorang ibu. Khusus bagi perempuan, perilaku hidup sehat dengan merawat, menjaga dan melindungi alat reproduksinya harus diajarkan secara tepat dan benar, mengingat secara anatomis lebih rumit dan kompleks dibandingkan laki-laki. Seperti mencuci tangan sebelum membersihkan kelamin, tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya, dan tidak memasukkan benda asing atau kotor ke dalam vaginanya (Hana, 2014).

Ketujuh, memberitahukan penyakit terkait seksual baik fisik, psikis dan sosial (penyakit menular, penyimpangan, dan kekerasan seksual). Salah satu prinsip yang digunakan dalam pendidikan seks islami adalah peringatan. Cara ini memberikan gambaran kepada seorang anak tentang kenyataan dampak negatif kesewenang-wenangan dalam menyalurkan hawa nafsu dan tergelincir ke lumpur kejahatan serta kebebasan. Beberapa hal yang sangat berbahaya yang dapat menyeret anak melakukan perzinahan dan berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Bahaya terhadap kesehatan (fisik) seperti penyakit gonorrhoe, sifilis, borok pada kemaluan, bisul bernanah dan ejakulasi dini. Sedangkan bahaya terhadap psikologi dan etika, seperti kelainan orientasi seksual, hyper sex dan sebagainya. Lalu, bahaya secara sosial yang penting dijelaskan juga yaitu terkait dampak abortus, kehamilan tidak diinginkan, pelecehan dan kekerasan seksual yang memiliki dampak secara sosial bagi individu dan keluarganya.

Daripada itu, perlu juga diketahui tentang pengaruh pendidikan seks islami terhadap pencegahan penyimpangan seksual remaja awal. Berdasarkan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang seksual, maka diperlukan upaya perilaku pencegahan yang tidak hanya menguatkan perilaku pencegahan, tetapi juga menanamkan moral, sehingga anak dapat membentengi dirinya kapanpun dan dimanapun seiring bertambahnya kedewasaan. Adapun hasil penelitian Nor (1993) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan tentang seksualitas saja tidak cukup memberi pengaruh signifikan terhadap kejadian penyimpangan seksual, sehingga

Nor (1993) menyarankan diadakan bimbingan kelompok dengan topik keagamaan sebagai upaya mengantisipasi dorongan seksual pada remaja. Berkaitan dengan itu, sejak awal Islam telah memberikan bimbingan tentang seksualitas yang mencakup ajaran yang bersifat preventif yang dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan seksual pada saat anak memasuki usia remaja (Asror, 2013). Sedangkan, definisi pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan, karena pencegahan identik dengan perilaku. Dalam agama Islam, ajaran yang bersifat preventif dimaksudkan sebagai usaha pencegahan agar penyimpangan dan kejahatan seksual tidak terjadi, diantaranya menggolongkan zina sebagai dosa besar yang sangsinya berat, sehingga diharapkan manusia menjauhi diri sejauh-jauhnya dari perbuatan zina tersebut. Berdasarkan hadits Imam Ghazali mengemukakan 147 dosa besar, dua diantaranya terletak pada kemaluan, yaitu dosa zina dan homoseksual (Asror, 2013). Demikian Islam memberikan arahan yang baik, nasihat yang tegas, hikmah yang bijaksana dan tidak mengesampingkan perantara (kolaborasi) untuk memperbaiki dan menyadarkan anak. Pengawasan eksternal yang dapat dilakukan adalah perlindungan dari beberapa pengaruh lingkungan fisik maupun non-fisik yang semakin dekat dan mudah mewarnai kehidupan remaja awal.

D. Kelebihan Bimbingan Kelompok untuk Mengedukasi Remaja Awal

Bimbingan kelompok adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya (Kurnanto, 2013). Konseling kelompok adalah konseling yang terdiri dari beberapa konseli yang bertemu dengan konselor. Dalam prosesnya, konseling kelompok dapat membicarakan beberapa masalah, seperti kemampuan dalam membangun hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan keterampilan dalam mengatasi masalah (Paulline Harrison (2002) dalam Kurnanto (2013)).

Untuk itu, terdapat alasan atau rasional konseling kelompok sebagai lingkungan pencegahan menurut Kurnanto (2013). Kebanyakan konselor dalam mengatur pendidikan dan hampir pada semua lembaga bantuan psikologis, berkonsentrasi pada konseli yang telah mengalami masalah emosional atau akademik. Padahal bagi sebagian siswa baik masalah emosional maupun akademik yang dialaminya merupakan predisposisi kebiasaan belajar mal-adaptif dan sikap buruk, yang pada gilirannya menyebabkan prestasi rendah. Bahkan pada akhirnya secara psikologis mereka cenderung hyper resistant, yakni seperangkat karakteristik mental yang cenderung memunculkan reaksi penolakan terhadap harapan masyarakat. Konseling kelompok seyogyanya bersifat preventif dan pengembangan dengan penekanan pada pencegahan terapeutik masalah emosional atau penyesuaian

siswa. Pencegahan atas kebiasaan akademis mal-adaptif dan sikap yang mungkin berasal dari masalah tersebut akan memungkinkan siswa memperoleh pengalaman pendidikan yang diperlukan sebagai kontribusi positif bagi diri dan masyarakat. Penerapan prosedur konseling kelompok dapat memenuhi kebutuhan individu cenderung berkembang, dirangsang oleh penerimaan lebih baik dari pendekatan preventif untuk menghadapi masalah dan pengakuan yang terus meningkat atas efektivitas konseling kelompok. Penelitian dan pengalaman yang cukup dengan prosedur konseling kelompok terakumulasi untuk mendukung penggunaan pendekatan ini sebagai bagian dari proses membantu individu untuk tumbuh. Sebagai hasil dari penelitian yang luas dan pengalaman dalam konseling kelompok.

Adapun keunggulan konseling kelompok diantaranya, menghemat waktu dan energi, menyediakan sumber belajar dan masukan yang kaya bagi konseli, pengalaman komunalitas dalam konseling kelompok dapat meringankan beban penderitaan dan menentramkan konseli, memenuhi kebutuhan akan rasa memiliki, bisa menjadi sarana untuk melatih dan mengembangkan keterampilan dan perilaku sosial dalam suasana yang mendekati kondisi kehidupan nyata, menyediakan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain, memberikan motivasi yang lebih kuat kepada konseli untuk berperilaku konsisten sesuai dengan rencana tindakannya, dan bisa menjadi sarana eksplorasi bagi remaja awal.

Dalam pada itu, terdapat salah satu pendekatan bimbingan kelompok yang cocok diterapkan dalam memberikan edukasi seksual pada remaja awal, yaitu client centered. Menurut Kurnanto (2013), pendekatan berpusat pada pribadi (person centered approach) disebut juga dengan istilah teori diri (self theory) atau konseling non-directive, menyebutkan bahwa pendekatan ini didasari asumsi bahwa manusia cenderung bergerak ke arah keseluruhan dan ke arah perwujudan diri dan bahwa anggota kelompok sebagai individu dan juga kelompok sebagai keseluruhan itu dapat menemukan arah sendiri dengan bantuan yang minimum dari konselor kelompok atau fasilitator. Pendekatan berpusat pada pribadi menekankan mutu pribadi konselor daripada keterampilan teknisnya dalam memimpin kelompok, karena tugas dan fungsi utama dari fasilitator dengan menciptakan hubungan didasari oleh sikap tertentu seperti pemahaman empatik yang teliti, penerimaan, penghargaan yang positif, kehangatan, perhatian, rasa hormat, keaslian (genuineness), spontan, dan pengungkapan diri (self disclosure).

Berkaitan dengan hal tersebut, Geldard (2012) menuliskan dalam bukunya tentang perilaku berisiko pada remaja yang memerlukan intervensi konseling atau bimbingan kelompok yang efektif bersama teman sebaya, diantaranya bunuh diri dan menyakiti diri sendiri, perilaku konfrontasional, penyalahgunaan substansi, perilaku seksual, kesehatan mental, dan remaja yang termarginalisasi. Dengan demikian, bimbingan kelompok yang dilakukan oleh orang yang cenderung dekat/ dipercaya (seperti guru di sekolah), serta peserta satu kelompok yang relatif setara

atau sebaya, akan efektif dalam upaya mencegah perilaku menyimpang seksual pada remaja awal.

E. Bimbingan Kelompok tentang Pendidikan Seks Islami di Sekolah sebagai Strategi Mencegah Perilaku Penyimpangan Seksual Remaja Awal

Sekolah adalah salah satu sarana strategis dalam memberikan pemahaman yang tepat tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Muatan kesehatan reproduksi telah tertuang pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah, namun penerapannya belum seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan. Agar dapat mencapai tujuan yang optimal, pengajaran yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi sangat perlu dilakukan oleh guru. Untuk itu, guru perlu memahami konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi yang seutuhnya.

Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah memasukkan kesehatan reproduksi remaja sebagai salah satu jenis layanan yang merupakan suatu dan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi. Pada Pasal 11 Nomor 1 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi; dan mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Pada Pasal 12 dijelaskan bahwa pelayanan tersebut dilaksanakan salah satunya melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi pada proses pendidikan formal dan nonformal. Serangkaian aturan telah menunjukkan pentingnya melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja (Kemkes RI, 2022).

Sebagaimana penelitian yang dilakukan pada sebuah sekolah dasar berbasis Islam yang ada di daerah Jawa Timur, dimana sekolah ini sudah menerapkan bimbingan kelompok oleh guru pada para siswa kelas 4 sampai kelas 6 setiap satu minggu sekali untuk memberikan bekal terkait adab dan semacamnya, termasuk pendidikan kesehatan reproduksi, sekaligus sebagai salah satu strategi sekolah dalam melaksanakan amanat undang-undang. Sehingga, untuk melakukan evaluasi dan menilai keefektifan upaya yang dilakukan sekolah selama ini terkait kegiatan tersebut, maka pihak sekolah memberikan izin atas permohonan peneliti guna mengadakan penelitian di sana. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perilaku (pengetahuan, sikap, dan tindakan) remaja awal (siswa berusia 10-12 tahun) dalam mencegah penyimpangan seksual, yaitu dengan mengukur perubahan perilaku antara sebelum dan sesudah dilakukan bimbingan kelompok (metode client centered) terdiri maksimal 10 siswa per kelompok) dengan fokus materi pendidikan seks islami, selama 8 minggu. Dalam kegiatan ini, siswa yang bersedia untuk diteliti, otomatis adalah siswa yang dianggap telah memahami tujuan penelitian dan secara

sadar memilih mengikuti kegiatan karena ingin mencegah terjadinya penyimpangan seksual (syarat bimbingan kelompok metode client centered), serta sanggup mengikuti kegiatan sampai akhir.

Adapun kisi-kisi materi pendidikan seks islami yang telah disepakati untuk diberikan yaitu adab memasuki kamar orang tua, mengenalkan mahram, mengenalkan batasan aurat dan etika memandang, menghindarkan dari rangsangan seksual, mengajarkan ketentuan dan batasan baligh, serta bersuci, menjelaskan tubuh anak, serta memberitahukan penyakit terkait seksual baik fisik, psikis dan sosial. Dimana pada masing-masing poin diuraikan dalam bentuk beberapa pertanyaan tertutup sesuai domain pengetahuan, sikap, dan tindakan, sehingga total poinnya dapat menggambarkan perilaku. Berikutnya, guru pembimbing dibekali modul bimbingan agar dapat memberikan edukasi materi yang standar, sedangkan siswa mendapatkan bimbingan setiap minggu selama 60-90 menit setiap pertemuan sesuai sebaran topik materi dalam modul. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa, pertama, sebelum diberikan bimbingan kelompok, siswa memiliki perilaku yang baik dengan pengetahuan terkategori sedang. Kedua, setelah diberikan bimbingan kelompok, siswa memiliki perilaku yang baik dengan pengetahuan terkategori tinggi. Ketiga, ada pengaruh bimbingan kelompok pendekatan client centered tentang pendidikan seks islami terhadap perilaku pencegahan penyimpangan seksual pada siswa (remaja awal). Jadi, meskipun kebetulan secara umum perilaku siswa dari awal memang sudah baik, tetapi dengan mengikuti bimbingan kelompok, faktanya siswa mengalami peningkatan pengetahuan yang selanjutnya akan mempengaruhi kemampuannya dalam mencegah penyimpangan seksual.

Setelah dibuktikan betapa pentingnya informasi bagi remaja dengan pendekatan islami dalam mencegah perilaku seksual menyimpang, guru di sekolah tidak dapat bekerja sendiri, membutuhkan komitmen orang tua juga dalam memfasilitasi remaja menjalani masa pubernya, khususnya melalui norma agama. Sebagaimana pernyataan Jamin (2008), bahwa pendidikan seks islami berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist merupakan bagian dari pendidikan akhlak, dapat digunakan untuk mencegah anak dari pengaruh seksual negatif. Senada dengan itu, Putri (2013) menyatakan bahwa melalui penerapan bimbingan kelompok, pemahaman remaja tentang seks dapat terfasilitasi dengan baik. Sehingga, keputusan pihak sekolah tersebut untuk mengadakan program bimbingan kelompok semacam ini sangat tepat, patut dilanjutkan dan ditingkatkan.

F. Penutup

Pendidikan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di sekolah akan memberikan dampak yang lebih besar jika program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Pendekatan komprehensif juga dibutuhkan karena pembelajaran dalam pendidikan kesehatan reproduksi tidak hanya berkisar pada pengetahuan, namun juga mencakup pengembangan nilai, sikap positif dan keterampilan hidup. Pelaksana utama di sekolah adalah guru dengan harapan dapat mengintegrasikan berbagai informasi dan aspek kesehatan reproduksi dalam proses pembelajaran dan pembiasaan di kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah.

Dengan demikian, strategi sekolah dalam mencegah penyimpangan seksual pada remaja yang dilakukan melalui bimbingan kelompok tentang pendidikan seks tersebut, tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam upaya mendukung remaja agar mampu dan berdaya, mereka harus memiliki keterampilan hidup baik secara personal maupun sosial. Dalam pendidikan kesehatan reproduksi, keterampilan hidup penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Keterampilan hidup adalah kemampuan untuk beradaptasi dan perilaku positif yang diperlukan seseorang dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan hidup sehari-hari secara efektif (World Health Organization, 1997).

Pada akhirnya, remaja secara personal hendaknya memiliki kesadaran memanfaatkan fasilitas yang disediakan sekolah dengan optimal, termasuk bimbingan kelompok yang mendukung tercapainya program peningkatan kesehatan reproduksi remaja di sekolah. Begitu pula, orang tua dan guru bersinergi dengan harmonis secara berkala atau konsisten melakukan upaya pengawasan yang dikomunikasikan dengan baik terkait pertumbuhan dan perkembangan remaja, sehingga menjadi peluang untuk deteksi dini apabila terjadi penyimpangan seksual maupun masalah kesehatan reproduksi lainnya. Selain itu, pihak sekolah juga dapat berkolaborasi dengan personal atau lembaga yang sama-sama memiliki keinginan serius dalam menyelesaikan masalah reproduksi atau seksual remaja, baik berbentuk konseling, seminar, class meeting, riset, dan sebagainya. Sehingga, melalui sekolah, remaja dapat menyelesaikan tugas perkembangan dalam suatu fase akan berdampak pada perasaan bahagia dan akan menjadi modal bagi penyelesaian tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya.

Referensi

- Aini, Lutfiah. (2011). Hubungan Pemahaman Tingkat Agama (Religiusitas) dengan Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMAN 1 Bangsal Mojokerto. *Jurnal Keperawatan – Volume 01 / Nomor 01/ Januari 2011 – Desember 2011*
- Asror, Miftahul. (2013). *Seks dalam Bingkai Islam*. Jawa Raya Surabaya
- Geldard, Kathryn. (2012). *Konseling Remaja, Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Hana, Bunda. (2014). *Right from The Start (Benar dari Awal)*. PT. Gramedia Jakarta
- Haryani, Mulya. (2012). Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa dan Upaya Guru Pembimbing untuk Mengatasinya. *Jurnal Ilmiah Konseling (KONSELOR) Volume 1 Nomor 1 Januari 2012*
- Kadek. (2014). Penerapan Konseling Client-Centered dengan Teknik Permisif untuk Meningkatkan Harga Diri Siswa Kelas X. IIS 2 SMA Negeri 2 Singaraja. *e-journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling Volume: 2 No 1, Tahun 2014*
- Kemkes RI. (2022). Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja. *Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan*. <https://sites.google.com/view/subditusekrem/download?authuser=0>
- Kurnanto, Edi. (2013). *Koseling Kelompok*. Alfabeta Bandung
- Madani, Yousef. (2014). *Pendidikan Seks Usia Dini bagi Anak Muslim*. Zahra Jakarta
- Nuryani, Ita. (2011). Hubungan Keterpaparan Media Informasi Tentang Seks dengan Perilaku Seks Remaja Awal pada Siswa di SMP Semarang. *Jurnal Dinamika Kebidanan vol. 1 no. 2. Agustus 2011*
- Putra, Nanda. (2013). Peranan Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dalam Mencegah Perilaku Seks Pranikah Di SMA Negeri 3 Samarinda Kelas XII. *eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (3): 35-53 ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id*
- Putri, Ghea. (2010). Penerapan Bimbingan Kelompok Teknik Home Room untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Bahaya Seks Bebas. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling Volume 1 Nomer 1 Tahun 2013, pp 79-99 Januari*
- Suherman, Sherly. (2011). *Yuk, Kenali Seks! Edukasi Seks untuk Remaja*. Yrama Widya
- Supriyanto, Afra. (2011). *Bincang-bincang Soal Seks, Pendidikan Seks untuk Remaja*. Gizone Publishing Surakarta
- Takariawan. (2012). *Wonderful Family, Merajut Keindahan Keluarga*. Era Adicitra Intermedia Solo
- Ulwan, Nashih. (2011). *Ada Apa dengan Seks?*. Gema Insani Press Jakarta

Yusuf, Syamsu. (2009). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung

Glosarium

A

Anhedonia : adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat merasakan kesenangan atau minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukainya. Anhedonia dapat menjadi gejala dari berbagai kondisi kesehatan mental, seperti depresi dan skizofrenia.

Aurat : adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Swt. Aurat harus ditutupi dengan pakaian dan tidak boleh dipamerkan atau terlihat oleh orang yang tidak mahram.

B

Baligh : adalah istilah dalam Islam yang berarti seseorang telah mencapai kedewasaan atau usia baligh

Bestiality atau zoophilia : adalah ketertarikan seksual terhadap hewan. Penderita zoophilia akan mendapatkan kepuasan seksual jika tubuhnya dijilat oleh hewan atau melakukan kontak seksual dengan hewan.

C

Client centered : adalah teknik konseling yang berpusat pada klien. Pendekatan ini bertujuan membantu klien untuk memecahkan masalahnya sendiri.

D

Depresi : adalah gangguan kesehatan mental yang memengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Depresi dapat ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai.

E

Empatik : adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Empati juga dapat diartikan sebagai kesadaran mental yang membuat

seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain.

F

Fungsi afektif : adalah fungsi yang berkaitan dengan kasih sayang, dukungan, dan penghargaan antar anggota keluarga. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama keluarga dan menjadi dasar kekuatan keluarga.

D

Deviasi seksual : adalah perilaku yang tidak biasanya dilakukan, dan atau perilaku seksual yang dianggap bermasalah.

E

Etika : adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, norma, dan prinsip moral yang membimbing perilaku manusia. Etika juga merupakan refleksi jiwa dan ungkapan perasaan terhadap tindakan orang lain atau diri sendiri.

Eksibisionisme : adalah gangguan mental yang ditandai dengan perilaku memamerkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuannya. Perilaku ini termasuk kelainan seksual parafilia.

F

Fetishisme : adalah kelainan seksual yang ditandai dengan ketertarikan seksual terhadap benda mati atau bagian tubuh tertentu. Fetishisme termasuk parafilia, yaitu penyimpangan seksual.

Frottage : adalah seseorang yang hanya mendapatkan kepuasan seksual dengan meraba orang yang disenanginya tanpa diketahui oleh si korban.

H

Heteroseksual : adalah orientasi seksual yang berarti tertarik secara romantis dan seksual kepada lawan jenis. Heteroseksual dianggap sebagai orientasi seksual yang paling umum.

Homoseksual : adalah ketertarikan seksual, emosional, atau personal terhadap orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama. Istilah ini juga digunakan untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang.

I

Inses : adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara sepihak.

K

Komprehensif : adalah kata yang berarti menyeluruh, luas, dan teliti. Kata ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu "comprehensive".

Konfrontasional adalah sikap atau tindakan yang berhadapan langsung dan terang-terangan, terutama dalam menghadapi masalah atau kesulitan.

Konseli : adalah orang yang mendapatkan bantuan dari konselor. Konseli juga dapat disebut sebagai klien.

Konseling : adalah proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan secara tatap muka dengan tenaga profesional. Konseling dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

Konselor adalah : tenaga profesional yang memberikan bantuan konseling kepada klien. Konseling adalah pemberian bantuan dan bimbingan untuk membantu seseorang meningkatkan pemahaman diri.

Koping maladaptif : adalah cara menghadapi stres atau tekanan yang tidak efektif. Koping maladaptif dapat merugikan diri sendiri dan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik.

M

Mahram : adalah orang yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, atau perkawinan.

N

Nasab : adalah keturunan, kerabat, atau hubungan darah. Dalam Islam, nasab merupakan hal penting yang berkaitan dengan hak waris, perwalian, dan lainnya.

O

Orientasi seksual : adalah ketertarikan emosional, romantis, atau seksual seseorang terhadap orang lain. Orientasi seksual berbeda dengan identitas gender.

P

Parafilia : adalah suatu perilaku seksual yang menyimpang dari masyarakat umum, dikenal juga sebagai deviasi seksual, yaitu perilaku yang tidak biasanya dilakukan, dan atau perilaku seksual yang dianggap bermasalah.

Pedofilia atau pedofil : adalah seseorang yang memiliki minat seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai usia remaja awal, yang umumnya berarti anak-anak di bawah usia 11 tahun.

Pornografi : adalah gambar, tulisan, suara, atau bentuk pesan lain yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Pornografi dapat melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Preventif : adalah tindakan pencegahan atau bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Psikomotor adalah : gabungan dari aspek psikologis dan motorik yang berkaitan dengan keterampilan fisik dan koordinasi jasmani. Psikomotor juga dapat diartikan sebagai ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik.

T

Transeksual : adalah istilah untuk orang yang telah atau ingin mengubah jenis kelaminnya melalui intervensi medis. Istilah ini berasal dari istilah medis untuk orang transgender yang telah bertransisi secara fisik.

Traumatik : adalah istilah yang merujuk pada pengalaman yang mengejutkan dan meninggalkan kesan mendalam pada seseorang. Trauma dapat merusak fisik maupun psikologis.

S

Sadisme dan masokisme : adalah dorongan seksual yang berhubungan dengan rasa sakit. Sadisme adalah dorongan seksual untuk menyakiti orang lain, sedangkan masokisme adalah dorongan seksual untuk disakiti.

Salirophilia : adalah fetish seksual atau paraphilia yang melibatkan perolehan kenikmatan erotis dengan mengotori atau mengacak-acak objek yang diinginkan, atau melihatnya dalam keadaan tersebut.

Signifikan : adalah kata serapan dari bahasa Inggris "significant" yang berarti penting, berarti, atau bermakna khusus. Kata ini dapat digunakan untuk menyatakan pentingnya suatu hal atau peristiwa serta dampak yang ditimbulkannya.

Sinergi : adalah kerja sama atau interaksi yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Sinergi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan.

Strategi : adalah rencana jangka panjang yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dapat berupa perencanaan, pola, posisi, taktik, atau perspektif.

U

Urgensi : adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Urgensi juga diartikan sebagai keadaan yang membutuhkan tindakan segera dan tidak bisa ditunda.

V

Voyeurisme dan skopofilia : adalah istilah yang merujuk pada kelainan seksual yang sama, yaitu ketertarikan seksual terhadap aktivitas orang lain tanpa sepengetahuannya.

BAB V

EDUKASI TENTANG PENTINGNYA

MENJAGA KESEHATAN ORGAN REPRODUKSI REMAJA

A. Pendahuluan

Remaja merupakan kelompok potensial yang perlu mendapat perhatian serius karena remaja dianggap sebagai kelompok yang mempunyai risiko secara seksual maupun kesehatan reproduksi dimana mereka memiliki rasa keingintahuan yang besar dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tersebut tidak tepat, mereka akan jatuh dalam perilaku berisiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial (Hapsari, 2019). Meskipun remaja merupakan salah satu pilar utama komunitas kita, mereka dianggap sebagai kelompok rentan (Organisasi Kesehatan Dunia, 2021). Penyebab utama dari kerentanan adalah perubahan gaya hidup dan bahaya sosial yang terpapar pada individu dalam rentang usia ini (Mosavi et al., 2014). Data yang tersedia menunjukkan bahwa 70% kematian di masa dewasa dikaitkan dengan perilaku di masa remaja (Azzopardi et al., 2019).

Masa remaja seringkali menjadi masa dimana remaja melakukan perilaku-perilaku seksual. Perilaku seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sejenis. Bentuk tingkah laku ini beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama (Hapsari, 2019).

Berbagai risiko kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, misalnya tuntutan kawin muda dan berhubungan seksual, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, ketimpangan gender, kekerasan seksual, pengaruh negatif media masa dan kemajuan teknologi, maupun gaya hidup modern yang bebas. Pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi sering berpengaruh terhadap masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja. Metode penyuluhan dipercaya

mampu meningkatkan pengetahuan remaja serta mengubah perilaku remaja untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri (Mayasari dkk, 2021).

Salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya promotif dan preventif di lingkungan sekolah adalah masalah kesehatan reproduksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan siswa sekolah menengah pertama. Hal ini dikarenakan adanya perilaku seks bebas di antara mereka. Sikap masyarakat dan lingkungan sekolah yang permisif terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seks bebas mendorong berkembangnya perilaku tersebut. Dampak kehamilan pada remaja tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berdampak jangka panjang. Kurangnya asupan gizi janin dan ibu remaja sering menjadi penyebab terjadinya masalah stunting. Risiko penyakit menular seksual dan kanker serviks akibat hubungan seks pada usia terlalu dini terbukti menjadi masalah serius yang dihadapi remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan (Pourmarzi & Rimaz, 2014).

Tindakan promotif dan preventif merupakan upaya yang sangat penting untuk menekan besarnya masalah kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penurunan masalah kesehatan akan optimal apabila semua sektor memuat indikator upaya promotif dan preventif yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing. Termasuk sektor utama yang dituntut untuk mengintegrasikan upaya tersebut adalah lembaga pendidikan. Tantangan Promosi Kesehatan di lembaga pendidikan (Health Promoting Schools) yang dicanangkan oleh World Health Organization menggunakan model holistik yang mencakup keterkaitan antara aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Konsep ini melibatkan keluarga dan sekolah dengan mendorong peran sertanya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik (sejak usia dini) tentang kesehatan (World Health Organization & UNESCO, 2018).

B. Pengenalan tentang Kesehatan Reproduksi

World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja sebagai penduduk yang memiliki rentang usia 10-19 tahun, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014 remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) remaja memiliki rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah (BPS, 2021; Indonesia, 2018; WHO, 2020).

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera baik fisik, mental dan sosial yang utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan) dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja menurut BKKBN adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan

namun juga sehat secara fisik, mental dan sosial kultur (Kementrian Kesehatan, 2017).

Sistem reproduksi secara umum terdiri dari gonad/organ reproduktif yang mensekresi gamet dan hormon, duktus/saluran, organ/kelenjar asesori dan genitalia eksterna. Fungsi sistem reproduksi pria yaitu spermatogenesis, kinerja kegiatan seksual pria dan pengaturan fungsi reproduksi pria dengan berbagai hormon. Fungsi reproduksi pada wanita adalah oogenesis, fertilisasi, kinerja kegiatan seksual wanita, pengaturan fungsi reproduksi wanita dengan berbagai hormon dan kehamilan serta laktasi. Pada masa pubertas wanita mengalami perubahan fisiologi pada sistem reproduksinya yang ditandai dengan menstruasi setiap bulan (Ekawati, 2019).

Pendidikan tentang sistem reproduksi harus dilakukan sejak dini. Pubertas adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual (Hasheem et al., 2021). Proses ini dimulai dengan sinyal hormonal dari otak ke gonad: ovarium pada anak perempuan, testis pada anak laki-laki. Kasus penyakit menular seksual banyak terjadi pada remaja yang akan berpengaruh pada tingkat kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Menurut WHO, 2022 terdapat lebih dari 1 juta kasus infeksi penyakit menular di seluruh dunia dan sebagian besar tidak menunjukkan gejala (asymptomatic). Pada tahun 2020 WHO memperkirakan 374 juta infeksi baru yang terdiri dari chlamydia (129 juta), gonore (82 juta), sifilis (7,1 juta) dan trikomoniasis (156 juta) (WHO, 2022).

C. Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi Sejak Usia Dini

Perawatan organ reproduksi dapat dilakukan dengan cara mengupayakan vagina senantiasa kering dan tidak lembab, mencuci tangan sebelum menyentuh vagina, menyeka dari depan ke belakang, tidak menggunakan handuk yang telah dipakai orang lain untuk mengeringkan vagina, menggunakan celana dalam yang bersih dan berbahan katun serta menghindari menggunakan alat pembersih kemaluan karena dapat merubah keasaman pada vagina (Putri and Saputra 2018). Perawatan organ reproduksi secara otomatis dapat terlaksana dengan melakukan personal hygiene secara rutin. Personal hygiene (kebersihan diri atau perawatan diri) merupakan bentuk perawatan diri yang ditujukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental (Nurchandra, Mirawati, and Aulia 2020). Pendapat lain mengatakan bahwa personal hygiene adalah tindakan menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan fisik dan mental, pengetahuan, tingkat pendidikan dan keadaan lingkungan itu sendiri (Rahmah 2021).

Merawat kebersihan organ seksual seringkali tidak dilakukan sesering merawat kebersihan organ tubuh lainnya. Padahal organ seksual membutuhkan perhatian yang ekstra. Pada organ seksual tersebut keringat yang dihasilkan cukup berlebih.

Sehingga organ seksual tersebut menjadi lebih lembab yang dapat menjadi media berkembangbiaknya bakteri, penyakit dan bau tidak sedap (Delvia, 2016).

Penunjang keberhasilan personal hygiene pada wanita Usia Subur (WUS) adalah kebersihan tubuh dan area genitali. Area genitalia dapat dijaga dengan melakukan Perineal Hygiene atau upaya lain dalam merawat diri yang bertujuan untuk membersihkan kotoran dan bau dari daerah perineum serta mencegah terjadinya infeksi terutama pada saluran kemih sebagai upaya meningkatkan kenyamanan diri disebut (Ruiz et al. 2019). Sejalan dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan dan kesadaran untuk menjaga kebersihan organ dengan penerapan perineal hygiene merupakan hal yang penting dalam mendukung terciptanya kesehatan bagi Wanita (Karo et al. 2021). Kebutuhan utama Wanita Usia Subur (WUS) tidak hanya bergantung pada perilaku personal hygiene tetapi juga harus ditunjang dengan pola hidup sehat dan pengetahuan yang baik.

D. Kesehatan Reproduksi Wanita Saat Menstruasi

Remaja putri merupakan kelompok yang rentan terkena infeksi organ reproduksi. Hal ini terjadi karena remaja putri memiliki tingkat perhatian yang rendah terkait kesehatan reproduksi sehingga mempunyai perilaku yang kurang baik dalam merawat kebersihan diri terutama saat mengalami menstruasi (Ningrum & Indriyanti, 2018; Pythagoras, 2018; Umahi Nnennaya et al., 2021). Penelitian yang dilakukan di negara dengan pendapatan menengah seperti Nepal, Zambia, Pakistan, Bangladesh dan Korea Selatan terkait kebersihan diri saat menstruasi, menunjukkan hasil yang serupa yang mana ditemukan masih banyak remaja putri yang belum memiliki praktik kebersihan yang baik ketika menstruasi (Kim & Choi, 2020; Lahme et al., 2018; Poudel & Gautam, 2020; Yadav et al., 2018; Yasmin et al., 2019). Bahkan terdapat 33% remaja putri di daerah pedesaan Kenya dan India mengalami infeksi saluran reproduksi (Juyal et al., 2014; Kerubo et al., 2016).

Dewasa ini, di Indonesia menstruasi yang terjadi pertama kali (menarche) pada remaja putri datang lebih awal. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) mengungkapkan bahwa perempuan di Indonesia mendapatkan haid untuk pertama kalinya pada usia kurang dari 10 tahun sampai dengan 17 tahun, dengan persentase <10 tahun (2,0%), 11-13 tahun (60,7,0%) dan sisanya 14-17 tahun. Diskusi tentang haid pertama lebih banyak dilakukan dengan teman (57,5%) dan sisanya dengan ibu, ayah, saudara, keluarga, guru, petugas kesehatan dan lain-lain (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional et al., 2018).

Usia menarche yang datang lebih awal dapat menjadi suatu masalah bagi remaja putri jika remaja putri tersebut belum siap. Kematangan yang terlalu awal dapat membuat remaja putri rentan menemui masalah yang tidak diinginkan seperti depresi, merokok, gangguan makan, bahkan gangguan mental (Mutasya et al., 2016). Remaja putri dengan usia menarche dini memiliki 1,36 kali kemungkinan

mengalami gejala depresi dibandingkan dengan kelompok menarche normal (Shen et al., 2019). Menarche dapat menimbulkan perubahan psikologis berupa emosional yaitu perasaan cemas (Abadi et al., 2015; Alomair et al., 2021; Marvan et al., 2017). Selain itu, ketidaksiapan dalam menghadapi menarche dapat berdampak pada masalah kurangnya kebersihan diri (personal hygiene) sehingga beresiko terjadi infeksi organ reproduksi.

Dukungan sosial yang diterima seseorang dapat membuat orang tersebut merasa dicintai, diperhatikan dan dapat meningkatkan perasaan positif. Dukungan sosial yang diterima remaja putri terkait menarche akan menyebabkan remaja putri merasa mendapatkan perhatian, informasi, cinta, kasih sayang dan rasa nyaman sehingga membantunya mempersiapkan diri dalam menghadapi menarche (Setyawati et al., 2019).

Ketersediaan informasi (accessibility of information) dapat meningkatkan intuisi sehingga pengetahuan yang didapatkan bisa bertambah. Informasi bisa berasal dari media cetak, media elektronik, media sosial, orang tua, guru, teman dan sebagainya. Informasi yang diperoleh akan menambah wawasan remaja putri, mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan serta meningkatkan gambaran yang positif terhadap menarche. Bertambahnya pengetahuan mengenai menarche dapat membuat remaja putri menjadi siap dalam menghadapi menarche.

E. Pentingnya Pendidikan Seksual dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi

Masalah seksual menjadi masalah utama remaja di Indonesia. Banyaknya peristiwa ini pada remaja menjadi berita di media. Hal ini menjadi serius karena jumlah remaja tergolong besar dari jumlah penduduk. Masalah seks bebas tidak hanya banyak terjadi di kota besar saja, akan tetapi telah sampai ke berbagai kota kecil di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang pesat terutama dikalangan remaja, seperti perkembangan alat komunikasi dan kebebasan mengakses internet.

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam website resmi BKKBN (2019) memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara ke 37 dengan jumlah perkawinan remaja terbanyak di dunia yaitu 34%. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan kedua setelah Kamboja yaitu 23% remaja yang sudah menikah. Pada masa remaja, salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai oleh individual adalah pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Hurlock (Mudjiran, 2016) mengemukakan bahwa remaja mencari informasi tentang seks dengan cara membahas dengan teman, membaca buku-buku tentang seks atau mengadakan percobaan dengan jalan masturbasi, onani, bercumbu atau berhubungan seksual.

Untuk meminimalisir hal tersebut pemberian informasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja harus diberikan, agar remaja tidak mencari informasi

dari orang lain atau dari sumber-sumber yang tidak jelas atau bahkan keliru sama sekali. Banyaknya seks bebas maupun seks dibawah umur serta terjadinya seks menyimpang diduga antara lain karena mereka kurang mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja (Helmi, Paramastri, & Mada, 2018).

Berbagai risiko kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, misalnya tuntutan kawin muda dan berhubungan seksual, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, ketimpangan gender, kekerasan seksual, pengaruh negatif media masa dan kemajuan teknologi, maupun gaya hidup modern yang bebas, Pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi sering berpengaruh terhadap masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja. Metode penyuluhan dipercaya mampu meningkatkan pengetahuan remaja serta mengubah perilaku remaja untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri (Mayasari, dkk, 2021).

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja merupakan sebuah diskusi yang realistis, jujur dan terbuka bukan merupakan dikte moral belaka. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu upaya mendidik dan mengarahkan perilaku seksual secara baik dan benar (Ernawati, 2018). Jalur yang tepat di sekolah untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja kepada siswa adalah melalui Bimbingan dan Konseling. Menurut Prayitno (Zamroni & Rahardjo, 2017) mengemukakan bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.

F. Peran Dukungan Sosial dalam Kesehatan Reproduksi

Remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yaitu batasan usia 10 sampai dengan 19 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, dimulai pada saat kematangan seksual yaitu antara usia 10-12 tahun sampai 20 tahun, menjelang masa dewasa muda (Sirupa,Wantania, & Suparman, 2016). Masa transisi ini, seringkali remaja dihadapkan pada situasi yang membingungkan bagi mereka. Permasalahan yang dihadapi remaja yang juga khas, dimana mereka sangat ingin tahu, ingin mencoba hal baru, sering berkelompok, masih mencari identitas sehingga mereka suka mencari tantangan, dan cenderung melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Salah satu permasalahan yang harus diperhatikan adalah masalah kesehatan reproduksi (Demon,Hinga, & Sir,2019). Kesehatan reproduksi orang tua berperan dalam mempersiapkan anaknya dengan berikan pendidikan seks pada masa remaja, hal ini dapat diimplikasikan dengan pengaplikasian

pengetahuan remaja tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Ardhiyanti & Rosita, 2021).

Usia remaja sangat rentan terhadap berbagai ancaman risiko kesehatan reproduksi oleh karenanya perlunya bimbingan dari lingkungan dari lingkungan sekitar, orang tua, guru dalam menghadapi masa pubertas. (Azizah, Rosyidah, & Nastiti, 2020). Pembahasan mengenai kesehatan reproduksi tidak jarang dianggap sebagai hal yang tidak pantas untuk dibahas membuat minimnya akses untuk pengetahuan dan sikap yang baik terkait topik ini yang menyebabkan menumbuhkan rasa penasaran para remaja untuk mencari informasi tanpa menyaring tentang kesehatan reproduksi dari berbagai sumber seperti media, teman dan tidak jarang kepada akses pornografi (Denno, Hoopes, & Chandra-Mouli, 2015).

Pola komunikasi yang positif antara orang tua dan anaknya memiliki korelasi yang baik yang dapat memengaruhi perkembangan kehidupan seorang siswa. Studi menemukan bahwa remaja yang tidak berjauhan dari orang tua, mengalami masalah psikis, seperti minimnya akses untuk berkeluh kesah serta kesulitan untuk mengekspresikan emosi dan perasaan takut. Peran guru sangatlah harus optimal, akan tetapi studi lainnya menemukan bahwa masih adanya gap antara komunikasi guru (ustadzah) di pesantren dengan siswa untuk mengungkapkan isi hatinya (Cahyani, Agushyana, & Nugroho, 2019).

G. Mempersiapkan Kesehatan Reproduksi untuk Kehamilan yang Sehat

Wanita usia subur berdasarkan konsep Kementerian Kesehatan adalah wanita yang sedang dalam masa reproduksi aktif, yaitu dengan rentang usia 15-49 tahun, baik yang sudah janda, sudah menikah, maupun belum menikah (Suwanti, 2019). Wanita usia subur harus menjaga dan merawat organ reproduksi dengan cara rajin membersihkan terutama saat masa subur agar terhindar dari gangguan organ reproduksi (Nasution 2018). Kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang sempurna, bukan hanya tanpa penyakit atau kelemahan, akan tetapi mencakup semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya (Nelwan 2019).

Wanita membutuhkan pengetahuan dan informasi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksinya demi kelangsungan hidup di masa mendatang. Kesehatan organ reproduksi dapat diartikan sebagai suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi, yaitu fungsi, komponen dan prosesnya. Dalam kesehatan organ reproduksi terdapat permasalahan yang sering muncul di negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga kesehatan reproduksi sangat perlu mendapat perhatian khusus (Rakhmawati, 2019).

Faktor yang melatarbelakangi rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada wanita adalah tentang kebersihan organ kewanitaan yang dapat berdampak

buruk pada perilaku dalam menjaga kebersihan organewanitaan karena pengetahuan dan perilaku yang baik merupakan faktor penentu dalam menjaga kebersihan organ kewanitaan. Dampak dari rendahnya pengetahuan menjaga kebersihan organ kewanitaan dapat mengalami keputihan yang tidak normal dengan tanda gejala seperti keluarnya cairan yang berbau tidak sedap, berbau tidak sedap, jumlahnya banyak, gatal, perih atau nyeri (Rakhmawati, 2019). Rendahnya informasi dan pengetahuan tersebut menyebabkan rasa malu dan cemas karena berbeda dengan orang lain yang tidak mengalami perubahan pada sistem reproduksinya (Abrori, dkk 2017).

Kondisi kesehatan reproduksi wanita di Indonesia saat ini belum sesuai dengan indikator kesehatan reproduksi, dimana masih banyak aspek yang belum terpenuhi (Kurniawaty dkk, 2020). Kesehatan reproduksi di Indonesia dinilai masih tertinggal jika dibandingkan dengan keadaan di negara ASEAN lainnya (Widiasih & Setyawati, 2018). Berdasarkan data WHO tahun 2010, masalah kesehatan reproduksi pada wanita usia subur (WUS) masih dalam taraf memprihatinkan, yakni mencapai 33% dari keseluruhan beban penyakit yang diderita wanita di dunia (Muharrina et al., 2023).

Namun di Indonesia, pengetahuan WUS khususnya ibu tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi masih tergolong rendah karena minimnya akses informasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktafia dkk pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi masih rendah sehingga berdampak serius seperti munculnya penyakit ginekologi, penyakit menular seksual hingga munculnya kekerasan pada organ reproduksi (Wahyuningsih, 2020).

H. Penutup

Permasalahan seputar kesehatan reproduksi remaja saat ini semakin meningkat, dikarenakan remaja yang belum memahami dengan baik cara menjaga kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksinya menjadi satu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dapat memberikan perhatian khusus dalam pencegahan berbagai penyakit reproduksi pada remaja.

Referensi

- Abadi, D. R., Dewi, A. P., & Nurchayati, S. (2015). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Remaja Putri Dalam Menghadapi Menarche. *JOM*, 2(2), 7.
- Aisyaroh. (2012). Kesehatan Reproduksi Remaja. *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*.
- Ardhiyanti, L. P., & Rosita, E. (2021). Pengaruh Antara Peran Serta Wali Santri Dengan Pengetahuan Santri Putri Usia 12-19 Tahun Tentang Kesehatan Reproduksi Di Lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Putri Pare-Kediri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 2(2), 55-64.
- Azizah, N., Rosyidah, R., & Nastiti, D. (2020). Masa Remaja Dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Santri Putri Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 4(1), 1-4.
- Azzopardi PS, Hearps SJC, Francis KL, Kennedy EC, Mokdad AH, Kassebaum NJ, Lim S, Irvine CMS, Vos T, Brown AD, Dogra S, Kinner SA, Kaoma NS, Naguib M, Reavley NJ, Requejo J, Santelli JS, Sawyer SM, Skirbekk V, Temmerman M, et al. Progress in adolescent health and wellbeing: tracking 12 headline indicators for 195 countries and territories, 1990-2016. *Lancet*. 2019;393:1101-18. PMID: 30876706 DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32427-9.
- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, & USAID. (2018). *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja—Indikator Utama*.
- BKKBN. (2019). Laporan hasil penelitian dan informasi kesehatan reproduksi remaja. <https://www.bkkbn.go.id/pages/hasil-penelitian-bkkbn>. Diakses 5 Februari 2025.
- Cahyani, K. O. A., Agushyana, F., & Nugroho, R. D. (2021). Hubungan Pola Komunikasi Orang Tua Asuh Dengan Pengetahuan Dan Sikap Kesehatan Reproduksi Remaja Panti Asuhan Kabupaten Klaten Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(1), 15-25.
- Delvia, S. (2016). Keluhan pada Genitalia Eksternal Ditinjau dari Pengetahuan dan Personal Hygiene Pada Siswi SMA. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), Hal-47.
- Demon, B. P., Hinga, I. A., & Sir, A. B. (2019). Gambaran Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Siswa Sma Di Kota Kupang Tahun 2019. *Lontar: Journal Of Community Health*, 1(2), 66-75.
- Denno, D. M., Hoopes, A. J., & Chandra-Mouli, V. (2015). Effective Strategies To Provide Adolescent Sexual And Reproductive Health Services And To Increase Demand And Community Support. *Journal Of Adolescent Health*, 56(1), S22-S41.

- Ekawati, R. (2019). Pengantar kesehatan reproduksi. Wineka Media.
- Ernawati, H. (2018). Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di daerah pedesaan. *Indonesia Journal For Health Sciences*, 02(01), 58–64
- Hapsari Anindya, (2019). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Modul Kesehatan Reproduksi. Wineka Media Malang.
- Hasheem, A., Ibrahim, R., Mukhtar, S., & Faris, M. (2021). Anatomy & Physiology of the Reproductive System. *Research Gate*, October, 1–59. https://doi.org/10.2174/97898150516671_22050003.
- Helmi, A. F., Paramastri, I., & Mada, U. G. (2018). Efektivitas pendidikan seksual dini perilaku seksual sehat. *Journal Psikologi* (2), 25–34.
- Juyal, R., Kandpal, S. D., & Semwal, J. (2014). Menstrual Hygiene And Reproductive Morbidity In Adolescent Girls In Dehradun, India. *Bangladesh Journal Of Medical Science*, 13(2), 170–174. <https://doi.org/10.3329/Bjms.V13i2.14257>.
- Karo, Marni Br, Ai Nuraida, Lenny Irmawaty Sirait, and R. Haryo Bimo Setiarto. 2021. "Relationship Between Tight Pants Use and The Incidence of Flour Albus Pathology in Women of Childbearing Age." *Jurnal Kesehatan Prima* 15(1):23–30. doi: 10.32.248/jkp.v15i1.589.
- Kim, K. M., & Choi, J. S. (2020). Female University Students' Menstrual-Hygiene Management And Factors Associated With Genitourinary-Tract Infections In Korea. *Women & Health*, 60(5), 559–569.
- Mayasari dkk, (2021). Kesehatan Reproduksi Wanita Di Sepanjang Daur Kehidupan. Syiah Kuala University Press, Aceh
- Mayasari dkk, (2021). Kesehatan Reproduksi Wanita Di Sepanjang Daur Kehidupan. Syiah Kuala University Press, Aceh.
- Mudjiran. (2016). Pengetahuan kesehatan reproduksi. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 2(1), 69–84.
- Muharrina, C. R., Yustendi, D., Sarah, S., Herika, L., & Ramadhan, F. (2023). Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 5(1), 26–29.
- Mutasya, F. U., Edison, E., & Hasyim, H. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Usia Menarche Siswi SMP Adabiah. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(1). <https://doi.org/10.25077/Jka.V5i1.475>.
- Nasution, Fitria Febriani. 2018. "Hubungan Perilaku Wanita Usia Subur (WUS) Tentang Vulva Hygiene Dengan Keputihan Di Lingkungan VII Kelurahan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018." *Institut Kesehatan Helvetia*.
- Nelwan, Jeini Ester. 2019. *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish.
- Ningrum, M. A. C., & Indriyanti, D. R. (2018). The Influence Of Knowledge, Attitude,

Family Support And Peer Support On The Behavior Of Female Teenage Menstrual Hygiene. 9.

- Nurchandra, Domas, Mirawati Mirawati, and Fika Aulia. 2020. "Pendidikan Kesehatan Tentang Personal Hygiene Pada Remaja Putri Di Smp 1 Muhammadiyah Banjarmasin." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan* 2(1):31. doi: 10.26714/jpmk.v2i1.5368.
- Pourmarzi, D., & Rimaz, S. (2014). Sexual and Reproductive Health Educational Needs in Engaged Couples in Tehran in 2010. *Sex Res Soc Policy*, 10 (7): 59-64.
- Putri, Sukmawati Anggraeni, and Elin Panca Saputra. 2018. "Perancangan Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Awal Kanker Reproduksi Wanita Dengan Metode Certainty Factor." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 2(3):63-68. doi: 10.30865/mib.v2i3.659.
- Rahmah, Dhea Aularia. 2021. "Hubungan Pengetahuan Dan Personal Hygiene Dengan Penyakit Kulit Pada Santri Putra Di Pondok Pesantren Trubus Iman Tanah Grogot 2021." Universitas Islam Kalimantan.
- Ruiz, Camilia, Paulo Cesar Giraldo, Jose Marcos Sanches, Virginia Reis, Joziani Beghini, Cristin Laguna, and Rose Luce Amaral. 2019. "Daily Genital Cares of Female Gynecologists: A Descriptive Study." *REv Assoc Med Bras* 65(2):171-76.
- Setyawati, A., Widiasih, R., E, E., & Maryati, I. (2019). A Literature Review: Urban Teenagers' Readiness To Improve The Quality Of Life Toward The Menarche. *Journal Of Maternity Care And Reproductive Health*, 2(2). <https://doi.org/10.36780/Jmcrh.V2i2.85>.
- Shen, Y., Varma, D. S., Zheng, Y., Boc, J., & Hu, H. (2019). Age At Menarche And Depression: Results From The NHANES 2005-2016. *Peerj*.7150, 1-12. <https://doi.org/10.7717/Peerj.7150>.
- Sirupa, T. A., Wantania, J. J., & Suparman, E. (2016). Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi. *E-Clinic*,4(2).
- Umahi Nnennaya, E., Atinge, S., Paul Dogara, S., & Joel Ubandoma, R. (2021). Menstrual Hygiene Management Among Adolescent School Girls In Taraba State, Nigeria. *African Health Sciences*, 21(2), 842-851. <https://doi.org/10.4314/Ahs.V21i2.45>.
- Wahyuningsih, R. O. A. W. S. B. L. (2020). Menstruasi Sehat Pada Remaja Putri Di Sanggar Disminore Gadis Qur'an Wilayah Desa Tlogo Rt 05 Tamantirto Kashan Bantul Riski. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 3(April), 148-155.
- WHO - World Health Organization. Adolescent and young adult health. Geneva: WHO; 2021.
- WHO. (2022). Sexually transmitted infections (STIs). In WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID19) Dashboard With Vaccination Data.

- WHO. [https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/sexuallytransmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/sexuallytransmitted-infections-(stis)).
- World Health Organization, & UNESCO. (2018). Global Standards for Health Promoting Schools. Geneva: WHO.
- Zamroni, E., & Rahardjo, S. (2017). Manajemen bimbingan dan konseling berbasis permendikbud nomor 111 Tahun 2014. Jurnal Konseling Gusjigang, 1(1), 1–11.

BAB VI

PENDEKATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pendahuluan

Kehidupan saat ini tidak bisa lepas dari teknologi digital. Teknologi digital memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia saat ini. Bagaimana tidak? Perkembangan teknologi telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi demikian pesat, terutama sejak terjadi pandemi covid 19 saat terjadi pembatasan aktifitas dan sosialisasi. Sebagian besar aspek kehidupan didominasi penggunaan teknologi digital. Perkembangan transformasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat didorong oleh perkembangan teknologi digital. Salah satunya di bidang kesehatan.

Dalam bidang kesehatan, teknologi digital dimanfaatkan dalam ranah pelayanan kesehatan dalam bentuk kuratif, rehabilitatif, maupun promotif. Dalam ranah promotif, teknologi digital sering dimanfaatkan untuk melakukan promosi kesehatan pada masyarakat umum berbagai usia. Promosi kesehatan ini mencakup berbagai aspek kesehatan pada manusia, salah satunya adalah pendidikan kesehatan reproduksi.

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu amanat dari UU Kesehatan No 17 tahun 2023. Menurut pasal 54 UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 bahwa upaya kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Pada pasal 55 ayat b disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi ini diberikan pada laki-laki dan perempuan di berbagai usia, salah satunya adalah remaja. Remaja merupakan masa awal dan istimewa dalam membangun kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan reproduksi. Remaja merupakan periode awal saat seorang anak mulai memiliki kemampuan membaca dan menginternalisasi suatu ide dengan baik. Sehingga diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diberikan menjadi sikap dan perilaku yang baik juga. Lukmana & Yuniarti (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebagian besar (78,9%) remaja salah satu SMP di kota Yogyakarta berpengetahuan kesehatan reproduksi yang cukup. Hal yang berbeda terjadi di Kota Ternate, Yamko et al (2022) menyampaikan bahwa

pengetahuan sebagian besar (52,1%) remaja terkait kesehatan reproduksi menunjukkan kategori kurang baik. Dua penelitian ini menggambarkan perbedaan tingkat pengetahuan remaja di berbagai daerah di Indonesia.

Pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik pada remaja belum tentu menunjukkan sikap positif mereka terhadap kesehatan reproduksi. Putri et al (2022) mengemukakan bahwa sebagian siswi di SMP Ubud (63,2%) berpengetahuan baik tentang kesehatan reproduksi namun sikap mereka terhadap kesehatan reproduksi masih negatif (50,9%). Pengetahuan baik tentang kesehatan reproduksi tidak menjamin remaja memiliki sikap yang positif terhadap kesehatan reproduksi masih negatif. Menyikapi hal ini, maka sangat penting memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang berkualitas pada remaja.

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang berkualitas sangat penting agar remaja mengetahui dan memahami kesehatan reproduksi yang baik dalam rangka menjaga kesehatan dan tidak terjerumus dalam pergaulan yang merugikan kesehatan reproduksi remaja. Dalam melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi remaja ini juga dapat memanfaatkan teknologi digital. Hal ini didukung bahwa remaja saat ini merupakan generasi Z (Gen Z) yang tumbuh di era teknologi digital.

Remaja sangat dekat dengan pemanfaatan teknologi digital. Semenjak pandemi covid 19 saat terjadi pembatasan aktivitas tatap muka, teknologi digital banyak dimanfaatkan untuk menjadi sarana penunjang pembelajaran jarak jauh di berbagai tingkatan pendidikan. Remaja menggunakan gawai, laptop, personal computer (PC) maupun tablet dalam mengakses pembelajaran jarak jauh ini. Salah satu dampak dari pembelajaran melalui teknologi digital ini adalah bahwa remaja menjadi terpapar dengan berbagai teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari seperti internet, media sosial, multimedia, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI), dan yang lainnya.

Keterikatan remaja pada teknologi digital ini dapat dikembangkan menjadi kegiatan positif dengan melakukan pendekatan teknologi digital dalam kesehatan reproduksi remaja. Pendekatan teknologi digital dalam kesehatan reproduksi remaja diharapkan meningkatkan akses remaja terhadap pendidikan kesehatan reproduksi.

B. Remaja

Remaja merupakan peralihan dari anak menuju usia dewasa pada rentang usia 11-20 tahun (Ricci et al., 2021). Menurut Kemenkes (2021), remaja merupakan individu dengan tingkatan umur 10-18 tahun, sedangkan anak usia sekolah ialah individu berumur >6 tahun sampai usia <18 tahun. Kadang terjadi tumpang tindih pada remaja dan kelompok usia sekolah (Ricci et al, 2021).

Remaja menjalani proses tumbuh kembang pada berbagai dimensi fisik, psikologis, dan sosial (Kemenkes, 2021). Pada fisik, remaja mengalami pertumbuhan

secara pesat sehubungan dengan perkembangan organ tubuh dan hormonnya termasuk didalamnya organ seksual reproduksi. Selain itu juga terjadi perkembangan otak yang sangat pesat. Remaja memerlukan ilmu terkait transformasi yang dialaminya dan membangun citra diri yang baik. Secara aspek psikologis, remaja mulai mahir berpikir konseptual, kritis, abstrak, dan analitis. Perkembangan tersebut menyebabkan remaja terdorong untuk melakukan banyak eksplorasi dan belajar banyak hal-hal baru. Remaja perlu diberikan berbagai rangsangan yang benar dan bervariasi sehingga kapasitas kognitifnya berkembang lebih maksimal. Remaja mengalami perkembangan emosi ke arah kedewasaan emosi.

Bimbingan dan dorongan dari lingkungan diperlukan oleh remaja untuk belajar mengidentifikasi, menyampaikan, dan mengatur emosi yang dirasakannya. Pada dimensi sosial, remaja mengalami perkembangan lingkup sosial yang bertambah luas. Terdapat peningkatan keinginan diterima oleh lingkungannya, sehingga fungsi teman sebaya (peer) amat besar pada dunia seorang remaja. Remaja memerlukan pendampingan agar bisa melakukan sosialisasi dengan baik dan mempunyai prinsip serta nilai namun juga tetap memiliki pendirian dan nilai individu. Kita perlu memfasilitasi remaja dengan aktivitas kelompok yang mendukung interaksi dengan teman sebaya. Remaja memerlukan ilmu dan kecakapan baru yang dapat mendorong mengoptimalkan tumbuh kembangnya.

Remaja dikenal dengan Igeneration, generasi Z, generasi net, atau generasi internet. Mereka tumbuh bersama perkembangan teknologi digital. Kehidupan mereka tidak bisa dipisahkan dengan teknologi digital dan teknologi internet. Menurut Kemenkes (2021), generasi Z/generasi internet memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pahami teknologi

Generasi ini memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitasnya setiap hari. Mereka menggunakan teknologi internet dalam edukasi, memperoleh hiburan, dan bermacam-macam hal lainnya. Mereka kesulitan lepas dari internet. Orang dewasa perlu menolong remaja berlatih bertanggung jawab dan bisa memanfaatkan internet secara sehat, terlindung dari hal yang tidak baik, dan bijak.

2. Berpandangan luas dan global

Perkembangan teknologi digital demikian pesat sehingga akses internet juga sangat gampang didapatkan oleh remaja. Remaja bisa mendapatkan informasi apapun yang berasal dari berbagai belahan dunia. Remaja memerlukan

bimbingan dalam memanfaatkan pengetahuan yang mereka dapat secara baik, kritis dan memilah dengan benar akses informasi yang dibutuhkan.

3. Optimis

Remaja condong untuk memiliki kepercayaan yang besar pada masa depan mereka.

4. Cenderung berpusat pada diri sendiri

Teknologi digital membuat remaja banyak berinteraksi dengan dunia maya sehingga interaksi dengan orang di sekeliling mereka menjadi berkurang. Remaja lebih berfokus pada diri sendiri. Remaja perlu dibantu untuk peka dan memiliki empati sosial.

5. Merasa kapasitas diri minim

Remaja butuh bantuan dari lingkungan sekitarnya agar dapat percaya diri dengan kemampuannya.

6. Ketahanan rendah

Remaja generasi Net kurang bisa menghadapi situasi yang kurang nyaman karena terbiasa dengan kemudahan dalam segala hal. Situasi ini dapat menimbulkan terjadinya tekanan pada diri mereka. Remaja perlu dibantu dalam mengelola stres dan emosi dalam menghadapi hal yang kurang nyaman tersebut.

7. Gaya belajar visual dan dinamis

Remaja generasi Z lebih mudah memahami pembelajaran dengan media video, gambar, dan aktivitas-aktivitas yang dapat mereka lakukan sendiri.

8. Rentang atensi sempit

Remaja generasi net memiliki keterbatasan dalam memberikan fokus perhatian hanya pada satu hal di waktu terbatas. Mereka tidak mudah melakukan konsentrasi dalam waktu yang lama. Mereka perlu dirangsang dengan stimulasi dengan cara yang bervariasi dan interaktif yang dapat menarik perhatian.

9. Ekspresif

Remaja generasi Net cenderung suka mengekspresikan dirinya dan butuh ruang untuk menunjukkan keberadaannya tersebut. Proses pembelajaran pada remaja diharapkan dapat memberikan kesempatan pada para remaja untuk menyalurkan dan menghormati kebutuhan tersebut.

10. Instan

Generasi ini ingin memperoleh hasil secara cepat tanpa mencermati proses yang dijalani.

Berbagai karakteristik yang disampaikan di atas tidak berlaku sepenuhnya pada setiap remaja. Hal ini merupakan cerminan generasi Z secara umum. Informasi karakteristik remaja diharapkan dapat membantu masing-masing individu yang ingin memberikan edukasi pada remaja, terutama dalam membantu memahami remaja sebagai peserta didik. Sehingga diharapkan dapat membantu mempersiapkan metode dan media pembelajaran serta pendekatan yang sesuai agar hasilnya bisa optimal.

Remaja mengalami proses tumbuh kembang yang memengaruhi cara remaja berperilaku dan berpikir. Perkembangan otak sangat memengaruhi perubahan perilaku dan pola pikir pada manusia. Remaja merupakan individu dengan perkembangan otak yang cepat. Lobus frontal yang terletak di belakang dahi merupakan salah satu bagian otak yang berkembang pesat. Lobus frontal mengendalikan proses pertimbangan norma dan nilai, pengambilan keputusan, spontanitas, perencanaan, konsekuensi dan perilaku sosial. Bagian otak lainnya yaitu bagian limbik yang terletak di bagian tengkuk memiliki perkembangan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan lobus frontal. Bagian ini menstimulasi manusia untuk menyenangkan sesuatu, mencoba sesuatu, menghadapi tantangan, merasa sedih, senang, kecewa, dan berbagai jenis emosi yang lain. Seandainya kedua bagian tersebut divisualisasikan sebagai bagian dari kendaraan, maka bagian limbik ini diibaratkan sebagai gas, dan lobus frontal merupakan remnya. Perkembangan gas pada remaja cenderung lebih cepat dari remnya. Kondisi tersebut mengakibatkan remaja lebih condong menyenangkan tantangan, makin emosional, dan memiliki kerentanan untuk melakukan sesuatu yang berisiko akan tetapi remaja belum sanggup untuk berpikir tentang konsekuensi dari perbuatannya itu.

Perilaku berisiko merupakan salah satu dari berbagai potensi kerentanan yang bisa terjadi pada remaja. Perilaku berisiko merupakan karakter perbuatan yang bisa merugikan kesehatan dan kesejahteraan remaja serta orang lain (Kemenkes RI, 2022). Perilaku pada diri remaja yang berisiko ini dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam remaja tersebut (proses tumbuh kembang dan kepribadian) dan faktor dari luar (teman, sekolah, keluarga, dan lingkungan di sekelilingnya serta pengaruh teknologi online). Salah satu perilaku berisiko dari 8 masalah kesehatan remaja menurut pemerintah yang paling banyak mendapat perhatian adalah masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Masalah kesehatan yang dimaksud berhubungan dengan pematangan organ reproduksi, perubahan biologis, dan perkembangan reproduksi remaja. Bekal ilmu tentang kesehatan reproduksi merupakan urusan yang sangat bermanfaat diberikan pada remaja. Bekal pengetahuan tentang

kesehatan reproduksi yang baik dapat mendukung perubahan yang positif dalam diri remaja.

C. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja

Remaja Indonesia memiliki berbagai variasi tingkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Tingkatan pengetahuan ini belum merata di berbagai daerah. Di pulau Jawa, sebagian penelitian menyatakan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi ada pada tingkatan cukup dan baik. Namun kondisi pengetahuan yang baik ini tidak sama dengan daerah lainnya. Penelitian Nislawaty et al (2022) tentang gambaran pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi di salah satu SD pada provinsi Riau menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan sebagian besar memiliki keterpaparan informasi negatif pada kesehatan reproduksi.

Pada aspek kesehatan reproduksi yang lebih spesifik, misalnya menstruasi memiliki gambaran pengetahuan yang berbeda. Menurut penelitian Solehati et al pada tahun 2018 didapatkan hasil bahwa semua responden memiliki pengetahuan yang buruk terkait menstruasi dan sebagian besar memiliki sikap tidak mendukung tentang perawatan selagi menstruasi.

Pengetahuan yang beragam ini tentu saja akan berdampak pada sikap dan perilaku yang bervariasi pula. Pengetahuan yang baik menurut berbagai sumber dikatakan menjadi satu diantara berbagai faktor yang memengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Pengetahuan kesehatan yang baik juga dapat meningkatkan literasi kesehatan seseorang sehingga nantinya mampu membuat keputusan yang baik terkait kesehatan dirinya. Remaja merupakan individu dengan tingkat penasarannya yang cukup tinggi terhadap berbagai hal. Mereka cenderung ingin mengeksplorasi berbagai hal yang baru. Hal ini sebetulnya dapat dimanfaatkan secara positif dengan memberikan pengetahuan tentang kesehatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan yaitu melalui pendidikan kesehatan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan berdampak positif pada peningkatan pengetahuan tentang kesehatan. Pendidikan kesehatan juga mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku dan sikap. Pendidikan kesehatan dalam konteks kesehatan reproduksi sangat diperlukan bagi remaja terutama dalam perkembangan reproduksinya. Informasi yang kurang tepat terkait kesehatan reproduksi, minim pengetahuan terkait kesehatan reproduksi juga dapat meningkatkan kemungkinan remaja bersinggungan dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti infeksi sistem reproduksi, kehamilan dini, pernikahan dini, bahkan infeksi menular seksual.

Pendidikan kesehatan reproduksi sendiri merupakan proses pembelajaran yang berhubungan dengan reproduksi melalui pemberian informasi, pemahaman, penanaman nilai, dan keterampilan. Menurut UNESCO (2017) dalam Kemenkes

(2022), tujuan edukasi kesehatan yang menyeluruh yaitu untuk membekali remaja dan anak lewat informasi yang tepat (pengetahuan), mengembangkan lifeskills /kemampuan bertahan hidup, menciptakan sikap, dan nilai-nilai yang baik agar dapat menguatkan anak dan remaja untuk:

1. Mewujudkan kesehatan, martabat, serta kesejahteraan anak dan remaja
2. Menumbuhkan interaksi sosial dan seksual yang penuh martabat
3. Memperhitungkan betapa pilihan mereka akan memengaruhi kesejahteraan diri sendiri dan orang lain
4. Mengetahui serta meneguhkan perlindungan atas hak anak dan remaja

Pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja seharusnya mampu membantu remaja dalam memperoleh informasi yang komprehensif tentang berbagai dimensi kesehatan reproduksi supaya mendorong anak muda dalam menentukan pilihan yang baik, sehat, berbahagia, dan bertanggungjawab terkait dengan kesehatannya. Pendidikan kesehatan kesehatan reproduksi terbukti dapat berpengaruh positif terhadap pengetahuan, sikap maupun perilaku remaja. Berbagai penelitian telah membuktikan hal tersebut. Millenia et al (2022), Fidora, I., & Utami, A. S. (2022) menyatakan bahwa edukasi kesehatan reproduksi dapat meningkatkan dan memberi pengaruh signifikan pada tingkat pengetahuan remaja.

Pendidikan kesehatan pada remaja dapat memberikan pengaruh pada sikap remaja terhadap kesehatan. Remaja berpengetahuan baik dapat membangun sikap yang positif baik yang berkontribusi meningkatkan motivasi remaja agar berperilaku hidup sehat. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian bahwa pendidikan kesehatan memiliki dampak positif dalam perubahan sikap remaja. Rofi'ah S (2017) menyampaikan dalam penelitiannya bahwa terdapat peningkatan sikap remaja sebelum dan sesudah dibekali dengan edukasi kesehatan. Remaja bersikap kurang mendukung tadinya mencapai 50%, kemudian berubah menjadi memiliki sikap mendukung sebesar 94,1 %. Peningkatan perubahan sikap ini cukup signifikan setelah pemberian pendidikan kesehatan. Hal ini didukung oleh Cahyani et al (2019) dan Setiawati et all (2022) yang menyampaikan bahwa edukasi kesehatan reproduksi berdampak positif terhadap terhadap sikap dan pengetahuan remaja kesehatan reproduksi.

Pendidikan kesehatan reproduksi juga mendukung perubahan perilaku kesehatan pada remaja. Informasi yang tidak valid mengenai kesehatan reproduksi dapat menghasilkan wawasan dan pemahaman yang salah pada remaja dan dapat mengakibatkan remaja melakukan hal yang menyimpang, seperti hubungan seksual pranikah yang bisa berakibat pada kehamilan dan pernikahan dini. Remaja perlu mendapatkan informasi yang relevan, valid, dan terpercaya terkait kesehatan reproduksi supaya dapat mendukung perilaku kesehatan reproduksi yang baik salah satunya melalui pendidikan kesehatan reproduksi. Perilaku yang baik pada

kesehatan reproduksi dapat dipengaruhi oleh pendidikan kesehatan reproduksi yang diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Yulfitria, F et al (2021); Saputra, Y.A, et.al (2021); Artini, B, et. Al (2021);Astuti, P.T, et al (2021); Passe, R et al (2021); dan Pratiwi, W.D & Sudaryanto, A (2024) dalam penelitiannya menguatkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode apapun telah terbukti memengaruhi penurunan perilaku seksual yang berisiko di kalangan remaja. Dan meningkatkan perilaku positif terkait kesehatan reproduksi

Berbagai penelitian dan jurnal yang ditampilkan di atas menjadi bukti atas keberhasilan edukasi kesehatan reproduksi dalam memengaruhi kognitif, afektif, dan psikomotor remaja terkait kesehatan reproduksinya. Pendidikan kesehatan reproduksi dapat mengoptimalkan pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi. Pengetahuan baik tentang kesehatan reproduksi dapat menumbuhkan sikap positif terhadap kesehatan reproduksi. Sikap yang baik tersebut mampu meningkatkan perilaku baik terkait kesehatan reproduksi dan menurunkan aktivitas berisiko pada kesehatan reproduksi.

Pendidikan kesehatan reproduksi seharusnya memenuhi dimensi-dimensi sebagai berikut (Kemenkes RI, 2022):

1. Bersumber bukti ilmiah
Informasi yang diberikan dalam pendidikan kesehatan merupakan informasi yang berdasarkan data yang valid dan telah teruji secara ilmiah.
2. Bertahap
Pendidikan kesehatan diberikan sebagai proses pembelajaran terus berkembang dan berkesinambungan
3. Pendidikan kesehatan disesuaikan dengan umur dan keunikan perkembangan remaja
Pemberian informasi harus sesuai dengan tumbuh kembang remaja dan hendaknya memperhatikan aspek kemampuan remaja dalam memproses dan memahami informasi sehingga dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari remaja.
4. Berdasarkan pada kurikulum
Pendidikan kesehatan memiliki arah yang jelas dan metode yang sistematis.
5. Komprehensif
Pendidikan kesehatan meliputi berbagai dimensi kesehatan reproduksi. Dimensi yang dimaksud adalah organ reproduksi, pubertas, menstruasi, kehamilan, Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV dan AIDS. Pendidikan kesehatan juga meliputi keterampilan hidup, hubungan personal, kesetaraan gender, dan lain-lain.
6. Berdasarkan pada pendekatan hak asasi manusia

Meliputi hak atas informasi yang berimbang serta hak anak dan anak muda. Selain itu juga dan menumbuhkan kesadaran remaja tentang hak mereka dan penghormatan pada hak orang lain.

7. Berasaskan kesetaraan gender

Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dan hak yang sama serta diperlakukan setara dalam semua aspek. Kesetaraan gender ini juga wajib ada pada kesetaraan dalam memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

8. Transformatif

Pendidikan kesehatan seharusnya memberikan pembelajaran dan informasi yang dapat memotivasi remaja agar bisa mengaplikasikannya dalam berbagai dimensi kehidupan. Selain itu juga dapat memotivasi remaja untuk memberikan andil yang lebih banyak pada masyarakat.

9. Menyesuaikan budaya dan konteks setempat

Pendidikan kesehatan yang diberikan hendaknya menghormati budaya yang berbeda, tidak memaksakan nilai, dan dapat memotivasi kesadaran mendalam tentang berbagai dampak sehingga lebih baik dalam mengambil berbagai keputusan.

10. Mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kesehatan

Kecakapan ini meliputi keterampilan hidup (*lifeskill*)

Topik pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif menurut Kemenkes (2022) sebaiknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan; relasi dengan keluarga, orang lain, persahabatan dan pertemanan, cinta dan hubungan romantis, toleransi, inklusi, dan saling menghormati, komitmen jangka panjang dan persiapan menjadi orang tua .
2. Hak, Nilai, dan Budaya; berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas.
3. Pemahaman Gender; norma gender, konstruksi gender, kesetaraan gender, stereotip, dan bias gender, kekerasan berbasis gender.
4. Kekerasan dan Cara Menjaga Diri; mencegah perilaku kekerasan, persetuhuan, privasi dan hak atas tubuh, pemanfaatan teknologi informasi yang aman.
5. Kompetensi dan Kecakapan menjaga Kesehatan dan Kesejahteraan; norma dan pengaruh teman tentang perilaku seksual, komunikasi, pengambilan keputusan, keterampilan negosiasi dan menolak, literasi seksualitas dan media, mengidentifikasi pertolongan dan layanan.

6. Tubuh dan Perkembangannya; organ reproduksi dan fungsinya, tumbuh kembang remaja, pubertas dan citra diri.
7. Perilaku dan Seksualitas; mengatur perilaku seksual dan dorongan seksual
8. Kesehatan Reproduksi; kehamilan dan tindakan preventif kehamilan, HIV dan AIDS, stigma, tata laksana, pengobatan dan menyatakan suport terkait HIV dan AIDS, mengerti dan mengurangi risiko IMS.

Perlu menjadi catatan bahwa unsur utama pada pendidikan kesehatan reproduksi ialah membagikan keterampilan pada remaja agar bisa mempertimbangkan berbagai pilihan dan mewujudkan satu keputusan yang baik sehingga bisa membantunya menjadi remaja yang bahagia dan sehat. Keterampilan ini wajib mencakup pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Transfer kemampuan ini bukan dengan pembelajaran satu arah saja, akan tetapi perlu memotivasi peserta didik agar aktif berpartisipasi, membuka celah untuk diskusi yang besar, serta mengadakan konseling. Hal ini diperlukan agar remaja lebih berdaya.

Selain itu, remaja perlu mempunyai lifeskills yang baik secara personal maupun sosial agar remaja menjadi mampu dan berdaya. Pendidikan kesehatan reproduksi perlu mengajarkan tentang keterampilan hidup kepada peserta didik. Menurut WHO (1997) dalam Kemenkes RI (2022), keterampilan hidup merupakan kekuatan untuk menyesuaikan diri dan merupakan perilaku positif yang diperlukan seseorang untuk menghadapi tantangan dan keperluan hidup setiap hari secara efektif. Salah satu keterampilan hidup yang penting bagi remaja yaitu Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS).

Keterampilan hidup sehat merupakan kekuatan yang diperlukan dalam membentuk pola pikir dan perilaku sehingga menjadi serangkaian aktivitas yang terintegrasi dan dapat diterima oleh lingkungan budaya setempat atau memiliki tujuan interpersonal yang mengarah pada perilaku hidup sehat baik secara sosial, fisik, dan mental (Kemenkes RI, 2022). PKHS telah diintegrasikan dalam berbagai modul kesehatan reproduksi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kesehatan reproduksi yang lebih baik dapat dicapai melalui penerapan keterampilan hidup sehat.

Kemenkes RI (2022) menyampaikan 10 komponen keterampilan yang termasuk dalam PKHS antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran diri. Keterampilan agar mahir dalam mengenal dirinya sendiri (kekuatan, karakter, keinginan, kelemahan)
2. Empati. Kemampuan untuk memposisikan perasaan orang lain pada dirinya
3. Pengambilan keputusan. Kemampuan melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan

4. Pemecahan Masalah. Kemampuan mengatasi permasalahan yang dihadapi secara konstruktif
5. Berpikir Kritis. Kemampuan menelaah informasi dan pengalaman yang didapatkan.
6. Berpikir Kreatif. Mampu menciptakan gagasan baru
7. Komunikasi Efektif. Mampu mengemukakan pandangan
8. Hubungan Interpersonal. Mampu berhubungan dengan orang lain dengan positif dan harmonis
9. Mengendalikan Emosi. Mampu mengekang gejolak emosi sehingga dapat mengendalikan perilakunya
10. Mengelola Stress. Mampu mengenali sumber stress, efeknya dan cara mengatasinya.

Pembelajaran PKHS ini memerlukan metode pembelajaran dengan aktivitas yang menarik dan interaktif serta situasi belajar yang mendukung. Penguasaan kompetensi dalam PKHS pada remaja dapat memberikan manfaat untuk mengatasi kendali lingkungan sekitar terutama teman sebaya, menghindari perilaku berisiko, serta membantu remaja membuat keputusan dan merespon ancaman agar terhindar dari tindak kekerasan baik fisik/psikis.

Pendidikan kesehatan reproduksi diharapkan dapat mengembangkan tiga dimensi pada diri peserta didik, yakni:

1. Pengetahuan, yakni informasi dan pengetahuan tentang pembelajaran yang disampaikan. Transformasi yang dirasakan adalah dari tidak mengetahui menjadi mengetahui.
2. Sikap, yakni dimensi emosi atau afektif mengenai sesuatu terkait dengan norma atau nilai yang diyakini dan dianut. Transformasi yang dirasakan adalah dari tidak mau melakukan menjadi mau melakukan.
3. Keterampilan, yakni dimensi kecakapan agar bisa melakukan sesuatu. Transformasi yang dirasakan adalah dari tidak tidak mampu melakukan menjadi mampu melakukan.

Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan memengaruhi agar bisa membentuk perilaku sehat dan bertanggung jawab dalam konteks kesehatan reproduksi. Metode pembelajaran partisipatif merupakan metode pembelajaran yang paling sesuai diterapkan sehingga bisa mendukung pengembangan tiga dimensi tersebut. Berbagai metode partisipatif yang dapat diterapkan misalnya ceramah, debat, diskusi kelompok, curah pendapat, lokakarya, bermain peran, simulasi, demonstrasi, pembelajaran kasus, permainan dan kuis, field study (kunjungan), observasi, pemutaran film, refleksi, dan lain sebagainya.

Pendidikan kesehatan reproduksi sangat erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Sehingga diharapkan pemberian pendidikan kesehatan reproduksi ini hendaknya diiringi dengan tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi yang simpatik bagi remaja termasuk rujukan dan konseling di fasilitas kesehatan. Pemberian akses terhadap edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi untuk remaja diperlukan untuk mewujudkan individu yang mampu serta berdaya. Dalam hal ini mampu mendorong kemandirian remaja untuk mengelola fungsi, proses reproduksi dan kehidupan seksualnya dengan baik.

Di era society 5.0 saat manusia hidup berdampingan dengan teknologi digital, kita perlu mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dengan teknologi digital. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan kesehatan tersebut bisa mengikuti jamannya dan diterima dengan baik oleh remaja yang merupakan generasi digital.

D. Teknologi Digital

Teknologi digital berkaitan dengan pemanfaatan perangkat elektronik dan komputer untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi dalam bentuk digital, yang terdiri dari serangkaian angka nol dan satu (Rotikan et al, 2024). Teknologi digital merupakan hal yang tak terpisahkan dalam society 5.0 khususnya pada remaja. Remaja saat ini sudah menjadi bagian integral dari internet dan teknologi digital sejak kecil. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi cara mereka bergaul, melakukan komunikasi, memutuskan hal yang penting untuk mereka. Kedekatan dengan teknologi digital juga memengaruhi cara mereka berperilaku dan membuat keputusan dalam hidupnya.

Nauvan et.al (2024) menyampaikan bahwa teknologi digital memberikan pengaruh yang bermakna pada perilaku sosial generasi muda, baik secara positif maupun negatif. Pada penelitiannya disampaikan bahwa penggunaan media sosial memberikan kemungkinan bagi generasi muda untuk saling terhubung dan memudahkan mereka dalam membina hubungan sosial. Media sosial memberikan akses pada generasi muda pada berbagai sumber informasi dan komunitas yang memiliki minat yang sama. Sebagian besar responden merasakan manfaat dari media sosial. Meskipun memberikan manfaat yang besar, namun media sosial juga memberikan tekanan untuk mempertahankan citra diri yang sempurna, sebagian besar mengalami tekanan sosial yang mengganggu kesejahteraan psikologisnya. Ketergantungan pada media sosial dapat menimbulkan perasaan tertekan, isolasi, dan permasalahan kesehatan jiwa yang berat. Lee, J & Zarnic , Z (2024) mengemukakan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dengan cara memfasilitasi pelayanan preventif dan pelayanan kesehatan secara online. Meskipun demikian penggunaan berlebihan teknologi digital dapat berdampak pada gangguan kesehatan mental dan perilaku pada generasi muda.

Teknologi digital memiliki berbagai dampak baik positif dan negatif bagi generasi muda saat ini. Dampak positif perkembangan teknologi digital adalah sebagai berikut:

1. Media komunikasi. Teknologi digital memungkinkan terjadinya interaksi antar pengguna melalui jalur komunikasi tanpa batas. Para pengguna internet dapat berkomunikasi dengan satu orang dan sekelompok orang dimana saja dengan mudah. Media sosial merupakan aplikasi yang mendukung komunikasi di internet. Saat ini perkembangan media sosial terjadi sangat pesat. Media sosial memiliki banyak ragam jenis dengan karakteristik dan keunikan masing-masing. Media sosial seperti Instagram, Tiktok, X, Facebook, Whatsapp, Youtube, dan lain-lain sering dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi interaktif.
2. Media pertukaran data. Teknologi digital memungkinkan terjadinya pemindahan atau pertukaran data dengan mudah. Kegiatan penerimaan dan pengiriman data ini dapat dilakukan melalui *e-mail*, teknologi *cloud*, *Google drive*, dan lain sebagainya.
3. Media untuk mencari informasi dan berita. Saat ini kita dengan mudah dapat menerima informasi kapan saja dan dari belahan dunia manapun melalui android. Berita yang terjadi di suatu negara dapat diakses di berbagai belahan dunia di hari yang sama dengan di negara tersebut. Jika dulu kita mengakses berita melalui media cetak seperti koran, buku dan lainnya, maka saat ini kita dapat mengakses berita melalui situs situs berita online yang berbasis internet. Penelusuran berita dan informasi melalui internet disediakan oleh berbagai mesin pencari atau *search engine* seperti Google, Firefox, Bing, dan lain-lain.
4. Media bisnis. Teknologi digital juga menambah performa bisnis secara online melalui *e-commerce*. Berbagai transaksi bisnis dan penjualan dapat dilakukan melalui situs jual-beli maupun blog komersil. Berbagai perusahaan *startup* menawarkan pelayanan penyedia barang maupun jasa yang berbasis online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain.
5. Media hiburan. Teknologi digital menawarkan berbagai macam alternatif hiburan seperti *streaming* film dan olahraga, *game online*, karaoke online dan lain-lain. Semua aktivitas hiburan tersebut dapat diakses melalui online tanpa terbatas ruang maupun waktu.
6. Media belajar dan stimulasi kreativitas. Semua orang bisa mempelajari tentang beragam hal melalui internet. Perkembangan berbagai media pembelajaran yang diakses secara online menjadi sangat pesat. Materi pembelajaran juga beragam seperti pengetahuan, teknologi, gaya hidup dan lain-lain. Internet juga menawarkan pembelajaran dari usia dini hingga lanjut usia.

7. Media mengekspresikan diri. Kita hidup di era saat eksistensinya di dunia maya menentukan identitas dan keberadaan seseorang. Banyak orang mengekspresikan dirinya kepada orang lain melalui internet. Orang menunjukkan hasil pekerjaan, minat, keterampilan yang dimiliki, bahkan kehidupan sehari-harinya melalui media sosial dan media internet.

Selain memberikan dampak yang baik pada remaja, teknologi digital juga dapat memberikan dampak buruk bagi remaja sebagai berikut menurut Gede (2011) dalam Kemenkes (2022);

1. Pelanggaran hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak khusus yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Teknologi digital menyajikan beragam informasi dengan jumlah sangat banyak. Hal ini memungkinkan orang untuk mengambil informasi dan tanpa mengindahkan sumber atau pembuat informasi sehingga terjadi pelanggaran hak cipta.
2. Kejahatan online. Kejahatan di internet tidak memedulikan batas negara dan teritorial. Kejahatan tersebut dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Kejahatan internet ini merupakan perbuatan ilegal dan tidak etis dengan memanfaatkan perangkat yang berkaitan dengan internet dan komputer. Kejahatan internet juga menimbulkan dampak kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan biasa. Bentuk kejahatan internet ini bisa berupa pencurian uang, penipuan, penggunaan identitas orang lain, pembajakan data dan materi privasi, maupun berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual.
3. Penyebaran virus dan ancaman digital lainnya. Virus komputer merupakan suatu program berukuran kecil, parasit, dan memperbanyak dirinya mirip menyerupai file atau folder, serta meresahkan pengguna komputer yang terinfeksi. Virus komputer meluas melalui berbagai media termasuk media internet dan penyimpanan seperti *Flash Disk*, *Hard Disk*, dan *Memory Card*.
4. Pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Internet banyak menyajikan tindakan pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan yang dapat segera disitir oleh para penggunanya. Tindakan tersebut kadang muncul dalam tayangan iklan komersial pada situs-situs tertentu, streaming video tanpa sensor, dan lain sebagainya.

Dalam kesehatan reproduksi, internet telah mengubah cara remaja berkomunikasi, belajar, dan mendapatkan akses informasi. Dampak baiknya, internet menyediakan peningkatan akses informasi, orang, dan komunitas tentang

kesehatan reproduksi yang baik dan benar. Pemanfaatan media digital oleh remaja terkait kesehatan reproduksi adalah sebagai berikut:

1. Media digital dapat digunakan untuk menciptakan, menyebarluaskan, dan mengakses informasi kesehatan reproduksi.
2. Media digital dapat mengembangkan komunitas dan mengakses dukungan dan pelayanan kesehatan reproduksi di luar lingkungan.
3. Media sosial dapat mendorong perkembangan remaja yang sehat dengan menggali norma dan kesehatan reproduksi.
4. Media sosial dapat digunakan untuk membangun hubungan/relasi.

Internet bisa menyebabkan berbagai risiko seperti risiko gangguan fisik, risiko kecanduan internet, risiko pornografi, risiko perundungan siber (cyberbullying), dan risiko penyebaran hoax. Risiko secara fisik berupa gangguan kesehatan mata, gangguan tidur (jam dan lama waktu tidur tidak teratur), ketidakseimbangan perkembangan tubuh, gangguan pencernaan, nyeri di bagian tubuh tertentu, dan cedera atau kecelakaan.

Internet juga bisa menyebabkan adiksi/kecanduan. Adiksi/kecanduan merupakan ketergantungan yang diinterpretasikan sebagai suatu pola perilaku yang bisa meningkatkan risiko penyakit dan permasalahan individu maupun permasalahan sosial. Perilaku adiktif umumnya dialami secara subjektif sebagai hilangnya kendali diri, perilaku terus muncul meskipun sudah ada upaya untuk menghentikan perilaku tersebut (Marlat dkk, 1998 dalam Thoms, 2006 dalam Kemenkes RI, 2022). Ada berbagai hal yang dapat menyebabkan seorang remaja rentan mengalami kecanduan internet, yaitu: 1) Penggunaan teknologi digital melebihi 20 jam/minggu pada remaja (kecuali belajar dan bekerja); 2) Remaja sering memiliki rasa khawatir dan sedih yang tidak wajar; 3) remaja sering mempunyai kesulitan dalam relasi dengan teman dan orang tua karena minimnya interaksi secara langsung; 4) Remaja banyak memakai internet untuk bermain game online dan bermedia sosial; 5) Penggunaan internet pertama kali saat berusia kurang dari 8 tahun; 6) Tidak ada pendampingan orang tua saat remaja menggunakan internet dan orang tua membiarkan saja remaja bermain internet terlalu lama.

Selain menyebabkan berbagai risiko yang telah disebutkan di atas, internet juga dapat menyebabkan terjadinya berbagai risiko yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Risiko teknologi digital terkait kesehatan reproduksi dapat terjadi meliputi tiga jenis risiko yaitu risiko kontak, risiko perilaku dan risiko konten. Risiko kontak bisa terjadi ketika remaja terhubung dalam komunikasi yang berisiko dengan orang lain. Komunikasi berisiko tersebut bisa dalam bentuk komunikasi yang tidak pantas baik antar remaja maupun orang dewasa baik secara online maupun offline. Pelaku komunikasi tidak pantas ini biasanya disebut predator. Seringkali modus operandi predator adalah berpura-pura menjadi teman, membuat

remaja percaya sehingga akhirnya dibujuk melakukan hal-hal yang tidak pantas termasuk yang berkaitan dengan aksi pornografi dan pornoaksi. Terkadang kegiatan tersebut dilakukan dengan imbalan uang atau barang. Kegiatan ini dapat berupa seksual online, pelecehan, dan eksploitasi seksual secara online. Aksi ini bisa dengan meminta remaja melakukan aksi seksual, photo tanpa busana, dan lain sebagainya.

Risiko selanjutnya ialah risiko perilaku/tindakan. Ada berbagai macam bentuk keterlibatan remaja dalam tindakan di dunia maya yang berdampak merugikan diri sendiri dan orang lain. Remaja bisa melakukan diskriminasi dan cyberbullying; menyebarkan sesuatu tanpa persetujuan, dan revenge porn (pornografi balas dendam). Diskriminasi dan cyberbullying dapat dilakukan dengan menghina, mengejek, atau merendahkan secara online lewat media sosial maupun media internet yang lainnya. Pelaku diskriminasi dan cyberbullying dapat melakukan tindakannya dengan menyembunyikan identitas asli sehingga pelaku dapat merasa bebas dan aman dalam melakukan tindakan tersebut. Risiko perilaku yang selanjutnya adalah menyebarkan foto/video pribadi lewat internet atau menunjukkan foto/video pribadi pada orang lain tanpa ijin/persetujuan pemilik atau objek foto/video tersebut. Risiko perilaku lainnya adalah revenge porn. Ilustrasi cerita untuk menjelaskan kegiatan ini misalnya, seorang remaja X berpacaran dengan remaja Y. Saat berpacaran dengan harmonis remaja X beberapa kali memberikan foto/video berpose seksi atau tanpa mengenakan busana. Ketika kemudian mereka putus, remaja Y menyebarluaskan foto/video pribadi remaja X di internet dengan maksud untuk menyakiti atau mempermalukan remaja X. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental remaja X. Tindakan remaja Y ini termasuk dalam pelecehan online.

Risiko konten pada remaja meliputi risiko remaja mengakses materi yang tidak diinginkan, tidak patut, atau mengancam yang berisi tentang pornografi, kekerasan, diskriminatif maupun berita yang tidak benar. Paparan konten pornografi tidak dengan pendampingan maupun edukasi kesehatan yang holistik dapat membentuk pandangan yang tidak benar tentang norma gender dan seksualitas pada remaja. Pornografi banyak mempertontonkan kekerasan seksual, aktivitas seksual yang tidak aman, dan tidak adanya persetujuan. Semuanya bisa memengaruhi perilaku seksual remaja. Banyak berkembangnya informasi yang salah di internet terkait kesehatan reproduksi juga dapat menjadi risiko konten. Tidak semua situs online dapat dipercaya. Situs online bisa saja berisi hoax maupun informasi yang tidak berdasarkan fakta ilmiah.

Selain menimbulkan berbagai permasalahan dan risiko pada remaja, internet dan media sosial juga dapat digunakan untuk memberikan manfaat yang luas bagi kesehatan salah satunya pendekatan teknologi digital pada pemberian edukasi kesehatan reproduksi remaja.

E. Pendekatan Teknologi Digital dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Saat ini kita semua berada pada era society 5.0. era ini memiliki konsep bermasyarakat yang unik, berpusat pada manusia dan senantiasa menggunakan teknologi dalam mengatasi tantangan sosial di sekitarnya. Konsep ini berawal dari usulan Jepang di tahun 2016. Sejak saat itu kehidupan senantiasa beriringan dengan teknologi, utamanya teknologi digital. Teknologi digital merasuki semua sendi kehidupan manusia termasuk para remaja.

Kehidupan remaja saat ini sangat bergantung pada teknologi digital. Kondisi yang demikian dapat berdampak positif jika teknologi dimanfaatkan dalam hal yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesehatan remaja salah satunya melalui edukasi kesehatan. Pendekatan teknologi digital dalam edukasi kesehatan pada remaja termasuk di dalamnya edukasi kesehatan reproduksi diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan dapat diterima dengan baik oleh remaja yang kehidupan hariannya tidak lepas dari gawai dan berbagai perangkat teknologi digital lainnya.

Digitalisasi dalam dunia kesehatan, terutama pada pelayanan kesehatan menjadi strategi yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di era society 5.0 ini. Amalia, A (2024) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa digitalisasi kesehatan menjadi elemen dari upaya potensial dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara merata. Keberhasilan digitalisasi kesehatan ini memerlukan pendekatan yang terus menerus untuk menghadapi tantangan yang ada dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan. Salah satu bentuk digitalisasi kesehatan adalah melalui digitalisasi media edukasi dalam upaya promotif dalam bidang kesehatan melalui pendidikan kesehatan.

Hasibuan et all (2024) menyampaikan bahwa meskipun mayoritas masyarakat sudah sering mendapatkan informasi kesehatan secara online, namun masih ada kesenjangan interpretasi dan pelaksanaan pola hidup sehat secara benar. Oleh sebab itu diperlukan solusi yang tepat untuk menambah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui program edukasi kesehatan yang menggunakan teknologi digital, seperti webinar, aplikasi kesehatan, dan konten edukasi interaktif. Kolaborasi dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyedia layanan kesehatan juga sangat penting dilakukan untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan dengan teknologi digital tersebut bersifat akurat, gampang dimengerti, dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Mustofa, R. A. B., & Sani, M. (2024) menyampaikan dalam penelitiannya bahwa edukasi kesehatan menggunakan media sosial terbukti efektif untuk menambah pengetahuan kesehatan dan juga dapat memberikan motivasi pada perubahan perilaku yang sehat. Tantangan yang dihadapi pada edukasi jenis ini yaitu penyampaian informasi yang tidak valid, terbatasnya literasi dan akses digital, dan masalah keamanan data serta privasi. Meskipun demikian, penelitian ini

menyampaikan bahwa media sosial memiliki potensi tinggi menjadi media promosi kesehatan yang efektif untuk remaja. Tantangan yang ada perlu diatasi dengan strategi yang tepat melalui edukasi literasi digital dan peningkatan peraturan untuk menjamin ketepatan informasi.

Penelitian tersebut didukung oleh Yana et.al (2024) yang melakukan literatur review pada 15 jurnal dari berbagai sumber yang relevan. Literatur revidu yang dilakukan untuk mengetahui penggunaan media edukasi secara online untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. Jurnal yang digunakan memuat pemanfaatan media edukasi melalui video, mHealth, jejaring sosial, ponsel aplikasi dan chatbot AI. Menurut penelusuran literatur, ditemukan bahwa pemanfaatan bermacam-macam media edukasi dengan pendekatan teknologi digital memberikan keuntungan dalam memberikan edukasi promosi kesehatan, khususnya dalam meningkatkan sudut pandang, pengetahuan, dan mendorong remaja berperilaku sehat.

Hal serupa juga ditemukan oleh Susanti et al (2022). Beliau melakukan penelitian tentang pengaruh teknologi digital terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Hasilnya menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital untuk media pembelajaran merupakan cara yang praktis, interaktif, dan menyenangkan. Interaksi di dunia maya melalui media sosial lebih diminati wanita terutama remaja jika dibandingkan edukasi kesehatan konvensional.

Berikut ini merupakan beberapa pendekatan teknologi digital dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja:

1. Website

Website menjadi salah satu media pembelajaran kesehatan reproduksi remaja. Ada beberapa website yang memberikan konseling dan layanan kesehatan reproduksi pada remaja secara daring. Choice for Youth and Sexuality melalui website www.choiceforyouth.org merupakan organisasi non-profit yang berkomitmen pada kesehatan dan hak reproduksi seksual generasi muda. Salah satu tujuan website ini adalah mendorong pendidikan seks yang komprehensif. Website ini berbahasa Inggris. Selain website ini, ada website yang diprakarsai oleh mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia dari IPB University yaitu www.GEKA.id. Website ini merupakan situs web edukasi untuk mencegah seks bebas pada remaja di Kabupaten Kampar Riau. Website ini berbahasa Indonesia. Website yang berfokus pada edukasi reproduksi yang lain adalah www.wrhc-indonesia.com. Women's Reproductive Health Center (WRHC) Indonesia adalah pusat kajian kesehatan reproduksi perempuan dan isu gender. WRHC memberikan layanan informasi, edukasi, dan konsultasi kesehatan reproduksi.

2. Aplikasi Android/Ios

Aplikasi android merupakan salah satu pilihan untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Salah satunya adalah aplikasi Oky yang dibuat oleh UNICEF Indonesia. Aplikasi Oky ialah aplikasi berbasis android dan iOS. Aplikasi diinisiasi oleh UNICEF untuk membantu remaja perempuan dalam melacak siklus menstruasi. Aplikasi berbasis android yang dikembangkan di Indonesia lainnya adalah aplikasi kesehatan reproduksi remaja (KEREPAARE) berbasis android. Aplikasi ini diinisiasi oleh Purnamasari, W. M. et al (2022). Beliau menyampaikan dalam penelitiannya bahwa aplikasi KEREPAARE ini sangat layak untuk digunakan sebagai media edukasi.

3. E-booklet.

Program BERANI ini merupakan program kerjasama pemerintah Indonesia, UNFPA, UNICEF, dan pemerintah Kanada yang menginisiasi Better and Sexual Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI). BERANI merupakan publikasi bersama untuk menguraikan program UNICEF dan UNFPA dalam menangani hak, kesehatan seksual dan reproduksi yang merupakan penentu utama kualitas hidup perempuan dan anak perempuan. UNICEF mendokumentasikan berbagai program dalam publikasi ini termasuk didalamnya menyediakan layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah remaja, pencegahan kekerasan berbasis gender dan pernikahan anak. Publikasi bersama ini diterbitkan dalam bentuk e-booklet.

4. Ebook.

E-book pendidikan kesehatan reproduksi terkait menstruasi dengan judul Apa itu Menstruasi? E-book tersebut dibuat tahun 2017 dengan sasaran anak sekolah dan anak usia remaja dan merupakan kerjasama antara kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan UNICEF. Ebook ini merupakan panduan dan edukasi mengenai menstruasi baik bagi anak. Ebook dibuat dalam 2 bagian yaitu panduan untuk anak perempuan dan panduan untuk anak laki-laki. Contoh ebook yang lain adalah ebook dengan judul Manajemen kebersihan Menstruasi dan pencegahan perkawinan anak. Ebook diterbitkan oleh UNICEF Indonesia di tahun 2020. E-book ini merupakan upaya edukasi tentang tata laksana kebersihan saat menstruasi pada anak remaja. Ebook ini juga merupakan salah satu usaha pencegahan praktik perkawinan anak yang sering terjadi di masyarakat.

5. Media social.

Media sosial banyak digunakan sebagai media edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Berbagai edukasi kesehatan reproduksi remaja dapat kita akses melalui media sosial baik instagram, youtube, facebook, whatsapp, tiktok, dan lainnya. Edukasi kesehatan reproduksi remaja pada platform media sosial banyak diberikan oleh akun media sosial kementerian, organisasi perangkat daerah, institusi pendidikan, organisasi non profit, praktisi kesehatan (dokter spesialis, perawat, bidan, psikolog, dll), dan mahasiswa kesehatan. Penelitian Rahmatika (2019); Herlina & Abidin (2022); Agustina, D, et al (2023); dan Lestari, D, et al (2024) menguatkan bahwa pemanfaatan berbagai jenis media sosial pada edukasi kesehatan reproduksi remaja memberikan dampak yang baik pada pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja.

6. Webinar.

Webinar dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi tentang pendidikan reproduksi pada remaja. Pandemi covid-19 mempopulerkan webinar sebagai salah satu media pembelajaran untuk kalangan berbagai usia. Webinar tentang kesehatan reproduksi umumnya diberikan oleh beberapa Kementerian, organisasi perangkat daerah, rumah sakit, maupun institusi pendidikan.

7. Podcast.

Podcast telah menjadi salah satu media pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Saat ini banyak organisasi perangkat daerah, rumah sakit, organisasi nonprofit, dan universitas yang memiliki podcast edukasi kesehatan maupun edukasi remaja. Podcast tersebut biasanya memberikan edukasi tentang kesehatan secara umum dan kadang memberikan edukasi kesehatan reproduksi remaja.

Pendekatan teknologi digital untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja merupakan suatu pendekatan yang sangat sesuai dengan zamannya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma dalam memberikan wawasan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Edukasi kesehatan reproduksi yang dulunya lebih menitikberatkan pada media yang bersifat konvensional seperti leaflet, booklet, dan brosur, kini bertransformasi ke dimensi digital melalui berbagai platform digital seperti aplikasi android, e-book, e-booklet, media sosial, webinar, podcast, maupun website. Konversi bentuk media pendidikan kesehatan ini membuka peluang dalam memberikan informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan individu remaja, memiliki jangkauan yang luas, memfasilitasi

pembelajaran kolaboratif dan partisipatif, serta dapat diakses dimanapun setiap saat.

Namun demikian pendekatan teknologi digital dalam pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja memiliki banyak tantangan. Hasyim, M (2024) menyampaikan ada dua tantangan penting yang dihadapi edukasi kesehatan online yaitu tantangan kecakapan informasi dan kesenjangan akses teknologi. Informasi yang diberikan di berbagai media teknologi digital yang tersedia belum terjamin kebenarannya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya informasi kesehatan yang tidak tepat adalah kemudahan penyebaran informasi tanpa proses verifikasi yang layak. Hal ini menyebabkan penyebarluasan informasi yang tidak didukung bukti ilmiah yang benar dan informasi palsu (hoaks), sehingga meningkatkan risiko kesalahan pemahaman pada masyarakat. Masyarakat yang terpapar informasi kesehatan yang salah cenderung mengalami ketidakpastian, keresahan, dan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatannya. Kondisi ini menyebabkan ketidaktepatan dalam tata laksana kesehatan mereka seperti penggunaan obat-obatan secara bebas atau mengabaikan perawatan kesehatan yang seharusnya dilakukan.

Untuk mengatasi tantangan keandalan informasi perlu dilakukan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif berbagai pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan literasi kesehatan masyarakat melalui pendidikan dengan fokus meningkatkan kemampuan kritis menilai keakuratan informasi kesehatan; pengawasan konten kesehatan secara ketat oleh pihak terkait; dan kerjasama lintas sektor (pemerintah, institusi kesehatan, platform digital).

Akses teknologi yang tidak merata juga menjadi tantangan pendidikan online. Meskipun teknologi digital telah berkembang dengan baik, namun masih ada masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan akses fisik pada perangkat digital dan infrastruktur internet yang memadai. Untuk mengatasinya diperlukan kolaborasi berbagai pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan investasi infrastruktur di daerah terisolasi, subsidi perangkat digital untuk kelompok rentan, dan literasi digital pada masyarakat yang belum melek digital. Dengan mengatasi dua tantangan tersebut, masyarakat diharapkan menjadi lebih cakap dalam memperoleh wawasan kesehatan yang akurat dan terpercaya sehingga mampu membuat keputusan yang bijak untuk kesehatannya.

Meskipun pendekatan teknologi digital dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sarat dengan tantangan, namun pendekatan ini juga memiliki sejumlah peluang yang besar. Hasyim, M (2024) menyampaikan tentang peluang pendidikan kesehatan online sebagai berikut:

1. Mencapai audiens yang lebih luas. Pemanfaatan platform online memungkinkan informasi kesehatan diakses oleh beragam kelompok masyarakat, mencakup

masyarakat yang memiliki keterbatasan akses fisik maupun yang berdomisili di daerah terpencil.

2. Interaktivitas dan personalisasi konten. Konten dapat disajikan lebih menarik, mudah dimengerti, memungkiankan peningkatan partisipasi audiens, dan dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan individu.
3. Kolaborasi antara profesional kesehatan dan teknologi. Integrasi teknologi digital dan pelayanan kesehatan akan memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat.
4. Pemanfaatan teknologi *wearable*. Penggunaan teknologi *wearable* seperti *smartwatch*, *fitness tracker*, dan lainnya dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan terkini dan memberikan informasi yang benar dan rinci terkait kesehatan personal.

Meskipun sarat dengan tantangan dan peluang, namun pemanfaatan pendekatan teknologi digital dalam pendidikan kesehatan merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan remaja. Pendekatan ini dinilai lebih sinkron dengan kondisi remaja saat ini. Pendekatan teknologi digital menyediakan informasi kesehatan reproduksi yang menarik, informatif, dan meningkatkan partisipasi aktif dari remaja. Kolaborasi berbagai pihak baik pemerintah, praktisi pemberi layanan kesehatan, edukator kesehatan reproduksi, platform digital, dan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyajikan pendidikan kesehatan reproduksi yang akurat, terpercaya, dengan konten yang menarik bagi remaja.

F. Penutup

Remaja merupakan suatu individu yang unik dengan tumbuh kembangnya. Dalam tumbung kembangnya, remaja mengalami berbagai kerentanan yang berkaitan dengan kesehatannya. Salah satunya adalah kerentanan dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Pemberian informasi melalui pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan remaja. Pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik dapat meningkatkan perkembangan sikap yang baik dan positif terhadap kesehatan reproduksi. Sikap yang positif tersebut juga akan memengaruhi perilaku baik remaja yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Dengan demikian, sangat penting mengupayakan pendidikan kesehatan yang sesuai kondisi remaja terkini sebagai generasi Z pada era society 5.0 seperti pada paparan saya di atas.

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja dengan menggunakan pendekatan teknologi digital memenuhi kebutuhan remaja akan informasi kesehatan reproduksi dengan media yang menarik, informatif, dan memungkinkan partisipasi aktif dari remaja. Pendekatan teknologi digital pada pendidikan kesehatan reproduksi remaja

memiliki berbagai tantangan dan peluang. Perlu dilakukan kolaborasi berbagai pihak agar dapat memberikan pendidikan kesehatan yang akurat, terpercaya dan mudah diakses bagi seluruh remaja Indonesia.

Referensi

- Agustina, D., Harahap, J. W., Laoli, A. N., Hasibuan, I. S. M., Rahmawati, N., & Hasibuan, S. R. (2023). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi Kesehatan Reproduksi pada Remaja. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 1784-1793.
- Amallia, A. (2024). Digitalisasi Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan. *Medical Journal of Nusantara*, 3(3), 151-158.
- Artini, B., Widari, N. P., & Safira, R. A. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Fibroadenoma Mammæ (FAM) Terhadap Perilaku Sadari Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan*, 10(2), 23-32.
- Astuti, P. T., Rahmawati, E., & Seftiani, M. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di Kelas Xi Smk Rise Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2016. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 2025-2028.
- Asari, A., Purba, S., Fitri, R., Genua, V., Herlina, E. S., Wijayanto, P. A., ... & Pratasik, S. (2023). Media pembelajaran era digital.
- Cahyani, A. N., Yunus, M., & Ariwinanti, D. (2019). Pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang hubungan seksual pranikah. *Sport Science and Health*, 1(2), 92-101.
- Fidora, I., & Utami, A. S. (2022). Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap tingkat pengetahuan remaja. *Jurnal Keperawatan Abdurrah*, 5(2), 73-82.
- Hasibuan, A. R., Pasaribu, A. F., Alfiah, S., Utami, J. N., & Harahap, N. R. Y. (2024). Peran Pendidikan Kesehatan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pola Hidup Sehat di Era Digital. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(001 Des), 305-318.
- Hasyim, M. (2024). *Tantangan dan Peluang Pendidikan Kesehatan di Era Digital: Membangun Kesadaran Kesehatan Online*. *Oshada*, 1 (2), 16–24.
- Herlina, V., & Abidin, S. (2022). Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Reproduksi Remaja Kota Batam. *Sumber*, 5, 102.
- Lee, J., & Žarnić, Ž. (2024). *The impact of digital technologies on well-being: Main insights from the literature* (No. 29). OECD Publishing.
- Lukmana, C. I., & Yuniarti, F. A. (2017). Gambaran tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi remaja pada siswa SMP di Yogyakarta. *IJNP (Indonesian Journal of Nursing Practices)*, 1(3), 115-123.
- Kebudayaan, K. P. (2017). Apa itu menstruasi: panduan untuk anak perempuan.
- Kemenkes, R. I. (2021). Modul Kesehatan Reproduksi Remaja Luar Sekolah. *Jakarta: Kementerian Kesehatan RI*.
- Kemenkes, R. I. (2022). Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP

- dan Sederajat: Untuk Guru. *Jakarta: Kementerian Kesehatan RI*.
- Kemendikbud, R.I. (2020). Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar. *Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI*.
- Millenia, M. E., Ningsih, F., & Tambunan, L. N. (2022). Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Bahaya Pernikahan Dini: The Effect of Health Education on the Knowledge Level of Youth about the Dangers of Early Marriage. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 7(2), 57-61.
- Mustofa, R. A. B., & Sani, M. (2024). Efektivitas promosi kesehatan melalui media sosial dalam mendorong perilaku hidup sehat pada remaja. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 212-223.
- Nauvan, M.Z, Zamzani, R., Nafais, M., Azmi, Z., & Afwan,M. (2024). Dampak teknologi digital terhadap perilaku sosial generasi muda. *TECHSI-Jurnal Teknik Informatika*, 15(2), 87-95.
- Putri, C. I. S. P., Pradnyawati, L. G., & Sumadewi, K. T. (2022). Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri terhadap Kesehatan Reproduksi pada Siswi SMP Negeri 1 Ubud di Kabupaten Gianyar. *Aesculapius Medical Journal*, 2(3), 137-142.
- Nislawaty, N., Handayani, F., & Ayuni, P. (2022). Gambaran Pengetahuan Remaja Puteri Kelas Vi Tentang Kesehatan Reproduksi Di Sekolah Dasar Inkam Kabupaten Kampar Tahun 2021. *Jurnal Doppler*, 6(1), 120-125.
- Passe, R., Syam, N. F. S., & Khatimah, H. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Perilaku Seksual Remaja di SMA Negeri 4 Palopo: Influence of Reproductive Health Education on the Level of Knowledge About Adolescent Sexual Behavior at 4 Palopo State High School. *Journal of Midwifery Science and Women's Health*, 2(1), 9-14.
- Pratiwi, W. D., & Sudaryanto, A. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seksual Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Keperawatan Malang*, 9(1), 20-27.
- Purnamasari, W. M., Diana, H., & Rosdiani, R. (2022). Pengembangan Aplikasi "Kere Pare" Sebagai Media Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Android. *Media Informasi*, 18(2), 185-191.
- Rahmatika, Q. T. (2019). M Media Sosial Sebagai Strategi Promosi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 39-46.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2021). *Maternity and pediatric nursing*. Wolters Kluwer.
- Rofi'ah, S. (2017). Efektivitas pendidikan kesehatan metode peer group terhadap tingkat pengetahuan dan sikap personal hygiene saat menstruasi. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 2(2), 31-36.

- Rotikan, R., Adam, S., Andryanto, A., Simarmata, J., Murpratiwi, S. I., Saputra, F. H., ... & Sudirman, S. (2024). *Pengantar Teknologi Digital: Web dan Mobile Teknologi*. Yayasan Kita Menulis.
- Saputra, Y. A., Kurnia, A. D., & Aini, N. (2021). Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap upaya remaja untuk menurunkan nyeri saat menstruasi (dismenore primer). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(3), 177-182.
- Setiawati, D., Ulfa, L., & Kridawati, A. (2022). Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Sikap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(04), 322-328.
- Solehati, T., Trisyani, M., & Kosasih, C. E. (2018). Gambaran pengetahuan, sikap, dan keluhan tentang menstruasi diantara remaja putri. *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nursing Journal)*, 4(2), 86-91.
- Susanti, S., Flora, R., & Zulkarnain, M. (2022). Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan. *Scientific Of Environmental Health and Diseases (e-SEHAD)*, 3(2), 143-153.
- UNICEF. Program UNICEF dan UNFPA untuk menangani kesehatan dan hak seksual dan reproduksi. Diakses pada 10 Maret 2025 dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/perindungan-anak/publikasi/program-unicef-unfpa-berani>
- Widayati, R. (2020). Manajemen kebersihan menstruasi dan pencegahan perkawinan anak.
- Women, U. N., & UNICEF. (2018). *International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach*. UNESCO Publishing.
- Yamko, R., Lestari, T., & Muhlis, M. (2022). Gambaran Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas BLUD Kalumpang Kota Ternate. *JURNAL SERAMBI SEHAT*, 15(1), 36-43.
- Yana, E., Prasetyo, D., & Zulvayanti, Z. (2024). UTILIZATION OF DIGITAL-BASED EDUCATIONAL MEDIA TO INCREASE ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH KNOWLEDGE: A LITERATURE REVIEW. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 34(2), 464-479.
- Yulfitria, F., Karningsih, K., Mardeyanti, M., Wahyuni, E. D., & Theresia, E. V. K. (2021). Pendidikan Kesehatan Mempengaruhi Perilaku Remaja Terhadap Pencegahan Keputihan Patologis. *Muhammadiyah Journal of Midwifery*, 2(2), 47-57.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*. VisiMedia.

Profil Penulis



Gusmadewi, AMd. Keb.SKM. M.Kes Lahir di Piladang, 12 Agustus 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Andalasa Padang tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIKes Fort De Kock Bukittinggi dan lulus pada tahun 2017 dan Saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor Kesehatan Masyarakat di Universitas Strada Indonesia di Kediri. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Bidan PTT, Tahun 1998 Bidan di Klinik Bersalin. Kemudian Pada Tahun 2003 Masuk sebagai Asisten Dosen di Akademi Kebidanan Lenggogeni Padang dan Tahun 2007 menjadi Dosen. Tahun 2009 Pindah ke Akademi Kebidanan Sumatera Barat, dimana saat ini sudah berubah menjadi Universitas Sumatera Barat dan saya berhombase sebagai Dosen di Prodi DIII Kebidanan mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Kebidanan Komunitas, Psikologi Dalam Kebidanan dan Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan, Asuhan Kebidanan Masa Persalinan & BBL. Penulis juga mengajar di Prodi S1 Kebidanan dengan Mata Kuliah Masalah dan Gangguan Sistem Reproduksi, Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan, Psikologi Dalam Pelayanan Kebidanan, Profesionalisme dalam Kebidanan serta Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar tentang Kebidanan dan Kesehatan yang dilaksanakan oleh SATU SEHAT Kemenkes dan juga Optimal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: gusmadewi.2019@gmail.com

Motto: "Living your life well"



Indayana Setiawati, S.ST.,M.Kes Lahir di Kudus, 22 Oktober 1989. Pendidikan terakhir S2 Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), lulus tahun 2014. Bekerja sebagai dosen di Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus. Email : indayanasetiawati@gmail.com



Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes Lahir di Musi Banyuasin Sumatra Selatan, 14 Agustus 1991. Penulis memulai Pendidikan Diploma III (DIII) Kebidanan di Akademi Kebidanan Abdurahman Palembang, lulus tahun 2012, pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan Diploma IV jurusan Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta lulus tahun 2014. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia Jakarta. Dengan konsentrasi pengajaran Reproduksi, lulus pada tahun 2017. Penulis memiliki kesibukan lain sebagai Dosen Kebidanan di STIKES Adurahman Palembang, mulai bergabung di STIKES Abdurahman Pada tahun 2017 s/d sekarang. Untuk mewujudkan dosen yang profesional penulis mengikuti berbagai pelatihan dan melakukan Tridarma Perguruan Tinggi, Penulis aktif melakukan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, beberapa karya ilmiah telah penulis hasilkan dan dipublikasikan dalam beberapa jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional tidak terakreditasi.

Korespondensi bisa melalui email penulis: marchatussoleha14@gmail.com

Motto: "Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis."



Anin Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kes. Lahir di Mojokerto, 28 Agustus 1984. Mengawali pendidikan tinggi dari D3 Keperawatan di AKPER Karya Bhakti Nusantara Magelang dan lulus pada tahun 2005, lalu melanjutkan S1 Keperawatan dan Ners di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran yang lulus pada tahun 2008, terakhir melanjutkan S2 Magister Kesehatan di Universitas Airlangga, peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009-2010 sebagai Dosen Keperawatan di STIKES Ngudia Husada Madura, kemudian pada tahun 2011 sebagai Dosen Keperawatan di Prodi Profesi Ners, Fakultas Kesehatan, ITS Kes Insan Cendekia Medika Jombang sampai sekarang. Saat ini, penulis mengampu mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan, Keperawatan Dasar, Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik (KKG), serta Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai pengajar, penulis, penyuluh kesehatan, serta peserta workshop dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aninwijayanti84@gmail.com

Motto: "Beradab, Berilmu, Beramal"



Ana Lestari, S.ST., M.Kes Lahir di Sumbawa, 27 Agustus 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi DIV Bidan Pendidik, Universitas Respati Yogyakarta tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019, penulis bekerja sebagai dosen tetap di STIKES Griya Husada Sumbawa mengampu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, Dasar Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak, Asuhan Kehamilan, keterampilan dasar praktik klinik, ilmu kesehatan masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: analestari674@gmail.com



(Ns.Meining Issuryanti, S.Kep., M.Kep) Lahir di Semarang, 14 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 dan Ners, Universitas Indonesia tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai editor keperawatan pada penerbit EGC, penulis kemudian bekerja di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo sebagai praktisi Keperawatan dari tahun 2006-2024. Pada tahun 2024 hingga sekarang penulis bekerja sebagai Satuan Pengawas Internal RSUD KRT Setjonegoro. Penulis memiliki pengalaman sebagai kepala ruang dari tahun 2018-2024 dan Ketua Komite Keperawatan RSUD KRT Setjonegoro periode 2022-2024. Saat ini penulis juga bekerja sebagai pengajar di Universitas Sains Al Qur'an dengan kepakaran Keperawatan Maternitas. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: meining.issuryanti@gmail.com

Sinopsis Buku

Buku Referensi **Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja** merupakan sumber referensi komprehensif yang dirancang untuk mendukung pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia remaja. Dengan pendekatan ilmiah dan kontekstual, buku ini menyajikan berbagai aspek yang saling berkaitan dalam upaya membangun kesadaran, tanggung jawab, dan perilaku sehat terkait kesehatan reproduksi pada remaja.

Bab pertama mengulas urgensi edukasi reproduksi sejak dini, menyoroti bagaimana pengetahuan yang tepat dapat mencegah risiko perilaku berisiko dan meningkatkan kualitas hidup remaja. Bab kedua membahas peran krusial keluarga sebagai sumber pendidikan pertama dan utama dalam pembentukan nilai serta pemahaman tentang seksualitas. Selanjutnya, bab ketiga menelaah pengaruh pola asuh terhadap pembentukan karakter dan perilaku seksual remaja, serta bagaimana pendekatan yang suportif dapat memberikan dampak positif.

Bab keempat memaparkan strategi berbasis sekolah dalam mendukung pendidikan kesehatan reproduksi, mencakup kurikulum, pelatihan guru, hingga program konseling yang efektif. Bab kelima menyajikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, meliputi aspek anatomi, fisiologi, dan pencegahan penyakit. Terakhir, bab keenam menyoroti pendekatan teknologi digital sebagai sarana inovatif dalam penyampaian informasi reproduksi yang menarik dan mudah diakses oleh remaja masa kini.

Dengan dukungan data, studi kasus, dan pendekatan interdisipliner, buku ini menjadi panduan penting bagi pendidik, tenaga kesehatan, orang tua, dan pemangku kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan informatif bagi remaja.

Buku Referensi Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja merupakan sumber referensi komprehensif yang dirancang untuk mendukung pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia remaja. Dengan pendekatan ilmiah dan kontekstual, buku ini menyajikan berbagai aspek yang saling berkaitan dalam upaya membangun kesadaran, tanggung jawab, dan perilaku sehat terkait kesehatan reproduksi pada remaja.

Bab pertama mengulas urgensi edukasi reproduksi sejak dini, menyoroti bagaimana pengetahuan yang tepat dapat mencegah risiko perilaku berisiko dan meningkatkan kualitas hidup remaja. Bab kedua membahas peran krusial keluarga sebagai sumber pendidikan pertama dan utama dalam pembentukan nilai serta pemahaman tentang seksualitas.

Selanjutnya, bab ketiga menelaah pengaruh pola asuh terhadap pembentukan karakter dan perilaku seksual remaja, serta bagaimana pendekatan yang suportif dapat memberikan dampak positif.

Bab keempat memaparkan strategi berbasis sekolah dalam mendukung pendidikan kesehatan reproduksi, mencakup kurikulum, pelatihan guru, hingga program konseling yang efektif. Bab kelima menyajikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, meliputi aspek anatomi, fisiologi, dan pencegahan penyakit. Terakhir, bab keenam menyoroti pendekatan teknologi digital sebagai sarana inovatif dalam penyampaian informasi reproduksi yang menarik dan mudah diakses oleh remaja masa kini.

Dengan dukungan data, studi kasus, dan pendekatan interdisipliner, buku ini menjadi panduan penting bagi pendidik, tenaga kesehatan, orang tua, dan pemangku kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan informatif bagi remaja.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

ISBN 978-623-10-9551-0



9

786231

095510

